Concepts et définitions pour le TD et la validation

Psychopathologie et psychologie clinique · Développement · Santé · Sociale

Le plan attendu, puis un accès direct aux notions de la liste et aux définitions complètes des quatre cours. Les formulations de révision et les extraits du support sont identifiés. Ce document est une fiche personnelle ; il ne constitue pas un support officiel.

Le plan demandé en page 4

Validation : travail individuel manuscrit sur table, 3 heures, le 15 décembre 2026. Les concepts doivent être choisis à partir du texte et argumentés, avec la définition du cours et les attributs qui la caractérisent.

Partie	Ce qui doit apparaître
Introduction	Présenter le texte : titre, auteur et fonction, source, année. Annoncer le plan.
Développement	Identifier et définir **6 concepts**. Pour chacun : définition du cours, citation précise du texte et explication du lien avec les attributs du concept.
Illustrations	Illustrer **2 des concepts** par une situation de pratique ou, à défaut, un livre, une série, un film ou la vie personnelle. Préciser cette origine et montrer les attributs.
Conclusion	Conclure l'analyse en synthétisant les éléments dégagés.

La trame à répéter pour chaque concept

1. Définir. J'identifie le concept de [nom]. Dans le cours, il est défini comme [définition complète, puis sous-type utile].

2. Citer. Dans le texte, [auteur ou personne] exprime : « [citation exacte et précise] ».

3. Argumenter. Ce passage montre [élément observé]. Il correspond à [attribut de la définition], car [lien expliqué].

Le nom du concept et une citation ne suffisent pas : l'argumentation doit montrer pourquoi la citation étaye cette notion. Ne pas inventer d'auteur pour une définition ni transformer une hypothèse en diagnostic.

Source : présentation de validation du 4 novembre 2026, p. 3-4. Les phrases à compléter ci-dessus sont une aide méthodologique, pas une analyse rédigée du texte du TD.

Utiliser ce recueil rapidement

1. Repérer un passage dans le texte. 2. Chercher le terme dans la liste contrôlée ou l'index. 3. Lire la définition entière et les distinctions. 4. Vérifier quels attributs sont réellement présents. 5. Choisir les six notions les mieux étayées.

Repère	Contenu
P	301 définitions de psychopathologie et de psychologie clinique.
D	222 définitions du développement, dont 20 nouvelles entrées et 8 précisions sur l'attachement désormais présentes dans la fiche.
H	79 définitions de psychologie de la santé.
S	137 définitions de psychologie sociale, plus 5 précisions de vocabulaire.
X et Y	82 passages complémentaires des supports de santé et de sociale, pour conserver les notions qui ne possédaient pas d'entrée distincte dans les lexiques.

Un même mot peut avoir plusieurs sens selon le cours : les entrées restent séparées. Par exemple, l'affiliation sociale n'est pas identique à l'affiliation comme défense ; l'étayage de la pulsion et l'aide de l'adulte dans l'apprentissage ont des emplois différents.

Validation et entraînement : deux consignes à distinguer

Validation (p. 4) : six concepts et deux illustrations. **TD 2 (p. 14) :** analyse de texte et illustration d'un concept par une expérience professionnelle ou de stage, à compléter pendant le stage. Le TD 1 est un jeu de rôle sur les mécanismes de défense et le coping ; chaque concept mis en scène doit être défini pour le débriefing.

Documents annoncés comme autorisés

La page 5 autorise au semestre 1 les supports ecampus imprimés, leurs annotations personnelles et les fiches personnelles manuscrites ou tapuscrites. Elle exclut les livres, les photocopies d'ouvrages et les documents extérieurs aux supports de cours. Cette fiche reprend les cours déjà travaillés ; elle ne remplace pas les règles données par l'équipe pédagogique.

Ce que les vérifications ont ajouté

Les 57 rubriques de la liste fournie disposent d'un renvoi. Les précisions ajoutées concernent surtout la réciprocité et les styles d'attachement chez l'adulte, l'attachement symbolique et le vieillissement, ainsi que certains termes de communication. Ces notions étaient parfois expliquées dans le cours ou l'oral sans disposer d'une entrée autonome. La nouvelle confrontation au support officiel complète surtout les lectures du normal et du pathologique, les styles éducatifs, la cohésion familiale, l'idéologie et certains repères identitaires.

Le développement a été confronté aux 35 pages du support officiel de N. Khatir (2026). Les définitions antérieures et les apports oraux utiles sont conservés ; 20 entrées ont été ajoutées. Les extraits littéraux du support sont signalés avec leur page. Les autres textes sont des formulations de révision, même lorsqu'un repère dans le support est indiqué. La mention « fiche antérieure p. » conserve la provenance des premières définitions et ne renvoie pas à la nouvelle pagination.

Accès : liste de concepts contrôlée · mécanismes de défense · distinctions utiles · index alphabétique

Index alphabétique

Psychologie clinique : notions et défenses

Correspondance avec la page 1 de la liste de concepts fournie. Les renvois pointent vers les définitions complètes du présent recueil.

Notion demandée	Où la retrouver
Inconscient	P097 p. 14
Talking cure, méthode cathartique, abréaction	P063 p. 12 · P060 p. 12 · P062 p. 12
Névrose et hystérie	P165 p. 18 · P052 p. 11
Symptôme	P201 p. 20
Pulsion, zone érogène, affect, représentation	P082 p. 13 · P088 p. 13 · P089 p. 13 · P090 p. 13
Inconscient, préconscient, perception-conscience	P097 p. 14 · P096 p. 14 · P095 p. 14
Ça, Moi, Surmoi, culpabilité, Idéal du Moi, honte	P101 p. 14 · P102 p. 14 · P103 p. 14 · P105 p. 14 · P104 p. 14 · P106 p. 14
Plaisir, réalité, compulsion de répétition	P109 p. 15 · P110 p. 15 · P117 p. 15
Libido objectale et narcissique, investissement libidinal	P113 p. 15 · P116 p. 15 · P115 p. 15 · P114 p. 15
Censure, pare-excitation, traumatisme	P098 p. 14 · P099 p. 14 · P100 p. 14
Conflit psychique	P119 p. 15
Étayage	P123 p. 15 · D069 p. 30
Sexualité infantile et auto-érotisme	P128 p. 16 · P129 p. 16
Stades oral, anal, phallique et complexe d'Œdipe	P137 p. 16 · P141 p. 16 · P145 p. 17 · P148 p. 17
Latence et puberté	P151 p. 17 · P291 p. 25 · D145 p. 33
Narcissisme	P130 p. 16
Angoisse : morcellement, perte d'objet, castration	P155 p. 17 · P158 p. 17 · P159 p. 17 · P160 p. 18
Mécanismes de défense : définition générale et liste complète	Voir les deux listes contrôlées de mécanismes
Transfert	P195 p. 20
Attachement, besoin primaire de proximité	D070 p. 30 · D200 p. 36 Précision ajoutée pour cette fiche
Carence affective, dépression anaclitique, hospitalisme	D083 p. 31 · D086 p. 31 · D087 p. 31
Séparation : protestation, désespoir, détachement	D090 p. 31
Empreinte et besoin primaire de contact	D085 p. 31 · D201 p. 36 Précision ajoutée pour cette fiche
Winnicott : holding, handling, object-presenting, préoccupation maternelle primaire	D091 p. 31 · D092 p. 31 · D093 p. 31 · D021 p. 27

Index alphabétique

Attachement au cours de la vie

Correspondance avec la page 2 de la liste de concepts fournie. Les renvois pointent vers les définitions complètes du présent recueil.

Notion demandée	Où la retrouver
Comportements d’attachement	D071 p. 30
Figure d’attachement, caregiver, caregiving	D072 p. 30 · D073 p. 30 · D074 p. 30
Proximité et base de sécurité	D202 p. 36 · D077 p. 30 Précision ajoutée pour cette fiche
MIO et partenariat corrigé quant au but	D079 p. 30 · D080 p. 30
Relation réciproque et style d’attachement chez l’adulte	D195 p. 35 · D196 p. 36 Précision ajoutée pour cette fiche
Attachement symbolique, vieillissement et personne démente	D197 p. 36 · D198 p. 36 · D199 p. 36 Précision ajoutée pour cette fiche
Attachement sécure, évitant, ambivalent, désorganisé	D099 p. 31 · D100 p. 31 · D101 p. 31 · D102 p. 31
Résilience	H035 p. 40 · H036 p. 40 · H037 p. 40

Index alphabétique

Psychologie sociale : relations et communication

Correspondance avec la page 3 de la liste de concepts fournie. Les renvois pointent vers les définitions complètes du présent recueil.

Notion demandée	Où la retrouver
Lien social et affiliation	S002 p. 44 · S003 p. 44
Attachement et socialisation	S010 p. 44 · S011 p. 44
Identité sociale, Soi, continuité, identité publique et de choix	S018 p. 44 · S019 p. 45 · S022 p. 45 · S026 p. 45 · S027 p. 45
Estime de soi et contrôle interne/externe	S023 p. 45 · S025 p. 45
Présentation de soi, conscience intime et publique	S028 p. 45 · S029 p. 45 · S030 p. 45
Appartenance sociale	S032 p. 45
Implication sociale : identité achevée, forclose, diffuse, moratoire	S033 p. 45 · S034 p. 45 · S035 p. 45 · S037 p. 46 · S038 p. 46 · S036 p. 45
Identification, référent identitaire, comparaison sociale	S039 p. 46 · S040 p. 46 · S041 p. 46
Groupe restreint	S042 p. 46
Normalisation	S046 p. 46
Norme, valeur, statut, rôle	S050 p. 46 · S049 p. 46 · S051 p. 46 · S052 p. 46
Leadership	S056 p. 47
Influence, conformisme, complaisance, identification, intériorisation	S062 p. 47 · S064 p. 47 · S065 p. 47 · S066 p. 47 · S067 p. 47
Obéissance	S068 p. 47
Non-conformité : réactance, déviance, marginalité	S072 p. 47 · S073 p. 47 · S078 p. 48
Communication	S079 p. 48
Émetteur, récepteur, message, code, codage, décodage, bruit, répertoire	S088 p. 48 · S089 p. 48 · S138 p. 51 · S139 p. 51 · S081 p. 48 · S083 p. 48 · S084 p. 48 · S085 p. 48 Précision ajoutée pour cette fiche
Feedback	S086 p. 48
Canal et contexte	S090 p. 48 · S091 p. 48
Communication persuasive : crédibilité et attractivité	S098 p. 49 · S096 p. 49 · S097 p. 49
Non verbal : territoire, posture, image corporelle, visage, ton	S101 p. 49 · S140 p. 51 · S103 p. 49 · S141 p. 51 · S104 p. 49 · S092 p. 48 Précision ajoutée pour cette fiche
Communication paradoxale	S142 p. 51 · S117 p. 50 · S118 p. 50 Précision ajoutée pour cette fiche
Structure, flux, réseau	S119 p. 50 · S122 p. 50 · S120 p. 50
Perception sociale	S124 p. 50
Préjugé, stéréotype, catégorisation	S127 p. 50 · S126 p. 50 · S125 p. 50

Index alphabétique

Tous les mécanismes de défense de la liste

Définition générale : P169 p. 18 et H056 p. 41. Les 24 entrées détaillées en psychopathologie sont présentes ci-dessous. Les deux clivages et l'identification à l'agresseur sont individualisés.

Psychopathologie : 24 mécanismes	Définition complète
Refoulement	P170 p. 18
Déplacement	P172 p. 18
Isolation	P173 p. 18
Annulation rétroactive	P174 p. 18
Formation réactionnelle	P175 p. 18
Dénégation	P176 p. 18
Déni	P177 p. 19
Projection	P178 p. 19
Clivage du Moi	P179 p. 19
Clivage de l'objet	P180 p. 19
Renversement en son contraire	P181 p. 19
Retournement contre soi	P182 p. 19
Introjection	P183 p. 19
Identification	P184 p. 19
Identification à l'agresseur	P185 p. 19
Idéalisation	P186 p. 19
Régression	P187 p. 19
Activisme	P188 p. 19
Rationalisation	P189 p. 19
Intellectualisation	P190 p. 19
Sublimation	P191 p. 19
Humour	P192 p. 19
Altruisme	P193 p. 20
Mise à l'écart	P194 p. 20

Index alphabétique

Défenses en psychologie de la santé

Le cours de santé apporte 16 formes ou variantes détaillées, dont la maîtrise, le retrait apathique, la projection agressive, la combativité et l'affiliation. Les formulations peuvent être complémentaires de celles de psychopathologie.

Santé : 16 formes ou variantes	Définition complète
Déni	H057 p. 41
Projection	H058 p. 41
Projection agressive	H059 p. 41
Régression	H060 p. 41
Rationalisation	H061 p. 41
Refoulement	H062 p. 41
Déplacement	H063 p. 41
Isolation	H064 p. 42
Dénégation	H065 p. 42
Maîtrise	H066 p. 42
Retrait apathique	H067 p. 42
Activisme	H068 p. 42
Combativité	H069 p. 42
Affiliation - mécanisme de défense	H070 p. 42
Humour - mécanisme de défense	H071 p. 42
Sublimation	H072 p. 42

Ces catégories appartiennent aux modèles présentés dans les cours. La présence d'un mécanisme ne permet pas, à elle seule, d'affirmer une structure ou un diagnostic. La mise à l'écart est explicitement volontaire dans la liste de psychopathologie.

Index alphabétique

Distinctions utiles avant de choisir un concept

À distinguer	Repère pour argumenter
Déni / dénégation	Déni : réalité perçue mais non reconnue psychiquement. Dénégation : pensée, désir ou sentiment formulé, puis rejeté comme sien. Un refus ou une négation grammaticale ne suffit pas.
Défense / coping	Les défenses sont principalement inconscientes ; le coping correspond aux efforts pour gérer des exigences stressantes. Les deux peuvent coexister. La mise à l'écart est volontaire dans la liste du cours.
Émotion / coping centré sur l'émotion	Être triste ou anxieux n'est pas déjà une stratégie. Rechercher les efforts de régulation. Le coping centré sur l'émotion n'est pas toujours inefficace.
Soutien reçu / perçu / réseau	Réseau : personnes en relation. Reçu : aides effectives. Perçu : appréciation de la disponibilité et de la satisfaction. Une famille présente ne prouve pas un soutien perçu satisfaisant.
Attachement / affiliation	L'attachement recherche une sécurité auprès de figures particulières. L'affiliation sociale concerne le lien et l'appartenance. L'affiliation comme défense désigne la recherche d'aide face à l'angoisse.
Stéréotype / préjugé / discrimination	Croyance simplifiée à propos d'un groupe / attitude évaluative / conduite ou traitement. Il faut distinguer ce qui est pensé, ressenti et fait.
Image corporelle / image du corps	Le chapitre de communication vise notamment l'apparence donnée à voir ; l'image du corps concerne la représentation subjective et affective de son corps.
Une hypothèse / un diagnostic	Un signe isolé, une angoisse de morcellement ou une conduite de retrait ne prouvent pas un trouble. Relier les observations au contexte et garder les limites de l'interprétation.
Résilience / disparition de la souffrance	La résilience décrit un processus de construction ou de réorganisation malgré l'adversité. Elle ne se déduit pas d'une apparence forte ni d'une absence de plainte.
Réactions à l'annonce / séquence obligatoire	Les réactions du schéma du cours ne constituent pas une suite universelle. La « dépression » dans ce schéma n'est pas, à elle seule, un diagnostic d'épisode dépressif.

Index alphabétique

Psychopathologie et psychologie clinique

P001 - Psychopathologie (fiche p. 18)
Discipline qui étudie les troubles et la souffrance psychiques. Piéron en souligne la description, la classification, les mécanismes et l'évolution. Pedinielli la situe comme une sous-discipline de la psychologie ayant pour objet l'évaluation, le diagnostic, l'aide et le traitement de la souffrance psychique, quelle que soit son origine. Ménéchal la présente comme la science de la souffrance psychique ; Samacher étend sa définition à l'étude des maladies mentales, du fonctionnement mental anormal et des conduites pathologiques. Son objet est la souffrance psychique, sa méthode clinique ou expérimentale, et son champ est proche de celui de la psychiatrie, avec un accent sur la connaissance et la compréhension.

P002 - Souffrance psychique (fiche p. 18)
Expérience pénible concernant la vie mentale et affective. Elle peut être exprimée par la personne ou repérée par son entourage, et s'apprécie avec son intensité, sa durée, son contexte et son retentissement.

P003 - Psychologie clinique (fiche p. 18)
Démarche de compréhension et d'étude du sujet dans sa singularité et dans sa situation. Son champ ne se limite pas aux maladies mentales.

P004 - Psychiatrie (fiche p. 18)
Discipline médicale qui prend en charge les troubles psychiques, avec des dimensions diagnostiques, thérapeutiques, préventives et de réadaptation.

P005 - Normalité (fiche p. 18)
Repère relatif à des normes individuelles, sociales et culturelles. Elle ne se confond ni avec la fréquence statistique d'un comportement ni avec l'absence de toute souffrance.

P006 - Pathologique (fiche p. 18)
Ce qui relève d'un trouble ou d'un processus morbide, apprécié à partir d'un ensemble de manifestations, du vécu, du contexte et du retentissement ; aucun critère isolé ne suffit systématiquement.

P007 - Pathologisation du normal (fiche p. 18)
Attribution injustifiée d'un caractère maladif à une variation ordinaire, comme assimiler toute tristesse à une dépression.

P008 - Normalisation du pathologique (fiche p. 18)
Banalisation d'une manifestation préoccupante, dont la souffrance ou le danger mérite pourtant une évaluation.

P009 - Déviance sociale (fiche p. 18)
Écart à une norme sociale ou individuelle. Sa signification dépend du contexte historique et culturel ; elle ne constitue pas en soi un diagnostic.

P010 - Handicap et limitation (fiche p. 18)
Limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le support l'utilise comme repère de retentissement, à replacer dans l'environnement réel.

P011 - Contact avec la réalité (fiche p. 19)
Capacité à situer ses perceptions, pensées et expériences par rapport au monde partagé, en tenant compte du contexte culturel et de l'adaptation concrète.

P012 - Comportement désadapté (fiche p. 19)
Conduite qui ne permet pas de répondre de façon adéquate à la situation ou entraîne des difficultés de fonctionnement. Son appréciation nécessite le contexte.

P013 - Anosognosie (fiche p. 19)
Méconnaissance par la personne de l'existence de son trouble. Elle ne se confond pas avec un mensonge volontaire ni, automatiquement, avec le déni psychanalytique.

P014 - Pathoplasticité (fiche p. 19)
Variation de l'expression d'un trouble selon le sujet, l'observateur, la culture, le lieu, l'époque et les situations dans lesquelles il apparaît.

P015 - Épistémologie (fiche p. 19)
Réflexion sur les connaissances scientifiques, leurs méthodes et leurs cadres théoriques. Dans le cours, elle aide à comprendre pourquoi des approches lisent différemment un même trouble.

P016 - Diachronie (fiche p. 19)
Étude d'un phénomène dans son évolution temporelle ; elle s'oppose à une lecture limitée à un seul moment.

P017 - Épidémiologie (fiche p. 19)
Étude de la fréquence et de la répartition des phénomènes de santé dans des populations et des facteurs qui leur sont associés.

P018 - Étude longitudinale (fiche p. 19)
Étude suivant des sujets ou des phénomènes au fil du temps pour observer leur évolution.

P019 - Étiologie (fiche p. 19)
Étude des causes d'une maladie ou ensemble des facteurs auxquels sa survenue est rapportée.

Index alphabétique

P020 - Psychogenèse (fiche p. 19)

Hypothèse selon laquelle les facteurs et mécanismes à l'origine des manifestations psychopathologiques sont psychologiques et fonctionnels, c'est-à-dire sans lésion ni inflammation structurale dans la formulation du support. La psychanalyse relie ainsi le symptôme à la vie psychique inconsciente et à son sens. Il s'agit d'une hypothèse étiologique ; elle ne permet pas de déclarer une origine psychique par le seul constat d'un examen sans anomalie.

P021 - Organogenèse (fiche p. 19)

Hypothèse rapportant les troubles à des facteurs organiques, structurels ou fonctionnels, notamment cérébraux, neurochimiques ou génétiques.

P022 - Sociogenèse (fiche p. 19)

Ensemble des facteurs sociaux susceptibles de favoriser ou de contribuer à la survenue de troubles psychiques ; elle ne signifie pas qu'un contexte détermine à lui seul le devenir individuel.

P023 - Modèle bio-psycho-social (fiche p. 19)

Cadre de compréhension articulant dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans leurs interactions, plutôt que recherchant une cause unique.

P024 - Prophylaxie (fiche p. 19)

Ensemble des mesures destinées à prévenir la survenue ou la diffusion d'une maladie ; le support la cite parmi les dimensions du champ psychiatrique.

P025 - Réadaptation (fiche p. 19)

Processus visant à soutenir le fonctionnement, l'autonomie et la participation à la vie ordinaire en tenant compte des difficultés et des ressources.

P026 - Psychothérapie (fiche p. 20)

Démarche thérapeutique utilisant des moyens psychologiques et une relation structurée pour travailler une souffrance ou des difficultés psychiques ; ses objectifs et méthodes dépendent du cadre choisi.

P027 - Approche personnaliste (fiche p. 20)

Dans le classement du support, approche centrée sur le sujet et les facteurs individuels ; elle comprend notamment les lectures psychanalytique, biologique et cognitive.

P028 - Approche environnementaliste (fiche p. 20)

Approche privilégiant l'environnement du sujet : situation-problème, contexte, culture et facteurs situationnels. Le support y classe les psychothérapies comportementales, ethnopsychologiques et sociales.

P029 - Approche interactionniste (fiche p. 20)

Approche tenant compte des contributions de la personne et de la situation, mais aussi de leur interaction : relations et influences réciproques entre personne et contexte. Le support y situe les psychothérapies systémiques et écosystémiques.

P030 - Approche syncrétique (fiche p. 20)

Dans le support, démarche qui va au-delà de la simple juxtaposition de techniques pour articuler plusieurs approches dans un modèle de causalité multiple et bidirectionnelle. Les TCC combinent la démarche comportementale et les stratégies cognitives, avec une place pour les émotions.

P031 - Approche biologique (fiche p. 20)

Lecture recherchant les éléments organiques des troubles et les modifications du fonctionnement du système nerveux susceptibles d'y contribuer.

P032 - Béhaviorisme (fiche p. 20)

Approche centrée sur les comportements observables et leurs lois d'apprentissage, en particulier les conditions de leur acquisition et de leur maintien.

P033 - Conditionnement classique ou répondant (fiche p. 20)

Apprentissage par association de stimuli, par lequel un stimulus initialement neutre peut déclencher une réponse ; l'exemple classique est celui du signal associé à la salivation.

P034 - Conditionnement opérant ou instrumental (fiche p. 20)

Apprentissage dans lequel les conséquences d'un comportement influencent sa probabilité de répétition ; il concerne le comportement et ses effets dans l'environnement.

P035 - Apprentissage vicariant (fiche p. 20)

Apprentissage reposant sur l'observation des conduites d'un modèle et de leurs conséquences, sans devoir faire soi-même toute l'expérience.

P036 - Renforcement (fiche p. 21)

Conséquence qui augmente la probabilité de répétition d'un comportement dans l'apprentissage opérant ; le terme décrit une fonction, pas uniquement une récompense agréable.

P037 - Extinction (fiche p. 21)

Affaiblissement d'une réponse apprise lorsque les conditions qui la maintenaient cessent ; l'oral l'évoque à propos des conséquences accordées à une conduite.

Index alphabétique

P038 - Approche systémique (fiche p. 21)

Lecture considérant la personne dans les systèmes auxquels elle appartient et les interactions circulaires qui participent au fonctionnement et à la souffrance.

P039 - Système relationnel (fiche p. 21)

Ensemble d'éléments en interaction, par exemple une famille, dont les règles et les échanges influencent les membres et sont influencés par eux.

P040 - Causalité circulaire (fiche p. 21)

Manière de comprendre des influences réciproques : chaque réaction agit sur les autres et contribue à entretenir ou modifier le fonctionnement du système.

P041 - Patient désigné (fiche p. 21)

Dans le modèle systémique, personne portant le symptôme à travers lequel se manifeste une difficulté relationnelle du système ; ce terme ne signifie pas qu'elle serait volontairement malade.

P042 - Métacommunication (fiche p. 21)

Communication portant sur la manière dont on communique : implicites, règles, malentendus, place du verbal et du non-verbal.

P043 - Thérapies cognitivo-comportementales · TCC (fiche p. 21)

Approches associant l'histoire des apprentissages à la manière subjective de vivre les situations : pensées, croyances, schémas, émotions et comportements. Elles visent à modifier les fonctionnements inadaptés ou, lorsque cela n'est pas possible, à en développer l'acceptation. Le travail comprend analyse du problème dans l'ici et maintenant, objectifs et moyens définis avec le patient, exercices adaptés en séance et entre les séances, puis évaluation des progrès et de la poursuite du traitement.

P044 - Cognition (fiche p. 21)

Ensemble des opérations par lesquelles le sujet traite l'information, se représente les situations, pense, juge et interprète.

P045 - Schéma cognitif (fiche p. 21)

Structure issue des expériences et connaissances qui organise les interprétations et oriente pensées, émotions et comportements, parfois sans que le sujet en ait conscience.

P046 - Biais cognitif (fiche p. 21)

Orientation ou déformation du traitement de l'information qui influence l'interprétation d'une situation ; le cours l'évoque lorsqu'elle contribue à maintenir la souffrance.

P047 - Inconscient cognitif (fiche p. 21)

Processus cognitifs se déroulant hors de la conscience immédiate. Il ne correspond pas nécessairement à des contenus refoulés en conflit avec des interdits.

P048 - Rumination (fiche p. 21)

Reprise répétitive de pensées autour d'une difficulté ou d'une inquiétude, susceptible d'entretenir la souffrance sans aboutir à une résolution.

P049 - Évitement (fiche p. 21)

Conduite consistant à se tenir à distance d'une situation ou d'un vécu redouté ; elle peut participer au maintien d'un apprentissage problématique.

P050 - Alliance thérapeutique (fiche p. 21)

Qualité de la collaboration et du lien de confiance entre personne soignée et professionnel autour du travail de soin ; l'oral la présente comme un facteur relationnel transversal.

P051 - Psychanalyse (fiche p. 22)

À la fois procédé d'investigation du psychisme inconscient, méthode de traitement et théorie de la vie psychique issue de cette expérience.

P052 - Hystérie (fiche p. 22)

Notion historique désignant des manifestations fonctionnelles diverses, notamment corporelles, interprétées dans le cours en relation avec des conflits psychiques et la conversion. Elle ne se confond pas avec une simulation.

P053 - Conversion (fiche p. 22)

Dans le modèle psychanalytique du cours, transposition corporelle d'un conflit ou d'un affect, donnant une expression somatique au symptôme ; cette lecture ne se déduit pas de la seule absence de lésion retrouvée.

P054 - Atteinte fonctionnelle (fiche p. 22)

Perturbation d'une fonction sans lésion structurale explicative identifiée dans la présentation considérée ; le trouble est vécu réellement et demande une évaluation clinique.

P055 - Corps fantasmatique (fiche p. 22)

Corps tel qu'il est représenté et investi psychiquement, avec une organisation subjective qui ne se confond pas avec le découpage anatomique.

P056 - Belle indifférence (fiche p. 22)

Expression historique de Charcot désignant une apparente absence d'inquiétude devant certains symptômes ; elle n'est ni une preuve de simulation ni un critère suffisant de diagnostic.

Index alphabétique

P057 - Prodrome (fiche p. 22)
Manifestation annonciatrice précédant un tableau clinique ; dans la description de Charcot, les prodromes précèdent les quatre périodes de la crise.

P058 - Clownisme (fiche p. 22)
Terme historique désignant les contorsions et attitudes corporelles spectaculaires de la deuxième période de la grande crise décrite par Charcot.

P059 - Suggestion post-hypnotique (fiche p. 22)
Consigne donnée dans un état hypnotique pouvant influencer ensuite une conduite sans que le sujet se rappelle consciemment la consigne ; le cours l'utilise pour introduire des processus psychiques non conscients.

P060 - Méthode cathartique (fiche p. 22)
Méthode historique associant la mise en récit d'événements pénibles à la libération des affects qui leur restent attachés, notamment dans les travaux de Breuer et Freud.

P061 - Catharsis (fiche p. 22)
Décharge ou libération émotionnelle ; dans le contexte historique du cours, elle désigne l'apaisement recherché par l'expression d'affects jusque-là retenus.

P062 - Abréaction (fiche p. 22)
Décharge émotionnelle d'un affect lié à un événement pénible ou traumatique, obtenue notamment lors de son évocation dans la méthode cathartique.

P063 - Talking cure (fiche p. 22)
Expression associée à Anna O. désignant la cure par la parole, dans laquelle la mise en récit participe au travail thérapeutique.

P064 - Associations libres (fiche p. 23)
Procédé invitant le sujet à exprimer ce qui lui vient à l'esprit en tentant de limiter la sélection volontaire, afin d'explorer les liens entre ses contenus psychiques.

P065 - Réminiscence (fiche p. 23)
Retour d'un souvenir ou d'une trace du passé ; le récit historique de l'hystérie insiste sur l'action persistante de souvenirs chargés d'affects.

P066 - Théorie de la séduction (fiche p. 23)
Première hypothèse étiologique freudienne reliant certaines névroses au souvenir de scènes sexuelles traumatiques précoces ; le terme historique ne signifie pas un consentement de l'enfant.

P067 - Fantasme (fiche p. 23)
Scénario ou représentation psychique exprimant des désirs et leurs conflits, conscient ou inconscient. Il appartient à la réalité psychique et ne démontre pas à lui seul la réalité matérielle d'un événement.

P068 - Réalité psychique (fiche p. 23)
Valeur et effets qu'ont pour le sujet ses représentations, désirs et fantasmes, indépendamment de leur correspondance exacte avec un événement extérieur.

P069 - Théorie du fantasme (fiche p. 23)
Hypothèse reconnaissant le rôle des désirs et scénarios psychiques, notamment œdipiens, dans certains conflits ; le cours précise qu'elle n'efface pas la réalité des traumatismes.

P070 - Formation de compromis (fiche p. 23)
Production psychique qui exprime de façon transformée des forces opposées, notamment un désir et une défense ; rêve, lapsus et certains symptômes en sont des exemples dans le modèle.

P071 - Contenu latent (fiche p. 23)
Pensées, désirs et associations sous-jacents au rêve, distingués de son récit manifeste dans la théorie psychanalytique.

P072 - Contenu manifeste (fiche p. 23)
Rêve tel qu'il est vécu et raconté au réveil, après transformation de ses contenus sous-jacents.

P073 - Reste diurne (fiche p. 23)
Élément d'une journée qui peut réactiver des contenus psychiques et fournir du matériau au rêve.

P074 - Condensation (fiche p. 23)
Processus réunissant plusieurs représentations ou chaînes associatives dans un même élément, par exemple un personnage de rêve combinant plusieurs personnes.

P075 - Figuration (fiche p. 23)
Transformation de pensées en images ou en formes représentables dans le rêve, présentée à l'oral comme un des procédés du travail onirique.

P076 - Élaboration secondaire (fiche p. 23)
Travail qui contribue à organiser les éléments du rêve en un récit présentant une certaine cohérence.

P077 - Lapsus (fiche p. 23)
Erreur de parole ou d'expression interprétable, dans la lecture psychanalytique, comme une manifestation transformée d'un contenu psychique ; son sens ne se conclut pas automatiquement d'une erreur isolée.

Index alphabétique

P078 - Acte manqué (fiche p. 23)

Action ou omission qui échoue au regard de l'intention consciente et peut exprimer, selon le modèle, une tendance inconsciente ; son interprétation nécessite le contexte du sujet.

P079 - Métapsychologie (fiche p. 24)

Partie théorique de la psychanalyse décrivant les processus psychiques selon les points de vue topique, économique et dynamique.

P080 - Appareil psychique (fiche p. 24)

Modèle ou fiction représentant un ensemble organisé de systèmes ou d'instances aux fonctions différentes, qui se constitue progressivement en transmettant et transformant les excitations internes et externes. Son travail est de les maîtriser, réduire ou transformer et de maintenir leur niveau aussi bas que possible, par protection contre l'externe et défense ou décharge de l'interne. Il ne désigne pas un organe anatomique.

P081 - Excitation (fiche p. 24)

Stimulation interne ou externe qui impose au psychisme un travail de maîtrise, de transformation ou de décharge dans le modèle du cours.

P082 - Pulsion (fiche p. 24)

Poussée liée à une source somatique interne, imposant un travail à l'appareil psychique. Elle correspond dans le cours à un afflux constant d'excitations internes auquel on ne peut se soustraire comme à une stimulation extérieure. Elle se caractérise par poussée, source, but et objet. Contrairement à l'instinct décrit dans le support, elle reste relativement indéterminée quant aux conduites, aux buts intermédiaires et aux objets procurant satisfaction, qui dépendent de l'histoire du sujet. Affect et représentation en sont les représentants psychiques.

P083 - Poussée pulsionnelle (fiche p. 24)

Aspect moteur et charge énergétique de la pulsion, c'est-à-dire sa pression et ce qui pousse à agir.

P084 - Source pulsionnelle (fiche p. 24)

Processus somatique, dans un organe ou une zone du corps, à l'origine de l'excitation représentée psychiquement par la pulsion.

P085 - But pulsionnel (fiche p. 24)

Satisfaction finale obtenue, dans le modèle, par suppression de l'état d'excitation à la source pulsionnelle, disparition de la tension ou décharge. Le terme peut également désigner les voies, activités ou mécanismes intermédiaires permettant d'atteindre cette satisfaction ; ces buts peuvent être multiples et parcellaires.

P086 - Objet pulsionnel (fiche p. 24)

Ce par quoi ou en quoi la pulsion peut obtenir satisfaction : personne entière, partie de personne, objet réel ou fantasmatique ; il est contingent et dépend de l'histoire.

P087 - Instinct (fiche p. 25)

Dans la distinction du support, comportement animal fixé par l'hérédité, caractéristique d'une espèce, relativement stable dans son déroulement, adapté à son objet et variant peu entre individus. Il suit une séquence temporelle peu susceptible de bouleversement et paraît répondre à une finalité. La pulsion est décrite, à l'inverse, comme plus indéterminée quant aux comportements, objets et buts.

P088 - Zone érogène (fiche p. 25)

Région corporelle pouvant être source de plaisir dans la théorie, notamment les zones cutanéo-muqueuses et d'échange avec l'entourage ; la notion est ensuite étendue au corps entier.

P089 - Affect (fiche p. 25)

Qualité de l'énergie associée à la pulsion, positive ou négative. Le terme peut désigner tout état affectif agréable ou désagréable, vague ou précis, sous forme d'une décharge massive et ponctuelle ou d'une tonalité générale durable, comme l'humeur. Affect et représentation constituent dans le cours les deux représentants psychiques de la pulsion.

P090 - Représentation (fiche p. 25)

Contenu de pensée, idée de quelque chose ou image, s'appuyant sur des traces mnésiques. Le support distingue représentations de mots, principalement acoustico-verbales, et représentations de choses, principalement imagées. Avec l'affect, elle constitue un représentant psychique de la pulsion ; dans le refoulement névrotique, c'est la représentation conflictuelle qui est maintenue dans l'inconscient.

P091 - Représentation de mot (fiche p. 25)

Représentation verbale, principalement acoustico-verbale dans le support, distinguée des représentations de choses.

P092 - Représentation de chose (fiche p. 25)

Représentation essentiellement imagée ou sensorielle d'un objet ou d'une expérience, distinguée de sa formulation verbale.

P093 - Trace mnésique (fiche p. 25)

Trace conservée d'une expérience, servant de support au souvenir et aux représentations dans le modèle psychique.

Index alphabétique

P094 - Point de vue topique (fiche p. 25)

Lecture de l'appareil psychique selon des systèmes ou instances ayant des fonctions et règles différentes, sans supposer de localisation anatomique.

P095 - Perception-conscience · Pc-Cs (fiche p. 25)

Système situé à la périphérie de l'appareil psychique dans la première topique. Il reçoit les informations extérieures et les sensations internes de plaisir et de déplaisir ; il est le siège des processus de pensée consciente, de l'accès aux souvenirs pour raisonner et du contrôle moteur. Aucune trace durable ne s'y inscrit dans ce modèle ; l'énergie y est mobile, permettant notamment l'attention portée à différents éléments.

P096 - Préconscient · Pcs (fiche p. 25)

Système situé entre l'inconscient et la perception-conscience. Ses contenus, notamment les représentations de mots, sont absents du champ actuel de la conscience mais peuvent devenir conscients assez facilement. L'énergie y est plutôt liée. L'oral l'illustre par un savoir disponible, comme des tables de multiplication que l'on rappelle pour effectuer un calcul.

P097 - Inconscient · Ics (fiche p. 26)

Partie la plus archaïque de l'appareil psychique, proche des sources pulsionnelles. Ses contenus comprennent notamment les représentants de pulsions et représentations de choses refoulés, dont des désirs infantiles, qui restent actifs et cherchent à revenir dans la conscience et l'action, par exemple dans le rêve, le lapsus ou le symptôme. Dans cette théorie, son fonctionnement comporte absence de contradiction, de négation, de doute et de degré dans la certitude, atemporalité et indifférence à la réalité extérieure, remplacée par la réalité psychique. L'énergie y circule librement.

P098 - Censure (fiche p. 26)

Fonction figurée comme une barrière sélective entre inconscient et préconscient. Elle interdit l'accès de certains désirs ou représentations à la perception-conscience et participe ainsi au refoulement. Elle impose des déformations importantes aux contenus qui franchissent cette limite, comme dans le travail du rêve.

P099 - Pare-excitation (fiche p. 26)

Fonction protectrice figurée à la surface de l'appareil psychique, limitant l'irruption d'excitations externes trop intenses ; l'environnement soutient cette protection au début de la vie.

P100 - Traumatisme psychique (fiche p. 26)

Dans le cadre du cours, expérience d'excitation débordant les capacités de maîtrise et de traitement psychique, pensée comme une effraction du pare-excitation. Ses effets ne se déduisent pas du seul événement.

P101 - Ça (fiche p. 26)

Instance constituant le pôle pulsionnel et le réservoir de l'énergie pulsionnelle de la personnalité. Ses contenus sont inconscients et son extrémité s'ouvre du côté somatique. Le support le décrit comme un ensemble de tendances contradictoires, cherchant satisfaction et ignorant les jugements de valeur, le bien, le mal et la morale.

P102 - Moi (fiche p. 26)

Instance médiatrice chargée des intérêts de la totalité de la personne entre revendications du Ça, impératifs du Surmoi et contraintes de la réalité. Son autonomie reste fragile face à ces exigences. Le Moi est à la fois un appareil adaptatif se différenciant du Ça au contact de la réalité et une unité assurant stabilité et identité par les identifications. Il comporte une part consciente, recouvre largement le préconscient et possède une part inconsciente importante, notamment son pôle défensif mobilisé face à l'angoisse.

P103 - Surmoi (fiche p. 26)

Instance présentée comme héritière du complexe d'Œdipe et issue de l'intériorisation des exigences et interdits parentaux, sociaux et culturels, notamment les interdits de l'inceste et du meurtre. Elle exerce trois fonctions : auto-observation critique, conscience morale et censure à l'égard du Moi, formation des idéaux. Le cours associe la culpabilité à la transgression des interdits et la honte à l'écart envers l'Idéal du Moi.

P104 - Idéal du Moi (fiche p. 26)

Ensemble des idéaux et de l'image de ce que le sujet voudrait être ; l'écart à cet idéal peut mobiliser la honte dans la distinction faite à l'oral.

P105 - Culpabilité (fiche p. 26)

Affect lié au sentiment d'avoir transgressé un interdit ou fait du mal à un autre, relié au Surmoi et au lien à l'objet dans le cours.

P106 - Honte (fiche p. 26)

Affect touchant l'image et la valeur de soi, notamment l'écart entre ce que l'on est et son idéal ; l'oral la distingue de la culpabilité.

P107 - Point de vue économique (fiche p. 26)

Lecture des processus psychiques selon les quantités d'excitation, leurs variations, leur circulation et leur répartition.

Index alphabétique

P108 - Principe de constance (fiche p. 27)

Tendance de l'appareil psychique, dans la théorie, à maintenir les quantités d'excitation à un niveau aussi bas que possible.

P109 - Principe de plaisir (fiche p. 27)

Principe selon lequel l'activité psychique évite le déplaisir et recherche le plaisir en réduisant au minimum la tension. Dans le modèle, l'augmentation des quantités d'excitation correspond au déplaisir et leur diminution au plaisir. Ce principe régit les phénomènes inconscients et le Ça ; il est modifié par le principe de réalité.

P110 - Principe de réalité (fiche p. 27)

Principe régulateur qui modifie la recherche de plaisir : la satisfaction n'emprunte plus nécessairement la voie la plus courte mais accepte détours et ajournement en fonction du monde extérieur. Il se construit progressivement avec la confrontation à la réalité et le développement de l'attention, du jugement, de la mémoire et de la pensée. Il prévaut au niveau du Moi.

P111 - Processus primaire (fiche p. 27)

Mode de fonctionnement caractéristique de l'inconscient, où l'énergie circule librement d'une représentation à l'autre, notamment par condensation et déplacement.

P112 - Processus secondaire (fiche p. 27)

Mode de fonctionnement des systèmes préconscient et conscient, dans lequel l'énergie est liée à des représentations investies de manière plus stable et circule de façon contrôlée. Il permet l'ajournement de la satisfaction grâce à la pensée vigilante, l'attention, le jugement, le raisonnement et l'action contrôlée.

P113 - Libido (fiche p. 27)

Énergie des pulsions sexuelles au sens élargi de la psychanalyse ; elle peut être investie dans le Moi, des objets, des représentations ou des activités.

P114 - Investissement libidinal (fiche p. 27)

Attachement ou allocation d'énergie psychique à une représentation, un objet, une partie du corps ou une activité dans le modèle économique.

P115 - Libido narcissique (fiche p. 27)

Part de l'investissement libidinal dirigée vers le Moi ; elle participe à l'image, à la valeur et au soin de soi.

P116 - Libido objectale (fiche p. 27)

Part de l'investissement libidinal dirigée vers des objets extérieurs au Moi, notamment des personnes aimées.

P117 - Compulsion de répétition (fiche p. 27)

Tendance inconsciente à répéter des expériences ou situations pénibles, qui dépasse une explication fondée sur la seule recherche de plaisir ; le cours l'évoque notamment à propos du traumatisme.

P118 - Point de vue dynamique (fiche p. 27)

Lecture des phénomènes psychiques comme résultant du jeu et du conflit entre forces ou exigences opposées, particulièrement d'origine pulsionnelle.

P119 - Conflit psychique (fiche p. 27)

Opposition d'exigences internes incompatibles, par exemple désir et interdit ou désir et défense ; il peut être manifeste ou latent et s'exprimer indirectement.

P120 - Dualisme pulsionnel (fiche p. 27)

Construction théorique opposant deux groupes de pulsions ; le premier dualisme distingue autoconservation et sexualité, le second pulsions de vie et de mort.

P121 - Pulsions d'autoconservation (fiche p. 27)

Pulsions orientées vers la préservation de l'individu et ses fonctions vitales, telles que nutrition, excrétion ou autoprotection dans le modèle.

P122 - Pulsions sexuelles (fiche p. 27)

Pulsions recherchant un plaisir corporel qui dépasse la seule satisfaction des besoins ; le terme est plus large que les conduites génitales adultes.

P123 - Étayage (fiche p. 28)

Appui initial des pulsions sexuelles sur les fonctions d'autoconservation, auxquelles elles empruntent source et objet avant de rechercher une prime de plaisir indépendante du besoin.

P124 - Pulsion partielle (fiche p. 28)

Composante pulsionnelle à source et but locaux, fonctionnant initialement de façon relativement autonome avant l'organisation sous le primat génital.

P125 - Pulsions de vie · Éros (fiche p. 28)

Dans le second dualisme, ensemble associant sexualité et autoconservation, orienté vers la liaison et la constitution d'unités plus grandes.

P126 - Pulsion de mort · Thanatos (fiche p. 28)

Hypothèse du second dualisme d'une tendance à la réduction complète des tensions et au retour du vivant à l'inorganique. Dans le support, elle serait d'abord tournée vers l'intérieur et l'autodestruction, puis vers l'extérieur sous forme de pulsion d'agression. Elle est mise en lien avec répétition et sadomasochisme. C'est un concept métapsychologique ; elle est généralement pensée comme intriquée aux pulsions de vie.

P127 - Intrication pulsionnelle (fiche p. 28)

Association des tendances de vie et de mort dans une même expression psychique ou conduite, plutôt que leur présence indépendante et pure.

Index alphabétique

P128 - Sexualité infantile (fiche p. 28)

Ensemble d'activités précoces procurant un plaisir corporel dépassant la satisfaction du besoin, avec zones érogènes, étayage, pulsions partielles et auto-érotisme ; elle n'est pas une sexualité génitale adulte.

P129 - Auto-érotisme (fiche p. 28)

Mode de satisfaction pulsionnelle trouvé dans le corps propre, initialement au niveau de zones partielles, sans recours nécessaire à un objet extérieur.

P130 - Narcissisme (fiche p. 28)

Investissement libidinal du Moi et de l'image unifiée de son corps comme objet d'amour. Dans le cours, le sujet se prend lui-même comme objet ; la notion n'a pas d'emblée une connotation négative. Elle concerne identifications, idéaux, estime de soi et image de soi. L'équilibre des investissements varie entre libido narcissique et libido d'objet.

P131 - Amour d'objet (fiche p. 28)

Investissement affectif et libidinal d'un autre objet que le Moi, notamment une personne reconnue comme extérieure et distincte.

P132 - Objet partiel (fiche p. 28)

Partie d'une personne ou élément investi psychiquement, par exemple le sein dans le stade oral, plutôt que la personne reconnue dans sa totalité.

P133 - Objet total ou global (fiche p. 29)

Personne investie et reconnue comme une totalité distincte, pouvant réunir des qualités appréciées et frustrantes.

P134 - Objet interne (fiche p. 29)

Représentation psychiquement intériorisée d'un objet ou du lien à celui-ci ; elle permet notamment de conserver un sentiment du lien en son absence.

P135 - Objet externe (fiche p. 29)

Objet ou personne existant à l'extérieur du sujet, avec lequel il entre réellement en relation ; il se distingue de sa représentation interne.

P136 - Incorporation (fiche p. 29)

But pulsionnel consistant à faire entrer en soi un objet de manière réelle ou fantasmatique, particulièrement important dans la description du stade oral.

P137 - Stade oral (fiche p. 29)

Repère développemental, de la naissance au sevrage mais se prolongeant au-delà, où prédomine la zone buccale comme source de plaisir. Le support étend cette source au carrefour aérodigestif, à la phonation, aux organes des sens et à la peau comme zones d'échange avec l'entourage. L'objet premier est le sein ou son substitut, objet partiel ; le but est l'incorporation réelle ou fantasmatique. Il comprend un temps oral primitif de succion et un temps sadique-oral de morsure et d'ambivalence.

P138 - Sous-stade oral primitif (fiche p. 29)

Temps de l'oralité dominé par succion et aspiration, avec une faible différenciation entre sujet et objet dans le modèle.

P139 - Sous-stade sadique-oral (fiche p. 29)

Temps de l'oralité dominé par la morsure et une incorporation pouvant être vécue fantasmatiquement comme destruction, avec émergence de l'ambivalence.

P140 - Sevrage (fiche p. 29)

Arrêt ou modification de l'alimentation au sein, mobilisant dans la lecture du cours des enjeux de séparation et de satisfaction orale, sans définir un âge universel de fin du stade oral.

P141 - Stade anal (fiche p. 29)

Repère surtout situé dans les deuxième et troisième années, se prolongeant au-delà et lié aux acquisitions de maîtrise : marche, parole, pensée et contrôle sphinctérien. Sa source est la zone anale et intestinale d'excrétion, son objet les fèces vécues comme partie du corps propre, ses buts l'expulsion et la rétention. Dans le modèle, il soutient les distinctions dedans-dehors et Moi/non-Moi, et les échanges avec l'entourage, avec des équivalences symboliques entre fèces, argent et cadeau.

P142 - Phase expulsive (fiche p. 29)

Sous-temps anal dominé par l'excrétion et l'expulsion. Le support lui associe une dimension auto-érotique, le rapport aux demandes parentales et une dimension sadique, figurée comme destruction de l'objet-fèces et agressivité envers l'entourage.

P143 - Phase rétentive (fiche p. 29)

Sous-temps anal dominé par la rétention. Le support lui associe une dimension masochique du fait de retenir et une dimension sadique du fait de garder l'objet précieux demandé par les adultes ; cette opposition participe à l'émergence de l'ambivalence dans le modèle.

Index alphabétique

P144 - Ambivalence (fiche p. 29)

Coexistence de sentiments ou tendances opposés envers un même objet, notamment amour et hostilité ; elle ne signifie pas simplement changer successivement d'avis.

P145 - Stade phallique (fiche p. 30)

Repère à partir d'environ trois ans où commence une unification des pulsions partielles sous une prévalence génitale, avec curiosité pour les organes génitaux, la différence des sexes et les origines. Dans la conception freudienne exposée, le monisme phallique oppose présence et absence du pénis. Ce stade reste dit prégénital car le phallus est surtout investi comme puissance ou complétude et comme objet partiel possédé ou non. Il ouvre vers le complexe d'Œdipe et ses angoisses de castration. Cette théorie historique est discutée dans le cours oral.

P146 - Monisme phallique (fiche p. 30)

Hypothèse freudienne selon laquelle l'enfant se représenterait d'abord une seule référence génitale, en opposant présence et absence du pénis ; le cours oral rappelle que cette conception est discutée.

P147 - Théories sexuelles infantiles (fiche p. 30)

Explications élaborées par l'enfant pour donner sens aux origines, à la procréation et à la naissance, à partir de ses représentations et de son niveau de développement.

P148 - Complexe d'Œdipe (fiche p. 30)

Ensemble de désirs amoureux et hostiles à l'égard des deux figures parentales, avec formes positive, négative et complète dans la théorie freudienne. Le support lui attribue un rôle nodal : dépassement de l'auto-érotisme, orientation vers des objets extérieurs globaux, entiers et sexués, triangulation, genèse du Surmoi et de l'Idéal du Moi. Sa résolution implique renoncement à la possession des objets parentaux, intériorisation des interdits de l'inceste et du meurtre, identifications et perspective d'autres objets d'amour : passer de l'avoir à l'être comme.

P149 - Œdipe positif, négatif et complet (fiche p. 30)

Forme positive : attirance pour le parent de sexe opposé et rivalité envers celui de même sexe ; forme négative : distribution inverse ; forme complète : coexistence et articulation des deux dans le modèle.

P150 - Triangulation (fiche p. 30)

Accès à une relation où un tiers a une place et où l'objet aimé peut investir un autre lien ; elle implique de sortir d'une exclusivité à deux.

P151 - Période de latence (fiche p. 30)

Période située approximativement de six-sept ans à la puberté, après l'Œdipe, décrite comme un repos seulement apparent du fait du refoulement. Ce n'est pas un stade car elle n'est pas un nouveau moment d'organisation autour d'une zone érogène. Les interdits, l'immaturité et les contraintes externes contribuent à l'inhibition du but sexuel ; la libido est réorientée vers les apprentissages, les activités, les liens tendres avec les parents et de nouveaux objets sociaux.

P152 - Amnésie infantile (fiche p. 30)

Rareté ou absence de souvenirs conscients des premières années de vie, reliée au refoulement dans le cadre explicatif du cours.

P153 - Primat du génital (fiche p. 30)

Organisation dans laquelle les pulsions partielles sont davantage coordonnées sous la prévalence génitale ; le cours la situe dans le développement psychosexuel et ses remaniements pubertaires.

P154 - Fixation (fiche p. 30)

Maintien privilégié d'un investissement ou d'un mode de satisfaction lié à un temps antérieur du développement, auquel une régression peut ensuite reconduire dans la lecture psychanalytique.

P155 - Angoisse (fiche p. 30)

Peur sans objet, ou sans objet clairement défini, traduisant dans le cours la détresse de l'appareil psychique face à des menaces internes et pouvant mobiliser ses défenses.

P156 - Signal d'angoisse (fiche p. 31)

Forme atténuée d'angoisse jouant un rôle d'alarme pour le Moi et déclenchant des opérations défensives dans la seconde théorie freudienne.

P157 - Angoisse automatique (fiche p. 31)

Réaction de débordement face à un afflux d'excitations internes ou externes que le sujet ne peut maîtriser ; elle se distingue du signal d'alarme atténué.

P158 - Angoisses de morcellement (fiche p. 31)

Angoisses massives et archaïques de destruction, d'anéantissement, d'annihilation, de dévoration, de mort psychique ou par éclatement, se traduisant par la sensation que le corps part en morceaux ou que l'identité vole en éclats.

P159 - Angoisses de perte d'objet (fiche p. 31)

Angoisses liées à la séparation ou à la perte, réelle, anticipée ou fantasmatique, d'un objet d'amour. Le cours les rapproche des angoisses d'abandon et de séparation, particulièrement décrites dans les états-limites.

Index alphabétique

P160 - Angoisses de castration (fiche p. 31)

Angoisses de pertes symboliques touchant le sentiment de puissance ou de complétude et pouvant atteindre fantasmatiquement féminité, virilité, capacités intellectuelles ou physiques, autonomie et indépendance.

P161 - Relation d'objet (fiche p. 31)

Manière dont un sujet investit ses objets et entre en relation avec eux, en fonction de son organisation et des modalités de son fonctionnement psychique.

P162 - Relation anaclitique (fiche p. 31)

Relation dans laquelle le sujet s'appuie fortement sur un objet extérieur pour soutenir son équilibre et son Moi, avec une crainte importante de le perdre.

P163 - Structure psychique (fiche p. 31)

Organisation relativement stable du fonctionnement de la personnalité dans la théorie psychanalytique, qui oriente les modalités de conflit, de défense et de décompensation.

P164 - Décompensation (fiche p. 31)

Rupture d'un équilibre psychique antérieurement maintenu, avec apparition ou accentuation de manifestations psychopathologiques selon les fragilités de l'organisation.

P165 - Névrose (fiche p. 31)

Notion clinique et théorique historique désignant dans le support une maladie mentale dont le sujet reste douloureusement conscient. Elle peut entraîner des troubles durables de la personnalité, sans altérer profondément les fonctions essentielles. Le support la décrit comme fonctionnelle, sans lésion, et caractérisée par des conflits intrapsychiques, notamment dans l'hystérie, la névrose phobique et la névrose obsessionnelle. L'oral insiste sur le maintien global du contact avec la réalité. Cette définition historique ne constitue pas l'équivalent d'une catégorie diagnostique contemporaine unique.

P166 - Psychose (fiche p. 31)

Notion regroupant dans le cadre du cours des organisations et tableaux où le rapport à la réalité peut être profondément altéré ; elle ne se définit pas par un signe isolé.

P167 - États-limites (fiche p. 31)

Organisations décrites par Bergeret comme des astructurations entre les grandes structures, avec enjeux narcissiques, dépendance à l'objet et angoisses de perte ; ce modèle ne se confond pas automatiquement avec une catégorie du DSM.

P168 - Perversion (fiche p. 31)

Notion historique de la psychopathologie psychanalytique, distincte de l'usage courant d'insulte ; le cours insiste sur la coexistence de reconnaissance et de déni de la loi ou de la castration dans le clivage dit pervers.

P169 - Mécanisme de défense (fiche p. 32)

Opération par laquelle le Moi se protège d'une menace ou d'un conflit susceptible de susciter une angoisse et d'atteindre l'intégrité psychique. Ces opérations sont inconscientes dans la liste du cours, sauf la mise à l'écart volontaire.

P170 - Refoulement (fiche p. 32)

Opération inconsciente repoussant ou maintenant hors de la conscience des représentations conflictuelles qui restent actives. Leur retour transformé peut participer au rêve, au lapsus ou au symptôme.

P171 - Retour du refoulé (fiche p. 32)

Réapparition indirecte et transformée de contenus maintenus dans l'inconscient, notamment lorsque le refoulement ne suffit plus à les contenir.

P172 - Déplacement (fiche p. 32)

Transfert de l'accent ou de l'intensité affective d'une représentation vers une autre, initialement moins importante, par des liens associatifs ; le conflit est ainsi déplacé vers un autre contenu.

P173 - Isolation (fiche p. 32)

Séparation d'une représentation et de l'affect qui lui est associé, ou déconnexion de pensées et conduites normalement liées ; le contenu peut rester conscient mais apparaître froid ou indifférent.

P174 - Annulation rétroactive (fiche p. 32)

Tentative inconsciente de rendre non advenus une pensée, une parole ou un geste au moyen d'une autre pensée ou conduite de sens opposé ; elle relève d'une logique de pensée magique.

P175 - Formation réactionnelle (fiche p. 33)

Adoption d'une attitude ou d'un trait opposé à un désir refoulé, souvent de façon rigide, forcée ou excessive ; le cours cite notamment une pudeur très accentuée contre une tendance exhibitionniste.

P176 - Dénégation (fiche p. 33)

Refus de reconnaître comme sien un désir, une pensée ou un sentiment venant d'être formulé et jusque-là refoulé. Le contenu atteint l'expression, mais le sujet en refuse l'appartenance.

Index alphabétique

P177 - Déni (fiche p. 33)

Refus inconscient de reconnaître la réalité d'une perception vécue comme trop dangereuse, traumatisante ou douloureuse pour le Moi ; il ne se confond pas avec une contestation volontaire ni un simple doute.

P178 - Projection (fiche p. 33)

Attribution au dehors, à une personne ou une chose, de pensées, affects, désirs ou qualités que le sujet méconnaît ou refuse de reconnaître en lui-même.

P179 - Clivage du Moi (fiche p. 33)

Coexistence dans le Moi de deux attitudes psychiques contradictoires, par exemple reconnaissance et déni de la réalité, qui persistent sans s'influencer et sans compromis.

P180 - Clivage de l'objet (fiche p. 33)

Séparation de l'objet en un pôle entièrement bon et un pôle entièrement mauvais, difficilement réunis dans une représentation ambivalente. Le bon objet est gratifiant, idéalisé et recherché ; le mauvais est frustrant, dévalorisé et attaqué. L'oral décrit comment cette opposition peut être projetée sur différents membres d'une équipe.

P181 - Renversement en son contraire (fiche p. 33)

Transformation du but pulsionnel en son contraire : activité en passivité, amour en haine, voyeurisme en exhibitionnisme, sadisme en masochisme ou inversement. Il concerne l'orientation de la tendance et se distingue de la formation réactionnelle qui porte notamment sur une attitude ou un trait de caractère opposé au désir refoulé.

P182 - Retournement contre soi (fiche p. 33)

Détournement vers soi d'une agressivité qui ne peut être reconnue ou adressée à l'objet extérieur ; le cours le relie notamment à la culpabilité et aux conduites autopunitives.

P183 - Introjection (fiche p. 33)

Inclusion fantasmatique dans le psychisme d'un objet, d'une partie de l'objet ou du lien avec lui. Elle permet notamment de garder intérieurement les traces d'une relation malgré l'absence ou la perte.

P184 - Identification (fiche p. 33)

Assimilation inconsciente d'un aspect, d'une propriété ou d'un attribut d'autrui, conduisant le sujet à se transformer en partie ou en totalité sur ce modèle ; les identifications participent à la construction de la personnalité.

P185 - Identification à l'agresseur (fiche p. 33)

Forme d'identification où un sujet confronté à un danger extérieur s'identifie à son agresseur, soit en reprenant l'agression, soit en l'imitant physiquement ou moralement, soit en adoptant des symboles de puissance qui le caractérisent. Ce processus défensif ne constitue ni un consentement à la violence ni un choix délibéré de la subir.

P186 - Idéalisation (fiche p. 33)

Élévation des qualités et de la valeur d'un objet à un degré de perfection, pouvant servir à se défendre contre la haine et l'ambivalence dans la lecture du cours.

P187 - Régression (fiche p. 33)

Retour plus ou moins organisé et transitoire à des modes antérieurs de pensée, de conduite ou de relation face à une angoisse ou une frustration ; elle peut apparaître dans la maladie.

P188 - Activisme (fiche p. 34)

Recours à l'action pour gérer un conflit ou une situation traumatique à la place de la réflexion et du vécu des affects ; l'agitation peut ainsi éviter de penser ce qui angoisse.

P189 - Rationalisation (fiche p. 34)

Justification apparemment logique mais artificielle de jugements, sentiments ou conduites, masquant à l'insu du sujet leurs motifs inconscients.

P190 - Intellectualisation (fiche p. 34)

Recours privilégié à l'abstraction et à la généralisation pour se tenir à distance d'une situation dont l'affect serait trop angoissant ; elle se distingue d'une recherche volontaire d'informations.

P191 - Sublimation (fiche p. 34)

Le support regroupe deux devenirs de la pulsion : d'une part, inhibition du but sexuel en conservant le même objet, avec transformation du désir en tendresse, amitié ou camaraderie ; d'autre part, dérivation de la libido vers des activités artistiques, intellectuelles ou morales socialement valorisées, avec changement de but ou d'objet et sans recours au refoulement. Il faut distinguer ces deux descriptions et ne pas confondre sublimation et refoulement.

P192 - Humour (fiche p. 34)

Dans la liste des défenses, manière de présenter sa propre situation pénible ou traumatisante sous un angle plaisant, insolite ou ironique ; le cours insiste sur l'humour appliqué à soi.

Index alphabétique

P193 - Altruisme (fiche p. 34)

Dans son emploi défensif, dévouement à autrui permettant au sujet d'échapper à un conflit psychique ; ce sens ne résume pas toutes les motivations d'une aide.

P194 - Mise à l'écart (fiche p. 34)

Rejet volontaire, hors du champ actuel de la conscience, de problèmes, désirs, sentiments ou expériences qui tourmentent. Le cours la distingue comme consciente, à la différence du refoulement.

P195 - Transfert (fiche p. 34)

Déplacement d'affects d'un objet du passé vers un objet du présent selon une analogie ou association le plus souvent inconsciente, réactualisant des attentes et modalités relationnelles antérieures.

P196 - Transfert positif / négatif (fiche p. 34)

Polarités affectives du transfert : attachement, confiance ou idéalisation d'une part ; hostilité, crainte ou rejet d'autre part. Elles peuvent coexister et se modifier dans la relation.

P197 - Contre-transfert (fiche p. 34)

Réactions psychiques du soignant engagées dans la rencontre avec le patient et ses mouvements transférentiels ; leur repérage soutient la réflexion sur la relation. Le terme est annoncé, sans développement détaillé, dans le support.

P198 - Résistance (fiche p. 34)

Dans le contexte psychanalytique, processus faisant obstacle à l'accès ou au travail de certains contenus psychiques ; le transfert peut servir de résistance tout en constituant un levier thérapeutique.

P199 - Clivage institutionnel (fiche p. 34)

Opposition entre groupes de professionnels pouvant prolonger dans l'équipe la division des objets en bons et mauvais vécue par le patient ; l'oral en fait un enjeu de réflexion collective.

P200 - Sémiologie psychiatrique (fiche p. 35)

Étude et recueil des manifestations psychiques, en distinguant symptômes rapportés, signes observables et syndromes ; le terme séméiologie est aussi employé.

P201 - Symptôme (fiche p. 35)

Au sens sémiologique précis, manifestation subjective d'un processus pathologique, ressentie ou décrite par le patient, à distinguer du signe clinique observé. Dans l'abord de la rencontre clinique, le support l'emploie aussi au sens plus large de signal d'alerte : changement émotionnel, cognitif ou comportemental tranchant avec le fonctionnement habituel, parfois repéré d'abord par l'entourage. Dans la lecture psychanalytique, certains symptômes sont compris comme formations de compromis entre désir et défense, dotées d'un sens et d'une fonction pour le sujet.

P202 - Signe clinique (fiche p. 35)

Manifestation repérable par l'observation du clinicien, à distinguer du vécu subjectif rapporté ; son interprétation dépend du contexte et de son association à d'autres manifestations.

P203 - Syndrome (fiche p. 35)

Association de signes et symptômes formant un ensemble clinique plus ou moins spécifique, susceptible d'orienter vers des hypothèses diagnostiques.

P204 - Signifiant / signifié (fiche p. 35)

Dans la présentation sémiologique du support, le signifiant est la forme matérielle d'un signe ; le signifié est son contenu ou sa signification.

P205 - Nosographie (fiche p. 35)

Description et organisation des maladies ou troubles en ensembles permettant leur classement et leur communication clinique.

P206 - Nosologie (fiche p. 35)

Étude et organisation conceptuelle des maladies, de leurs catégories et de leurs relations ; l'oral la rattache notamment à la réflexion sur leurs causes.

P207 - Recueil sémiologique (fiche p. 35)

Étape de collecte et de discrimination de ce que le patient décrit et de ce qui est observé, avant l'élaboration du diagnostic.

P208 - Diagnostic (fiche p. 35)

Démarche et conclusion consistant à reconnaître un trouble à partir d'un ensemble de manifestations, de leur organisation, de leur contexte et de critères pertinents.

P209 - Hypothèse étiopathogénique (fiche p. 35)

Proposition concernant les causes et mécanismes par lesquels un trouble s'est constitué et se maintient ; elle doit être distinguée d'un fait directement observé.

Index alphabétique

P210 - Diagnostic différentiel (fiche p. 35)
Raisonnement distinguant plusieurs causes ou troubles susceptibles d'expliquer des manifestations proches, notamment une autre affection médicale ou l'effet d'une substance.

P211 - Bénéfice primaire (fiche p. 35)
Dans le modèle psychanalytique, apaisement de l'angoisse ou diminution de l'intensité d'un conflit interne rendu possible par la formation du symptôme.

P212 - Bénéfice secondaire (fiche p. 35)
Avantage conscient ou inconscient qu'un sujet peut tirer de sa pathologie psychique ou somatique ou de ses conséquences. Il est distinct de l'apaisement interne du conflit, appelé bénéfice primaire. Sa présence ne prouve pas une simulation ni l'absence de souffrance.

P213 - Symptôme labile (fiche p. 35)
Manifestation changeante ou susceptible de se modifier rapidement ; le cours insiste sur cette labilité chez l'enfant en développement.

P214 - Classification (fiche p. 36)
Mise en ordre de phénomènes dans un système de classes partageant des caractéristiques ; elle remplit des fonctions de systématisation et d'aide au diagnostic.

P215 - Systématisation (fiche p. 36)
Organisation ordonnée d'une multiplicité de manifestations afin de pouvoir les décrire, les comparer et les penser plus facilement.

P216 - Classification catégorielle (fiche p. 36)
Classement reposant sur la présence ou l'absence de critères permettant l'inclusion dans une catégorie définie.

P217 - Classification dimensionnelle (fiche p. 36)
Évaluation de l'intensité ou de la fréquence d'une ou plusieurs dimensions, sans que leur mesure constitue automatiquement un diagnostic catégoriel.

P218 - Classification typologique (fiche p. 36)
Description des troubles par types ou configurations de traits associés à des syndromes. L'appartenance repose sur certains traits essentiels, sans exiger tous les traits possibles. Le profil peut être établi à partir de l'observation et de l'expérience cliniques, éventuellement standardisées, ou par des méthodes statistiques ; il associe caractéristiques et intensité.

P219 - Validité externe (fiche p. 36)
Adéquation de la classification avec la réalité clinique qu'elle cherche à représenter dans la présentation du cours.

P220 - Validité interne / cohérence (fiche p. 36)
Cohérence des règles et des catégories du système permettant un raisonnement non contradictoire ; elle n'interdit pas l'existence de troubles associés.

P221 - Fidélité temporelle (fiche p. 36)
Stabilité du résultat lorsqu'une même situation clinique inchangée est évaluée à différents moments avec le même système.

P222 - Fidélité inter-juges (fiche p. 36)
Accord entre plusieurs évaluateurs utilisant le même système à partir d'une même situation clinique.

P223 - Sensibilité (fiche p. 36)
Capacité de repérage des situations qui relèvent du trouble recherché ; le support l'évoque plus largement avec la capacité de différenciation des tableaux et de leurs évolutions.

P224 - Faux négatif (fiche p. 36)
Situation où un trouble présent n'est pas repéré par la démarche de classification ou d'évaluation utilisée.

P225 - Faux positif (fiche p. 36)
Situation où l'évaluation conclut à un trouble alors qu'il n'est pas présent dans les conditions recherchées.

P226 - Comorbidité (fiche p. 36)
Présence associée de plusieurs troubles chez une même personne ; elle justifie de rechercher ce qui accompagne ou reste masqué derrière la plainte principale.

P227 - Épisode dépressif caractérisé · EDC (fiche p. 36)
Ensemble d'au moins cinq des neuf manifestations décrites dans l'exemple du support, sur une même période d'au moins deux semaines, avec humeur dépressive ou perte d'intérêt/plaisir, changement et retentissement significatifs ; les exclusions doivent aussi être examinées.

P228 - Anhédonie (fiche p. 36)
Diminution ou perte de la capacité à éprouver de l'intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement investies ; elle constitue un des deux symptômes centraux de l'exemple d'EDC.

P229 - Ralentissement psychomoteur (fiche p. 36)
Diminution observable de l'activité motrice et du rythme psychique ; dans l'exemple diagnostique, il ne se limite pas au seul ressenti intérieur de lenteur.

Index alphabétique

P230 - Hypersomnie / insomnie (fiche p. 37)

Augmentation excessive du sommeil d'une part ; difficulté de sommeil d'autre part. Elles font partie des manifestations à considérer dans l'exemple dépressif, sans être spécifiques à elles seules.

P231 - Manie / hypomanie (fiche p. 37)

États d'élévation ou d'irritabilité de l'humeur et d'activation, d'intensité et de retentissement différents. Le support les cite surtout comme antécédents à rechercher pour distinguer le trouble dépressif unipolaire d'un trouble bipolaire ; leurs critères complets ne sont pas détaillés ici.

P232 - Rémission partielle (fiche p. 37)

Amélioration d'un trouble avec persistance de certaines manifestations ou de critères résiduels ; elle se distingue de la rémission complète.

P233 - Rémission complète (fiche p. 37)

Disparition des manifestations définissant l'épisode considéré ; elle ne signifie pas automatiquement disparition de toute vulnérabilité ou arrêt d'un suivi.

P234 - Rechute (fiche p. 37)

Réapparition ou aggravation d'un trouble après une amélioration ; elle doit être appréciée dans l'évolution clinique.

P235 - Diagnostic provisoire (fiche p. 37)

Hypothèse diagnostique retenue en attente d'informations ou d'une observation évolutive suffisantes, plutôt qu'une conclusion présentée comme définitive.

P236 - Diagnostic non spécifié (fiche p. 37)

Catégorie employée lorsqu'un tableau répond aux critères généraux d'une classe sans satisfaire ceux d'un trouble spécifique, ou lorsqu'un regroupement non inclus dans la classification provoque une souffrance ou une déficience significative. Le support cite aussi l'étiologie incertaine et des informations manquantes, incohérentes ou contradictoires. Ce terme ne signifie ni absence de trouble ni certitude sur sa cause.

P237 - Diagnostic de rétablissement (fiche p. 37)

Évaluation des perspectives d'amélioration et de retour à une vie ordinaire en fonction des ressources et possibilités de la personne, en complément du nom du trouble.

P238 - DSM (fiche p. 37)

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de l'American Psychiatric Association ; le cours présente le DSM-5 comme descriptif et principalement catégoriel, avec critères et spécifications de sévérité et d'évolution.

P239 - CIM (fiche p. 37)

Classification internationale des maladies portée par l'Organisation mondiale de la santé, couvrant maladies et problèmes de santé ; le support compare sa démarche clinique à celle du DSM.

P240 - CFTMEA (fiche p. 37)

Classification française des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, soulignant des repères développementaux, dynamiques et structuraux, ainsi que des dimensions catégorielles et dimensionnelles.

P241 - APA / OMS (fiche p. 37)

APA : American Psychiatric Association, organisme éditant le DSM. OMS : Organisation mondiale de la santé, responsable de la CIM dans la présentation du cours.

P242 - Mortalité / morbidité (fiche p. 37)

La mortalité concerne les décès dans une population ; la morbidité concerne la présence ou la fréquence des maladies. Le cours les relie à l'histoire et aux usages de la CIM.

P243 - Modèle processuel (fiche p. 37)

Modèle centré sur les processus psychiques participant à la dynamique des troubles, plutôt que seulement sur leur classement en catégories.

P244 - Processus transdiagnostique (fiche p. 38)

Mécanisme susceptible d'intervenir dans plusieurs troubles ou catégories diagnostiques ; son étude peut relier des tableaux différents.

P245 - Modèle en réseau de symptômes (fiche p. 38)

Modèle expliquant un trouble par des relations complexes et des interactions entre symptômes, sans supposer nécessairement une cause morbide sous-jacente unique.

P246 - Névroses actuelles / de transfert (fiche p. 38)

Distinction historique freudienne : les premières sont rapportées à des facteurs actuels ; les secondes sont abordées à partir de conflits et de leur réactualisation transférentielle. Ces groupes ne sont pas des équivalents directs des diagnostics contemporains.

P247 - Névrose d'angoisse (fiche p. 38)

Catégorie historique de névrose actuelle centrée sur des manifestations anxieuses ; les rapprochements proposés à l'oral avec les troubles anxieux sont des repères, pas une équivalence nosographique exacte.

P248 - Neurasthénie (fiche p. 38)

Catégorie historique citée parmi les névroses actuelles, associant notamment fatigue et plaintes nerveuses ; ses critères ne sont pas développés dans ce support.

Index alphabétique

P249 - Hypocondrie (fiche p. 38)

Préoccupation anxieuse concernant la santé et la possibilité d'être malade, citée dans la classification historique ; cette mention ne suffit pas à définir tous les critères d'un diagnostic contemporain.

P250 - Névrose obsessionnelle (fiche p. 38)

Catégorie historique marquée par des pensées contraignantes, conflits et défenses notamment d'isolation et d'annulation ; elle ne se superpose pas automatiquement à tout trouble obsessionnel-compulsif.

P251 - Névrose phobique (fiche p. 38)

Catégorie historique où une crainte est attachée à un objet ou une situation et peut conduire à l'évitement ; elle est aussi appelée hystérie d'angoisse dans la classification présentée.

P252 - Schizophrénie (fiche p. 38)

Trouble cité dans les psychoses et rattaché à la dissociation dans la tradition française du cours ; l'oral insiste sur la désorganisation de la pensée et des associations, et non sur une double personnalité. Le support n'en expose pas tous les critères diagnostiques.

P253 - Paranoïa / psychose paranoïaque (fiche p. 38)

Notions historiques de psychose non dissociative du tableau français, associées dans l'oral à un délire et à une lecture projective ; leurs critères complets ne sont pas exposés dans ce cours introductif.

P254 - Mélancolie / manie et PMD (fiche p. 38)

Termes de la classification historique regroupés sous psychose maniaco-dépressive. L'oral rapproche la PMD des troubles bipolaires et décrit la mélancolie comme une dépression particulièrement grave ; ce rapprochement ne remplace pas les critères diagnostiques.

P255 - Bouffée délirante aiguë · BDA (fiche p. 38)

Terme de la tradition française désignant un tableau psychotique aigu, d'apparition rapide, dont l'évolution doit être observée. Un épisode isolé ne permet pas de conclure d'emblée à une évolution chronique.

P256 - Dissociation psychiatrique (fiche p. 38)

Dans la tradition française présentée, désorganisation des liens entre pensée, affect et comportement, illustrée surtout à l'oral par la rupture des associations. Elle ne signifie pas une double personnalité.

P257 - Barrage (fiche p. 38)

Interruption brusque du cours de la pensée ou du discours, illustrée à l'oral comme une manifestation de la désorganisation des associations.

P258 - Fading (fiche p. 39)

Effacement ou ralentissement progressif du cours de la pensée et du discours, distingué à l'oral du caractère abrupt du barrage.

P259 - Psychose hallucinatoire chronique · PHC (fiche p. 39)

Catégorie historique française de psychose chronique non dissociative où les phénomènes hallucinatoires et l'automatisme mental occupent une place importante dans la présentation orale.

P260 - Automatisme mental (fiche p. 39)

Ensemble de phénomènes vécus comme imposés ou échappant à la maîtrise du sujet, notamment autour de la pensée ; il est évoqué à l'oral à propos de la PHC sans description exhaustive.

P261 - Paraphrénies (fiche p. 39)

Catégories historiques de psychoses chroniques non dissociatives, évoquées à l'oral par des productions délirantes imaginatives et fantastiques ; leurs critères ne sont pas détaillés dans le support.

P262 - Impulsion / compulsion (fiche p. 39)

L'oral distingue une tendance impérieuse au passage à l'acte, pouvant court-circuiter la pensée, d'une conduite contraignante contre laquelle le sujet peut lutter anxieusement. Ces termes ne sont pas synonymes de pulsion.

P263 - Hallucination (fiche p. 39)

Expérience perceptive vécue en l'absence d'un objet extérieur correspondant, évoquée notamment dans les exemples de voix ; sa signification doit être appréciée dans son contexte et ne définit pas seule un diagnostic.

P264 - Délire (fiche p. 39)

Ensemble de convictions et d'interprétations marquant une altération du rapport à la réalité dans les tableaux psychotiques cités ; le contenu seul ne suffit pas à caractériser tout le fonctionnement d'une personne.

P265 - Dépersonnalisation (fiche p. 40)

Expérience d'étrangeté concernant soi-même ou son identité, évoquée à l'oral pour illustrer le sentiment de ne plus se reconnaître ou de perdre son unité.

P266 - Reviviscence traumatique (fiche p. 40)

Retour vécu comme actuel d'éléments d'une expérience traumatique, cité à l'oral avec les cauchemars ; le souvenir pénible peut s'imposer plutôt qu'être volontairement recherché.

Index alphabétique

P267 - Passage à l'acte (fiche p. 40)

Recours à une action pouvant court-circuiter l'élaboration et l'expression psychiques d'un conflit ou d'un affect dans la lecture orale du cours ; les causes d'un acte ne se réduisent pas à cette seule hypothèse.

P268 - Anesthésie psychique (fiche p. 40)

Sensation de ne plus éprouver d'émotions ou de se sentir intérieurement vide, décrite dans un exemple oral de souffrance dépressive très importante.

P269 - Angoisse de dévoration (fiche p. 40)

Forme d'angoisse archaïque où le sujet redoute d'être absorbé ou détruit par l'objet ; elle figure dans la définition orale des angoisses de morcellement.

P270 - Astasie-abasie (fiche p. 40)

Incapacité à se tenir debout et à marcher, illustrée dans le cas historique d'Élisabeth ; le terme décrit une difficulté et ne démontre pas, à lui seul, sa cause.

P271 - Aphonie (fiche p. 40)

Perte de la voix ; elle fait partie des manifestations corporelles citées dans l'histoire de l'hystérie, sans que toute aphonie soit psychogène.

P272 - Aphasie (fiche p. 40)

Trouble du langage affectant son expression ou sa compréhension ; elle est citée dans le récit d'Anna O. et dans les repères historiques sur Freud, sans fournir ici une classification neurologique.

P273 - Mutisme (fiche p. 40)

Absence de parole dans une situation donnée ; il est cité parmi les manifestations historiques et demande une analyse de son contexte et de ses causes.

P274 - Parésie / paralysie (fiche p. 40)

La parésie désigne une diminution de la force motrice ; la paralysie une perte du mouvement volontaire. Leur présence ne permet pas d'en déduire automatiquement une origine psychique.

P275 - Anesthésie corporelle (fiche p. 40)

Perte ou diminution de sensibilité dans un territoire, citée parmi les symptômes historiques ; elle se distingue de l'anesthésie psychique qui concerne le ressenti affectif.

P276 - Algies / céphalées (fiche p. 40)

Algies : douleurs ; céphalées : douleurs de la tête. Le support les mentionne parmi des expressions corporelles possibles, sans que ces termes déterminent leur étiologie.

P277 - Vaginisme (fiche p. 40)

Contraction involontaire de la musculature à l'entrée du vagin rendant la pénétration difficile ou impossible ; le terme est cité dans la liste historique des manifestations corporelles, sans développement thérapeutique dans ce support.

P278 - Psyché-soma (fiche p. 40)

Expression soulignant les liens entre vie psychique et corps, notamment chez le jeune enfant dont les difficultés peuvent s'exprimer par des manifestations corporelles.

P279 - Énurésie (fiche p. 40)

Émission involontaire d'urine, évoquée à l'oral comme une manifestation possible chez l'enfant ; l'âge, le développement, le contexte et les causes doivent être pris en compte avant d'en interpréter le sens.

P280 - Égodystonique / égosyntonique (fiche p. 41)

Un vécu égodystonique est ressenti comme étranger ou en désaccord avec soi ; un vécu égosyntonique est en accord avec soi. Ces mots décrivent le rapport subjectif à un vécu et ne suffisent pas à conclure à une pathologie.

P281 - Morbidité / indice morbide (fiche p. 41)

Le premier terme renvoie aux maladies dans une population ; l'emploi de « morbide » dans la définition du champ renvoie à ce qui concerne la maladie, sans constituer à lui seul un critère diagnostique.

P282 - Pathologie du psychologique (fiche p. 19)

Lecture de la psychologie centrée sur ses aspects inhabituels, rares, pathologiques ou affectés d'un indice de morbidité ; premier axe de Lantéri-Laura dans le support.

P283 - Psychologie du pathologique (fiche p. 20)

Lecture globale et holistique de l'expérience vécue d'un patient, qui ne se limite pas à ce qui produit la souffrance ; deuxième axe de Lantéri-Laura.

P284 - Clinique du pathologique (fiche p. 20)

Lecture centrée sur la singularité de l'expérience de souffrance psychique de chaque sujet ; troisième axe de Lantéri-Laura.

P285 - Fonctionnel / lésionnel (fiche p. 20)

Dans les distinctions du support, fonctionnel qualifie une perturbation du fonctionnement sans lésion structurale explicative ; lésionnel renvoie à une atteinte de structure. Cette distinction descriptive ne démontre pas à elle seule une cause psychologique.

Index alphabétique

P286 - État hypnoïde (fiche p. 23)

État de conscience modifié, décrit dans le cas historique d'Anna O., au cours duquel un mot lié à ses préoccupations pouvait susciter une narration spontanée. Il est présenté dans l'histoire de la méthode cathartique, sans être assimilé au sommeil ordinaire.

P287 - Rêve (fiche p. 24)

Formation étudiée en psychanalyse comme expression transformée de contenus psychiques. L'oral distingue contenu latent et contenu manifeste, et décrit condensation, déplacement, figuration et élaboration secondaire. L'exploration repose sur les associations du rêveur, sans clé symbolique universelle.

P288 - Régression topique (fiche p. 24)

Retour, dans la lecture orale du rêve, vers des modalités plus imagées et sensorielles de représentation plutôt que la seule pensée verbale. C'est une modalité de régression dans un modèle de fonctionnement psychique, pas un déplacement anatomique.

P289 - Névrose de destinée (fiche p. 28)

Expression historique employée à l'oral pour décrire des répétitions de situations relationnelles ou de vie pénibles, apparemment subies comme un destin, et rapprochées de la compulsion de répétition. Elle ne permet pas d'attribuer au sujet la responsabilité des violences qu'il subit.

P290 - Carence du préconscient (fiche p. 28)

Hypothèse psychanalytique évoquée à l'oral lorsque des contenus trop chargés d'affects deviennent difficiles à mobiliser et à penser. L'action peut alors court-circuiter l'élaboration. Cette lecture ne constitue pas un critère diagnostique suffisant d'addiction, de trouble alimentaire ou de passage à l'acte.

P291 - Puberté et remaniement psychosexuel (fiche p. 32)

Dans le modèle du cours, poussée pulsionnelle et modifications corporelles s'accompagnent d'un remaniement identificatoire et d'une réactivation des enjeux œdipiens. La capacité génitale donne une portée nouvelle aux fantasmes incestueux, contre lesquels le sujet se défend, et sollicite la prise de distance avec les objets parentaux au profit d'autres investissements.

P292 - Première théorie freudienne de l'angoisse (fiche p. 32)

Le refoulement produit l'angoisse : lorsque la pulsion ne peut être satisfaite, la représentation est refoulée et la charge ou quantum d'affect est transformé en angoisse. C'est la première articulation causale exposée dans le support.

P293 - Seconde théorie freudienne de l'angoisse (fiche p. 32)

L'angoisse provoque les défenses, notamment le refoulement. Un signal de déplaisir, reproduction atténuée d'une ancienne réaction traumatique, mobilise le Moi face aux exigences pulsionnelles ; la perte ou menace de perte de l'objet joue souvent un rôle. Ce signal se distingue du débordement de l'angoisse automatique.

P294 - Deuil et travail de deuil (fiche p. 32)

Réaction à la perte d'un objet d'amour et travail de remaniement psychique de cet investissement. Dans l'exemple oral, le sujet reprend les traces de la relation et peut conserver un lien intérieur à l'objet par introjection. La souffrance n'est pas automatiquement pathologique ; contexte, intensité, durée et retentissement sont à examiner.

P295 - Athéorique (fiche p. 39)

Dans la présentation du DSM, intention de ne pas faire dépendre la description diagnostique d'une théorie causale particulière et de privilégier les critères cliniques et les données empiriques. L'oral rappelle que la construction d'une classification comporte néanmoins des choix.

P296 - Sévérité légère, moyenne ou sévère (fiche p. 39)

Spécification de l'intensité d'un trouble. Le support décrit un niveau léger avec peu de symptômes au-delà du minimum requis et une altération mineure du fonctionnement ; un niveau sévère avec davantage de symptômes, des manifestations particulièrement intenses ou un retentissement marqué ; le niveau moyen est intermédiaire.

P297 - Antécédent / diagnostic principal (fiche p. 39)

Un antécédent est un événement ou trouble de l'histoire clinique utile à l'évaluation actuelle. Le diagnostic principal désigne le trouble retenu comme principal dans la situation de consultation ; les troubles associés ne disparaissent pas pour autant. Le motif exprimé de consultation et le diagnostic principal sont à distinguer.

P298 - Transcodage (fiche p. 39)

Mise en correspondance des codes de plusieurs classifications, notamment CFTMEA et CIM dans le support, pour faciliter les échanges, recherches et usages administratifs. Une correspondance de code n'implique pas une identité parfaite des concepts.

Index alphabétique

P299 - Stade du miroir (fiche p. 32)

Repère évoqué à l'oral pour penser la reconnaissance de sa propre image et la constitution d'un sentiment d'unité du corps et du Moi. Il sert ici à comprendre le pôle identitaire, sans constituer un test diagnostique ni une explication suffisante d'une pathologie.

P300 - Effet placebo (fiche p. 22)

Effet associé notamment aux attentes et au contexte de soin, utilisé à l'oral pour illustrer les interactions entre dimensions psychiques et corporelles. L'exemple vise à éviter d'opposer somatique et psychologique ; les pourcentages approximatifs cités ne sont pas des valeurs à mémoriser.

P301 - Stratégies de coping (fiche p. 34)

Manières de faire face à une situation stressante. L'oral distingue notamment la recherche volontaire d'informations pour réduire le stress de l'intellectualisation défensive, où la fonction d'éloignement de l'affect échappe au sujet.

Index alphabétique

Psychologie du développement

Définitions confrontées au support officiel 2026 et aux compléments oraux déjà examinés. D195-D202 sont désormais documentées par le support ; D203-D222 complètent le lexique. Les citations sont distinguées des reformulations.

D001 - Psychologie du développement (fiche antérieure p. 24)

Étude de la genèse et des transformations des conduites et des systèmes qui les organisent sur l'ensemble de l'existence.

Extrait du support officiel, p. 2 : « étude de la genèse des conduites et des systèmes qui la structurent, s'appliquant à l'ensemble de l'existence (et donc fonction de l'âge) »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 2.

D002 - Psychologie de l'enfant (fiche antérieure p. 24)

Étude des compétences, performances et fonctionnements psychologiques des enfants, avec notamment des applications éducatives.

D003 - Inné (fiche antérieure p. 24)

Ce qui relève de dispositions biologiques présentes précocement ; leur expression s'inscrit dans une interaction avec le milieu.

D004 - Acquis (fiche antérieure p. 24)

Ce qui se construit par l'expérience, l'apprentissage et les interactions au cours de la vie.

D005 - Génotype (fiche antérieure p. 24)

Ensemble des caractéristiques génétiques d'un individu, distinct des caractéristiques directement observables.

D006 - Phénotype (fiche antérieure p. 24)

Caractéristiques observables résultant de l'expression du patrimoine génétique dans un environnement.

D007 - Épigenèse (fiche antérieure p. 24)

Construction progressive de l'organisation et du fonctionnement par des interactions entre dispositions et expériences, au sens du cours.

D008 - Plasticité cérébrale (fiche antérieure p. 24)

Capacité des réseaux nerveux à se modifier au cours du développement et sous l'effet de l'expérience.

D009 - Norme statistique (fiche antérieure p. 24)

Repère fondé sur la fréquence ou la distribution d'une caractéristique dans une population ; elle ne suffit pas à définir la santé.

D010 - Norme sociale (fiche antérieure p. 24)

Attente ou règle de conduite partagée dans un groupe, variable selon la culture et l'époque.

D011 - Pathologique (fiche antérieure p. 24)

Qui concerne une maladie ou un fonctionnement entraînant des difficultés significatives, à apprécier selon plusieurs critères et dans un contexte.

D012 - Désir de grossesse (fiche antérieure p. 24)

Dans la lecture psychodynamique du cours, désir de vivre l'état de grossesse et les expériences corporelles ou psychiques qui lui sont associées.

D013 - Projet d'enfant (fiche antérieure p. 24)

Démarche consciente d'intégration d'un enfant à un projet de vie, individuel ou familial.

D014 - Désir d'enfant (fiche antérieure p. 24)

Investissement de l'idée d'avoir un enfant, comportant des composantes conscientes et inconscientes dans le modèle présenté.

D015 - Enfant imaginaire (fiche antérieure p. 24)

Enfant représenté à partir des souhaits, attentes, fantasmes et projections des futurs parents.

D016 - Enfant réel (fiche antérieure p. 24)

Enfant rencontré dans sa singularité et ses besoins propres, distinct des représentations parentales.

D017 - Deuil de l'enfant imaginaire (fiche antérieure p. 24)

Remaniement des attentes permettant de reconnaître et d'accueillir l'enfant réel.

D018 - Mandat transgénérationnel (fiche antérieure p. 25)

Attentes ou missions transmises entre générations et attribuées à un enfant, de manière plus ou moins explicite.

D019 - Ambivalence (fiche antérieure p. 25)

Coexistence d'affects ou de tendances opposées envers un même objet ou une même situation.

D020 - Identification (fiche antérieure p. 25)

Processus par lequel un sujet s'approprie des caractéristiques d'une autre personne et transforme ainsi sa propre organisation.

D021 - Préoccupation maternelle primaire (fiche antérieure p. 25)

Concept de Winnicott décrivant une sensibilité particulière aux signaux et besoins du bébé en fin de grossesse et dans les premières semaines après la naissance.

Index alphabétique

Extrait du support officiel, p. 16 : « état psychique particulier de la mère qui prend naissance pendant la grossesse et qui se prolonge après la naissance, sorte de folie maternelle caractérisée par une adaptation et une hypersensibilité aux états internes et signaux de son bébé(tout ce qu'il lui communique), »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 16.

D022 - Couvade psychosomatique (fiche antérieure p. 25)

Manifestations corporelles rapportées chez certains futurs pères pendant la grossesse de leur partenaire, sans caractère obligatoire.

D023 - Néoténie (fiche antérieure p. 25)

Persistance ou prolongation de caractéristiques d'immaturité ; dans le cours, elle souligne la grande dépendance initiale du nouveau-né humain.

D024 - Réflexe archaïque (fiche antérieure p. 25)

Réponse motrice précoce automatique recherchée lors de l'examen neurologique du nourrisson, dont l'évolution dépend du réflexe considéré.

D025 - Tonus (fiche antérieure p. 25)

État de tension des muscles participant au maintien postural et à l'ajustement des mouvements.

D026 - Progression céphalo-caudale (fiche antérieure p. 25)

Organisation du contrôle moteur allant globalement de la tête vers les parties inférieures du corps.

D027 - Progression proximo-distale (fiche antérieure p. 25)

Organisation du contrôle moteur allant globalement de l'axe corporel vers les extrémités.

D028 - Préhension (fiche antérieure p. 25)

Action de saisir un objet ; ses modalités deviennent progressivement plus précises.

D029 - Coordination visuo-manuelle (fiche antérieure p. 25)

Ajustement des mouvements de la main aux informations visuelles pour orienter une action.

D030 - Pince pouce-index (fiche antérieure p. 25)

Prise fine d'un objet entre le pouce et l'index, permettant des manipulations plus précises.

D031 - Contrôle sphinctérien (fiche antérieure p. 25)

Capacité progressive à percevoir les besoins d'élimination et à contrôler volontairement les fonctions concernées dans un contexte adapté.

D032 - Énurésie nocturne (fiche antérieure p. 25)

Mictions involontaires répétées pendant le sommeil à un âge où le contrôle est attendu, usuellement à partir de 5 ans ; elle demande une appréciation clinique.

D033 - Encoprésie (fiche antérieure p. 25)

Émissions répétées de selles dans des endroits inappropriés chez un enfant d'au moins 4 ans, avec recherche des causes et du contexte.

D034 - Discrimination perceptive (fiche antérieure p. 25)

Capacité à différencier des stimuli selon leurs caractéristiques.

D035 - Catégorisation (fiche antérieure p. 25)

Regroupement d'éléments à partir de propriétés communes, permettant d'organiser les connaissances.

D036 - Coordination intersensorielle (fiche antérieure p. 26)

Mise en relation d'informations provenant de plusieurs modalités sensorielles.

D037 - Permanence de l'objet (fiche antérieure p. 26)

Compréhension progressive qu'un objet continue à exister lorsqu'il n'est plus directement perçu.

D038 - Erreur A-non-B (fiche antérieure p. 26)

Recherche persistante d'un objet en A, lieu de découvertes antérieures, après qu'il a été caché en B sous les yeux de l'enfant.

D039 - Schème (fiche antérieure p. 26)

Organisation d'action ou de pensée réutilisable dans des situations comparables, notion centrale chez Piaget.

Extrait du support officiel, p. 11 : « actions fondamentales de la connaissance, soit physiques telles vision, succion, préhension etc., soit mentales telles classement, comparaison etc. »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 11.

D040 - Adaptation (fiche antérieure p. 26)

Ajustement des conduites aux rapports entre l'organisme et son milieu, par assimilation et accommodation dans le modèle piagétien.

Extrait du support officiel, p. 11 : « ensemble des modifications des conduites permettant un équilibre des relations entre l'organisme et son milieu »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 11.

D041 - Assimilation (fiche antérieure p. 26)

Intégration d'une donnée nouvelle à un schème existant sans transformation essentielle de celui-ci.

Extrait du support officiel, p. 11 : « intégration de nouvelles données à des conduites antérieures »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 11.

Index alphabétique

D042 - Accommodation (fiche antérieure p. 26)

Modification d'un schème pour rendre possible le traitement de données nouvelles.

Extrait du support officiel, p. 11 : « transformation d'un schème de conduite antérieur pour le rendre compatible avec le traitement de nouvelles données »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 11.

D043 - Équilibration (fiche antérieure p. 26)

Processus de réorganisation des schèmes visant une cohérence entre connaissances et situations rencontrées.

D044 - Intelligence sensori-motrice (fiche antérieure p. 26)

Organisation de la connaissance à partir de la perception et de l'action, avant la place centrale des représentations, jusqu'à environ 2 ans chez Piaget.

D045 - Intelligence préopératoire (fiche antérieure p. 26)

Dans le modèle de Piaget, pensée symbolique encore limitée par la centration et une réversibilité logique incomplète, située approximativement entre 2 et 7 ans.

D046 - Intelligence opératoire concrète (fiche antérieure p. 26)

Dans le modèle de Piaget, raisonnement réversible et décentré portant surtout sur des situations concrètes, approximativement entre 7 et 12 ans.

D047 - Intelligence opératoire formelle (fiche antérieure p. 26)

Dans le modèle de Piaget, raisonnement sur des hypothèses et relations entre propositions, se développant à partir de l'adolescence sans maîtrise universelle dans tous les domaines.

D048 - Réaction circulaire primaire (fiche antérieure p. 26)

Répétition d'une action initialement fortuite et intéressante, centrée sur le corps propre.

D049 - Réaction circulaire secondaire (fiche antérieure p. 26)

Répétition d'une action produisant un effet intéressant sur un objet extérieur.

D050 - Réaction circulaire tertiaire (fiche antérieure p. 26)

Exploration par variation volontaire des actions et observation de leurs effets.

D051 - Intentionnalité (fiche antérieure p. 26)

Organisation d'une conduite orientée vers un but, avec mobilisation progressive des moyens pour l'atteindre.

D052 - Insight (fiche antérieure p. 26)

Apparition d'une solution par réorganisation ou combinaison mentale, plutôt que par les seuls essais moteurs successifs.

D053 - Imitation différée (fiche antérieure p. 26)

Reproduction d'un modèle après sa disparition de la situation perceptive immédiate.

D054 - Prosodie (fiche antérieure p. 27)

Rythme, accentuation et variations d'intonation de la parole, participant au sens et aux échanges affectifs.

D055 - Phonème (fiche antérieure p. 27)

Unité sonore distinctive permettant de différencier des mots dans une langue.

D056 - Graphème (fiche antérieure p. 27)

Unité écrite, formée d'une ou plusieurs lettres, correspondant à une unité du système de la langue écrite.

D057 - Babillage (fiche antérieure p. 27)

Productions vocales prélinguistiques organisées en suites de sons et de syllabes.

D058 - Lallation (fiche antérieure p. 27)

Répétition de suites consonne-voyelle, comme « ba-ba », dans les productions du nourrisson.

D059 - Lexique (fiche antérieure p. 27)

Ensemble des mots disponibles dans une langue ou chez une personne ; distinguer vocabulaire compris et produit.

D060 - Syntaxe (fiche antérieure p. 27)

Organisation des mots et des relations grammaticales dans les énoncés.

D061 - Style référentiel (fiche antérieure p. 27)

Profil d'acquisition du langage privilégiant notamment les noms et la désignation d'objets.

D062 - Style expressif (fiche antérieure p. 27)

Profil d'acquisition du langage utilisant volontiers des expressions ou fragments de phrases dans l'interaction.

D063 - Mot pivot (fiche antérieure p. 27)

Mot réutilisé avec plusieurs autres dans les premiers énoncés, par exemple « encore » associé à différentes demandes.

D064 - Mot-phrase / holophrase (fiche antérieure p. 27)

Mot dont le sens communicatif équivaut à un énoncé plus large, interprété grâce au contexte.

D065 - Pointage / pointing (fiche antérieure p. 27)

Geste orienté vers un objet ou événement pour demander ou partager un intérêt avec autrui.

Index alphabétique

D066 - Attention conjointe (fiche antérieure p. 27)

Partage d'attention entre deux personnes à propos d'un même objet ou événement, avec une dimension de partage social.

D067 - Tour de rôle (fiche antérieure p. 27)

Alternance ajustée des contributions des partenaires dans une interaction.

D068 - LAE (fiche antérieure p. 27)

Langue adaptée à l'enfant : parole ajustée aux possibilités de l'enfant, souvent plus lente, concrète, répétitive et syntaxiquement correcte.

D069 - Étayage (fiche antérieure p. 27)

Appui apporté par un partenaire pour permettre une activité ou une acquisition ; ici, ajustement de l'aide dans l'interaction. À distinguer de l'étayage pulsionnel psychanalytique.

D070 - Attachement (fiche antérieure p. 27)

Lien affectif durable avec une ou quelques figures privilégiées, recherchées comme source de sécurité et de réconfort en situation de détresse.

Extrait du support officiel, p. 17 : « L'attachement constituerait un besoin social primaire => tendance originelle et permanente à rechercher la relation avec autrui, l'attachement une fois formé ayant pour nature de durer. Sa fonction à l'échelle de l'espèce est vraisemblablement double : de protection à l'égard des prédateurs et de survie. »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D071 - Comportement d'attachement (fiche antérieure p. 27)

Conduite favorisant le maintien ou le rétablissement d'une proximité avec une figure d'attachement.

Extrait du support officiel, p. 17 : « Comportements du bébé destinés à favoriser la proximité avec l'objet d'attachement »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D072 - Figure d'attachement (fiche antérieure p. 27)

Personne vers laquelle les conduites d'attachement sont préférentiellement dirigées et dont la disponibilité soutient la sécurité.

Extrait du support officiel, p. 17 : « Figure vers laquelle l'enfant dirige son comportement d'attachement, donc toute personne s'engageant dans une interaction sociale durable et animée avec le bébé, répondant facilement à ses signaux et ses approches. »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D073 - Caregiver (fiche antérieure p. 28)

Personne qui prend soin et peut répondre aux besoins de protection et de réconfort.

D074 - Caregiving (fiche antérieure p. 28)

Système de conduites de protection et de réconfort complémentaire du système d'attachement.

Extrait du support officiel, p. 17 : « Cette réponse aux besoins d'attachement de l'enfant peut s'organiser en système réciproque (ou complémentaire) du système d'attachement de l'enfant : il s'agit du caregiving (fonction de prendre soin, souvent dévolue aux parents mais pas uniquement). Le caregiver cherche à rétablir ou maintenir la proximité physique et psychologique avec le bébé quand il est en situation de danger ou de détresse afin de répondre à ses besoins et de le protéger. Le caregiving est associé chez le caregiver à des émotions spécifiques : plaisir/satisfaction/soulagement quand il peut protéger l'enfant, colère/tristesse/anxiété quand il ne le peut pas. »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D075 - Sensibilité relationnelle (fiche antérieure p. 28)

Capacité à percevoir et interpréter les signaux de l'autre et ses besoins dans la relation.

D076 - Responsivité (fiche antérieure p. 28)

Capacité à répondre de façon ajustée aux signaux et aux besoins perçus.

D077 - Base de sécurité (fiche antérieure p. 28)

Confiance dans la disponibilité d'une figure permettant de rechercher du réconfort et de s'engager dans l'exploration.

Extrait du support officiel, p. 17 : « la confiance dans l'idée qu'une figure protectrice sera accessible/disponible, quel que soit l'âge de l'individu »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D078 - Angoisse de séparation (fiche antérieure p. 28)

Détresse liée à l'absence ou à la perte redoutée d'une figure importante ; son interprétation dépend de l'âge, du contexte, de l'intensité et du retentissement.

D079 - MIO (fiche antérieure p. 28)

Modèles internes opérants : représentations de soi, d'autrui et des interactions qui orientent les attentes et les conduites relationnelles.

D080 - Partenariat corrigé quant au but (fiche antérieure p. 28)

Organisation de la relation dans laquelle l'enfant prend progressivement en compte les intentions de l'autre pour ajuster les moyens de maintenir le lien.

D081 - Système exploratoire (fiche antérieure p. 28)

Organisation des conduites de découverte et de maîtrise de l'environnement, facilitée par un sentiment suffisant de sécurité.

Index alphabétique

D082 - Système affiliatif (fiche antérieure p. 28)
Conduites orientées vers les relations avec les autres et l'appartenance sociale, notamment avec les pairs.

D083 - Carence affective (fiche antérieure p. 28)
Insuffisance durable de relations et de réponses affectives ajustées aux besoins, susceptible de compromettre le développement.

D084 - Éthologie (fiche antérieure p. 28)
Étude des comportements animaux dans leurs conditions de vie, en milieu naturel ou dans des dispositifs d'observation.

D085 - Empreinte (fiche antérieure p. 28)
Apprentissage précoce, décrit chez certaines espèces, orientant une conduite vers un objet rencontré dans une période sensible ; ne se superpose pas directement à l'attachement humain.

D086 - Dépression anaclitique (fiche antérieure p. 28)
Description historique de Spitz d'un tableau de détresse et de retrait du nourrisson après la perte d'une relation auparavant investie.

D087 - Hospitalisme (fiche antérieure p. 28)
Tableau historique de perturbations graves du développement et de la relation lié à une privation relationnelle prolongée dans un environnement institutionnel défaillant.

D088 - Retrait relationnel (fiche antérieure p. 28)
Diminution importante de l'engagement dans les échanges ; signe à explorer, sans cause unique déduite de sa seule présence.

D089 - Stéréotypie (fiche antérieure p. 28)
Répétition de mouvements ou de conduites relativement semblables ; sa signification dépend de l'ensemble du fonctionnement et du contexte.

D090 - Protestation / désespoir / détachement (fiche antérieure p. 29)
Trois phases possibles décrites par les Robertson lors de séparations prolongées : tentative active de retrouver le lien, retrait, puis diminution apparente des manifestations d'attachement.

D091 - Holding (fiche antérieure p. 29)
Chez Winnicott, portage et contenance physiques et psychiques dans un environnement suffisamment fiable.

D092 - Handling (fiche antérieure p. 29)
Chez Winnicott, manière de manipuler le bébé et de prodiguer les soins corporels, en s'ajustant à ses rythmes et réactions.

D093 - Object-presenting (fiche antérieure p. 29)
Chez Winnicott, présentation ajustée des objets et ouverture progressive au monde extérieur.

D094 - Psyché-soma (fiche antérieure p. 29)
Articulation de la vie psychique et de l'expérience corporelle ; dans le modèle, sentiment d'habiter son corps.

D095 - Self (fiche antérieure p. 29)
Chez Winnicott, expérience subjective d'être soi et de continuité d'existence, soutenue par l'environnement précoce.

D096 - Objet transitionnel (fiche antérieure p. 29)
Objet investi dans une aire intermédiaire entre vécu subjectif et réalité extérieure, pouvant soutenir la tolérance de l'absence.

D097 - Phénomène transitionnel (fiche antérieure p. 29)
Expérience, rituel ou activité occupant cette aire intermédiaire ; ne se limite pas à un objet matériel.

D098 - Situation étrange (fiche antérieure p. 29)
Procédure standardisée d'Ainsworth observant le jeune enfant avec une figure d'attachement lors de brefs épisodes de présence, séparation et retrouvailles.

D099 - Attachement sécure (fiche antérieure p. 29)
Organisation dans laquelle la figure peut être utilisée pour se réconforter et retrouver une disponibilité à l'exploration.

D100 - Attachement insécure évitant (fiche antérieure p. 29)
Organisation marquée par la limitation visible de la recherche de proximité et l'évitement du contact, notamment aux retrouvailles.

D101 - Attachement insécure ambivalent / résistant (fiche antérieure p. 29)
Organisation associant forte détresse, recherche de contact et résistance au réconfort lors des retrouvailles.

D102 - Attachement désorganisé (fiche antérieure p. 29)
Conduites contradictoires, figées ou interrompues à certains moments d'activation du lien, sans stratégie cohérente disponible.

D103 - Sociabilité indiscriminée (fiche antérieure p. 29)
Approche sociale insuffisamment différenciée des adultes, parfois excessivement familière, avec peu de vérification auprès d'une figure repère.

D104 - Alliance de caregiving (fiche antérieure p. 29)
Coopération entre les adultes qui prennent soin pour préserver protection, continuité et sécurité malgré d'éventuels désaccords.

Index alphabétique

D105 - Émotion (fiche antérieure p. 29)

Réaction généralement brève à une situation significative, associant vécu subjectif, évaluation cognitive et modifications corporelles.

Extrait du support officiel, p. 17 : « Réaction survenant le plus souvent brusquement et pour une durée relativement brève à l'apparition d'une situation significative pour le sujet. Réaction qui est à la fois cognitive (processus cognitifs) et à la fois biologique. »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D106 - Régulation émotionnelle (fiche antérieure p. 29)

Processus par lesquels l'intensité, la durée et l'expression d'une émotion sont modulées, avec l'aide d'autrui ou par le sujet.

D107 - Fonction sémiotique (fiche antérieure p. 30)

Capacité d'évoquer des objets, personnes ou événements au moyen de signes et de symboles, notamment en leur absence.

D108 - Jeu symbolique (fiche antérieure p. 30)

Activité de faire-semblant où un objet, un geste ou un rôle représente autre chose que sa réalité immédiate.

D109 - Image mentale (fiche antérieure p. 30)

Représentation interne d'un objet ou d'une situation en l'absence de perception directe.

D110 - Réalisme fortuit (fiche antérieure p. 30)

Dans le développement du dessin, attribution après coup d'une signification à une production initialement non prévue pour la représenter.

D111 - Réalisme intellectuel (fiche antérieure p. 30)

Mode de dessin montrant ce que l'enfant sait d'un objet plutôt que seulement ce qu'il en voit depuis un point de vue.

D112 - Sous-extension (fiche antérieure p. 30)

Utilisation d'un mot pour une partie trop restreinte de la catégorie qu'il désigne.

D113 - Sur-extension (fiche antérieure p. 30)

Utilisation d'un mot pour une catégorie trop large par rapport à son sens partagé.

D114 - Pragmatique du langage (fiche antérieure p. 30)

Usage du langage dans une situation de communication, selon le but, l'interlocuteur et le contexte.

D115 - Capacité métasyntaxique (fiche antérieure p. 30)

Capacité à réfléchir sur les règles d'organisation grammaticale des phrases.

D116 - Voie phonologique / assemblage (fiche antérieure p. 30)

Traitement de l'écrit reposant sur les correspondances entre unités écrites et unités sonores.

D117 - Voie lexicale / orthographique (fiche antérieure p. 30)

Identification de mots écrits connus à partir de représentations orthographiques mémorisées.

D118 - Dyslexie (fiche antérieure p. 30)

Trouble durable de l'apprentissage de la lecture, qui demande une évaluation spécialisée et ne se réduit pas à un test isolé.

D119 - Dysorthographie (fiche antérieure p. 30)

Trouble durable de l'acquisition et de l'utilisation de l'orthographe.

D120 - Dyscalculie (fiche antérieure p. 30)

Trouble durable des apprentissages numériques et du calcul, à apprécier dans une évaluation globale.

D121 - Trouble du langage oral (fiche antérieure p. 30)

Difficultés persistantes de compréhension ou d'expression orales avec retentissement ; l'ancienne appellation « dysphasie » est évoquée dans le cours.

D122 - Résignation apprise (fiche antérieure p. 30)

Attente que ses actions ne modifieront plus les résultats, pouvant se construire lors d'expériences répétées d'impuissance ou d'échec.

D123 - Égocentrisme cognitif (fiche antérieure p. 30)

Difficulté à distinguer et coordonner son point de vue avec celui d'autrui, dans le modèle piagétien.

D124 - Décentration (fiche antérieure p. 30)

Capacité à considérer plusieurs dimensions ou points de vue au lieu de rester centré sur un seul.

D125 - Animisme (fiche antérieure p. 30)

Attribution de vie ou d'intentions à des objets ou phénomènes, dans la description piagétienne de la pensée enfantine.

D126 - Artificialisme (fiche antérieure p. 31)

Idée que les phénomènes et les choses sont fabriqués par l'homme, dans le modèle présenté.

D127 - Réalisme enfantin (fiche antérieure p. 31)

Tendance à traiter des phénomènes mentaux, comme les rêves, comme s'ils possédaient une réalité matérielle extérieure.

D128 - Réversibilité logique (fiche antérieure p. 31)

Capacité à concevoir mentalement l'annulation ou la compensation d'une transformation.

Index alphabétique

D129 - Conservation (fiche antérieure p. 31)
Compréhension qu'une propriété demeure identique malgré une transformation d'apparence qui ne la modifie pas.

D130 - Opérations infralogiques (fiche antérieure p. 31)
Opérations structurant les propriétés et les relations internes des objets, notamment leurs aspects spatiaux et physiques, chez Piaget.

D131 - Opérations logico-mathématiques (fiche antérieure p. 31)
Opérations structurant les rapports entre objets ou classes : classification, inclusion, ordre et nombre.

D132 - Classification / inclusion (fiche antérieure p. 31)
Organisation en classes et sous-classes, avec compréhension de l'appartenance d'une partie à un ensemble plus vaste.

D133 - Sériation (fiche antérieure p. 31)
Mise en ordre d'éléments selon une relation, par exemple du plus petit au plus grand.

D134 - Transitivité (fiche antérieure p. 31)
Possibilité de déduire une relation à partir de deux autres : si A > B et B > C, alors A > C.

D135 - Théorie de l'esprit (fiche antérieure p. 31)
Capacité à attribuer des états mentaux à soi-même et à autrui pour comprendre et anticiper les conduites.

D136 - Fausse croyance (fiche antérieure p. 31)
Représentation tenue pour vraie par une personne alors qu'elle ne correspond pas à la réalité connue de l'observateur.

D137 - Croyance du second ordre (fiche antérieure p. 31)
Représentation de ce qu'une personne croit concernant l'état mental d'une autre : « il croit qu'elle pense que… ».

D138 - Contagion émotionnelle (fiche antérieure p. 31)
Résonance affective dans laquelle l'émotion exprimée par autrui déclenche une réaction émotionnelle, sans supposer à elle seule une prise de perspective élaborée.

D139 - Empathie - psychologie du développement (fiche antérieure p. 31)
Capacité à comprendre ou partager certains aspects de l'expérience affective d'autrui en conservant une distinction entre soi et l'autre.

D140 - Cognition sociale (fiche antérieure p. 31)
Ensemble des processus permettant de percevoir, comprendre et interpréter les informations et relations sociales.

D141 - Socialisation (fiche antérieure p. 31)
Processus d'apprentissage et d'appropriation des normes, valeurs, rôles et pratiques permettant la participation à la vie sociale.

D142 - Hétéronomie (fiche antérieure p. 31)
Situation dans laquelle la règle est reçue d'une autorité extérieure au sujet.

D143 - Autonomie (fiche antérieure p. 31)
Capacité progressive à se déterminer et à s'approprier les règles, compatible avec le recours à des soutiens.

D144 - Adolescence (fiche antérieure p. 32)
Période de remaniements corporels, affectifs, cognitifs et sociaux liée notamment aux transformations pubertaires et au passage vers des rôles adultes.

D145 - Puberté (fiche antérieure p. 32)
Transformations biologiques conduisant à la maturation sexuelle et reproductive, distinctes de la maturité psychique et légale.

D146 - Image du corps (fiche antérieure p. 32)
Ensemble des représentations et vécus subjectifs concernant son propre corps.

D147 - Identité (fiche antérieure p. 32)
Sentiment d'être soi, singulier et suffisamment cohérent à travers le temps et les changements, en relation avec autrui et les appartenances.

D148 - Moratoire identitaire (fiche antérieure p. 32)
Dans le modèle de Marcia, exploration active de possibilités identitaires sans engagements encore stabilisés.

D149 - Pensée hypothético-déductive (fiche antérieure p. 32)
Raisonnement qui pose des hypothèses, en déduit des conséquences et peut les confronter aux faits.

D150 - Combinatoire (fiche antérieure p. 32)
Exploration organisée de différentes combinaisons possibles d'éléments ou de propositions.

D151 - Logique des propositions (fiche antérieure p. 32)
Étude des relations entre énoncés au moyen d'opérateurs comme négation, conjonction ou implication.

D152 - INRC (fiche antérieure p. 32)
Groupe de transformations piagétien : Identité, Négation, Réciproque et Corrélative ; articulation de transformations réversibles.

D153 - Introspection (fiche antérieure p. 32)
Examen de ses propres pensées, sentiments et expériences internes.

Index alphabétique

D154 - Argumentation (fiche antérieure p. 32)
Organisation de raisons destinées à soutenir ou discuter une proposition, en tenant compte des objections et de l'interlocuteur.

D155 - Illettrisme (fiche antérieure p. 32)
Maîtrise insuffisante de l'écrit dans les situations ordinaires chez une personne qui a été scolarisée.

D156 - Analphabétisme (fiche antérieure p. 32)
Absence d'apprentissage initial de la lecture et de l'écriture.

D157 - Allophonie (fiche antérieure p. 32)
Situation d'une personne dont la langue première est différente de celle du milieu considéré ; ce n'est pas un trouble.

D158 - Dilemme moral (fiche antérieure p. 32)
Situation dans laquelle plusieurs exigences ou valeurs entrent en conflit et rendent la décision problématique.

D159 - Morale préconventionnelle (fiche antérieure p. 32)
Dans le modèle de Kohlberg, raisonnement centré sur la punition, la récompense et l'intérêt individuel.

D160 - Morale conventionnelle (fiche antérieure p. 32)
Dans le modèle de Kohlberg, raisonnement fondé sur les attentes des groupes, les règles et l'ordre social.

D161 - Morale postconventionnelle (fiche antérieure p. 32)
Dans le modèle de Kohlberg, examen des règles selon des droits, un contrat social ou des principes éthiques universalisables.

D162 - Estime de soi (fiche antérieure p. 32)
Évaluation affective que le sujet porte sur lui-même et sur sa valeur.

D163 - Sentiment d'efficacité personnelle (fiche antérieure p. 33)
Croyance en sa capacité à organiser et réaliser les actions requises dans une situation.

D164 - Lieu de contrôle interne (fiche antérieure p. 33)
Tendance à attribuer les résultats aux actions ou capacités du sujet plutôt qu'aux seules forces extérieures.

D165 - Autonomie comportementale (fiche antérieure p. 33)
Possibilité de prendre certaines décisions et de réaliser des actions sans autorisation parentale à chaque occasion.

D166 - Clique / bande (fiche antérieure p. 33)
Dans le modèle présenté, petit groupe de proches puis groupe plus large de pairs ; descriptions de sociabilité et non étapes obligatoires.

D167 - Refus scolaire anxieux (fiche antérieure p. 33)
Difficulté à fréquenter l'école liée à une détresse anxieuse, dont les mécanismes et le contexte doivent être explorés.

D168 - Narcissisme (fiche antérieure p. 33)
Dans le sens psychanalytique du cours, investissement du Moi et de l'image de soi, distinct d'un jugement courant d'égoïsme.

D169 - Finitude (fiche antérieure p. 33)
Condition d'un être dont l'existence est limitée et mortelle.

D170 - Deuil (fiche antérieure p. 33)
Ensemble des réactions et du remaniement psychique consécutifs à une perte significative ; son évolution varie et ne suit pas une séquence obligatoire.

D171 - Régression (fiche antérieure p. 33)
Recours à des modes de fonctionnement ou de relation antérieurs face à une difficulté, dans la lecture psychodynamique.

D172 - Déni (fiche antérieure p. 33)
Refus inconscient de reconnaître un aspect de réalité vécu comme trop éprouvant, dans le modèle psychanalytique.

D173 - Dénégation (fiche antérieure p. 33)
Expression d'un contenu de pensée accompagnée du refus de le reconnaître comme sien.

D174 - Mémoire (fiche antérieure p. 33)
Ensemble des capacités d'encodage, de conservation et de récupération des informations et connaissances.

Extrait du support officiel, p. 34 : « La mémoire est la capacité du cerveau d'enregistrer, de stocker et de récupérer des connaissances acquises »
Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 34.

D175 - Encodage / stockage / récupération (fiche antérieure p. 33)
Traitement initial de l'information / maintien de traces / accès ultérieur à l'information mémorisée.

D176 - Mémoire sensorielle (fiche antérieure p. 33)
Maintien très bref d'informations sensorielles, dont la durée dépend de la modalité.

D177 - Mémoire à court terme (fiche antérieure p. 33)
Maintien temporaire d'une quantité limitée d'informations.

Index alphabétique

D178 - Mémoire de travail (fiche antérieure p. 33)

Maintien et manipulation d'informations nécessaires à une activité en cours.

D179 - Mémoire à long terme (fiche antérieure p. 33)

Conservation durable de connaissances et d'expériences, selon plusieurs systèmes.

D180 - Mémoire déclarative (fiche antérieure p. 33)

Mémoire de contenus accessibles à un rappel conscient, comprenant notamment les mémoires épisodique et sémantique.

Extrait du support officiel, p. 34 : « Mémoire qui correspond au rappel conscient et volontaire de connaissances anciennes »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 34.

D181 - Mémoire épisodique (fiche antérieure p. 33)

Mémoire d'événements personnellement vécus et situés dans un contexte temporel et spatial.

Extrait du support officiel, p. 34 : « regroupe des représentations d'événements temporellement datées (événements ou épisodes personnellement vécus) »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 34.

D182 - Mémoire sémantique (fiche antérieure p. 34)

Mémoire des connaissances générales, du sens des mots et des concepts.

Extrait du support officiel, p. 34 : « regroupe les connaissances générales nécessaires à la production et la compréhension linguistique (mots, symboles verbaux, significations, référents, etc.) »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 34.

D183 - Mémoire non déclarative (fiche antérieure p. 34)

Ensemble de formes de mémoire s'exprimant sans rappel conscient nécessaire, dont la mémoire procédurale.

Extrait du support officiel, p. 34 : « Mémoire qui correspond à la répercussion inconsciente d'expériences anciennes »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 34.

D184 - Mémoire procédurale (fiche antérieure p. 34)

Mémoire des habiletés et savoir-faire progressivement automatisés.

D185 - Rappel / reconnaissance (fiche antérieure p. 34)

Retrouver une information sans qu'elle soit présentée / identifier une information parmi des éléments proposés.

D186 - Intelligence fluide (fiche antérieure p. 34)

Capacités de raisonnement et de résolution de problèmes nouveaux, relativement indépendantes des connaissances apprises.

D187 - Intelligence cristallisée (fiche antérieure p. 34)

Capacités s'appuyant sur les connaissances et l'expérience accumulées.

D188 - Plainte mnésique (fiche antérieure p. 34)

Difficulté de mémoire rapportée par la personne, qui ne suffit pas à établir une pathologie.

D189 - Anosognosie (fiche antérieure p. 34)

Méconnaissance par la personne de ses troubles, liée à son fonctionnement pathologique, distincte d'un simple refus volontaire.

D190 - Trouble neurocognitif majeur (fiche antérieure p. 34)

Déclin acquis significatif d'un ou plusieurs domaines cognitifs compromettant l'autonomie ; la mémoire n'est pas nécessairement atteinte en premier.

D191 - Dépression (fiche antérieure p. 34)

Trouble associant notamment une humeur dépressive ou une perte d'intérêt durable, avec d'autres manifestations et un retentissement ; elle ne se réduit pas à une tristesse ponctuelle.

D192 - Apraxie (fiche antérieure p. 34)

Trouble de la réalisation de gestes appris, non expliqué par une simple faiblesse motrice ou une incompréhension de la consigne.

D193 - Aidant (fiche antérieure p. 34)

Personne de l'entourage apportant une aide régulière à un proche dans sa vie quotidienne ou ses soins.

D194 - Infantilisation (fiche antérieure p. 34)

Manière de traiter un adulte comme un enfant, en négligeant sa dignité, ses choix ou ses capacités préservées.

D195 - Relation d'attachement chez l'adulte et réciprocité

Chez l'adulte, une relation d'attachement peut fournir une base de sécurité réciproque : chacun peut donner et recevoir soutien et attention. Le partenaire est investi comme une personne singulière, non interchangeable, dont la proximité est recherchée. Le recours à cette base s'appuie notamment sur les échanges verbaux et les représentations du lien.

Extrait du support officiel, p. 33 : « lien affectif durable au sein duquel le partenaire est conçu comme unique, non interchangeable et dont on désire la proximité »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

À distinguer : La réciprocité entre adultes se distingue de la relation de dépendance du jeune enfant à son caregiver.

Index alphabétique

D196 - Style d'attachement chez l'adulte

Organisation relativement systématisée des attentes, besoins, émotions, stratégies de régulation et comportements sociaux dans les relations d'attachement. Elle se construit à partir des expériences relationnelles et influence la manière d'attendre ou de rechercher la disponibilité et le soutien d'autrui.

Extrait du support officiel, p. 33 : « patterns systématisés d'attentes/besoins/émotions/stratégies de régulation émotionnelle/comportements sociaux »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

À distinguer : Ne pas déduire un style d'attachement adulte d'une seule phrase ni le confondre avec une catégorie observée chez le bébé.

D197 - Attachement symbolique chez le sujet âgé

Appui sur les représentations et les souvenirs des liens d'attachement pour trouver du soutien et du réconfort, notamment lorsque les figures d'attachement ne sont plus présentes. Les objets familiers, les photographies et les lieux peuvent contribuer au maintien de repères liés à l'histoire et aux relations de la personne.

Extrait du support officiel, p. 33 : « l'évocation des souvenirs suffit à apporter soutien et réconfort »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

À distinguer : Formulation de révision accompagnée d'un extrait du support officiel, p. 33.

D198 - Attachement chez le sujet âgé

Les besoins d'attachement persistent au cours du vieillissement. La vulnérabilité, la dépendance et les situations de détresse peuvent les réactiver. Le conjoint, la fratrie, les amis et les enfants adultes peuvent être des figures importantes ; les pertes et les séparations modifient les appuis disponibles.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

D199 - Attachement et troubles neurocognitifs

Les besoins d'attachement et la fonction de réconfort du lien peuvent persister malgré la détérioration cognitive. Une relation régulière et des repères familiers peuvent soutenir le sentiment de sécurité, même lorsque la personne confond l'identité de celui qui s'occupe d'elle.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

À distinguer : Le support emploie « personne démente ». Ne pas confondre difficulté de reconnaissance et disparition des besoins relationnels.

D200 - Besoin primaire de proximité

Dans la théorie de l'attachement présentée dans le cours, le jeune enfant recherche la proximité d'une figure familière pour obtenir protection, sécurité et réconfort. Le lien d'attachement ne se réduit pas à la satisfaction de la faim.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D201 - Besoin primaire de contact

Besoin de contact physique, tactile et thermique pouvant procurer du réconfort. Dans les expériences de Harlow présentées dans le cours, le contact avec un support doux ne se confond pas avec la seule délivrance de nourriture.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 16.

À distinguer : Résultat d'un modèle animal présenté dans le cours ; ne pas le transposer directement à toute relation humaine.

D202 - Proximité dans l'attachement

Maintien ou recherche d'un accès à la figure d'attachement, particulièrement en situation de détresse. Ses modalités évoluent : contact et présence physique chez le jeune enfant, mais aussi échanges et représentations du lien plus tard.

Extrait du support officiel, p. 17 : « notion spatiale, distance entre l'enfant et la figure d'attachement qui peut être modulée en fonction des besoins de l'enfant »

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 17.

D203 - Norme idéale

Repère de normalité fondé sur un état jugé souhaitable ou valorisé ; il ne se confond pas avec ce qui est fréquent ni avec l'absence de maladie.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D204 - Normalité comme absence de maladie

Lecture du normal définie par l'absence de maladie identifiée, distincte des lectures statistique, sociale et idéale.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D205 - Prévalence

Nombre de cas existants d'une maladie dans une population à un moment donné ou sur une période déterminée ; exprimée en proportion, elle rapporte ces cas à la population considérée.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D206 - Incidence

Survenue de nouveaux cas d'une maladie dans une population pendant une période définie ; elle se distingue de la prévalence des cas existants.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D207 - Étiologie

Étude des causes et facteurs à l'origine d'une maladie.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D208 - Pathogénie

Étude des mécanismes par lesquels une maladie apparaît et se développe.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

Index alphabétique

D209 - Lecture professionnelle du pathologique

Dans la typologie du cours, désignation d'un état comme pathologique par un professionnel, notamment médecin ou psychologue.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D210 - Lecture existentialiste du pathologique

Dans la typologie du support, approche mettant l'accent sur la modification de l'environnement plutôt que sur celle de l'individu.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D211 - Critères pratiques du pathologique

Trois critères cités dans le support : inconfort, bizarrerie et inefficacité. Leur appréciation est contextuelle ; aucun signe isolé ne suffit à établir une pathologie.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 4.

D212 - Style éducatif contractualiste

Style décrit dans le cours comme démocratique : règles présentes, expliquées et discutables, avec une place à la compréhension et à la négociation. Le support nomme les parents « contractualisés ».

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 25.

D213 - Style éducatif statutaire

Style décrit dans le cours comme autoritaire, fondé sur la position et l'autorité de l'adulte, laissant moins de place à la discussion des règles.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 25.

D214 - Style éducatif maternaliste

Style décrit comme protecteur et chaleureux, valorisant la cohésion familiale, avec une marge de décision de l'enfant plus limitée.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 25.

D215 - Famille bastion

Type de cohésion familiale évoqué dans le cours, privilégiant le collectif, l'unité et les activités communes. Il s'agit d'un repère descriptif et non d'un diagnostic familial.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 25.

D216 - Famille association

Type de cohésion familiale évoqué dans le cours, laissant davantage de place à l'individualisation et aux activités ou choix personnels. Ce repère ne suffit pas à caractériser une famille entière.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 25.

D217 - Construction opératoire du nombre

Dans le modèle piagétien présenté, articulation de l'inclusion des classes et de la relation d'ordre ; à distinguer de la récitation précoce de la suite des nombres.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 23.

D218 - Idéologie

Dans le chapitre de l'adolescence, raisonnement abstrait sur la politique, l'éducation ou la religion, prenant en compte l'évolution des idées et se référant à des principes généraux plutôt qu'à des opinions particulières.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 28.

D219 - Métatexte

Éléments qui accompagnent et organisent un texte, tels titres, notes ou indications, et contribuent à orienter sa lecture et sa compréhension.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 28.

D220 - Réciprocité de l'attachement adulte

Possibilité, au sein de la relation adulte, de fournir et de recevoir tour à tour soutien, attention et sécurité.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 33.

D221 - Continuité temporelle de l'identité

Sentiment de demeurer soi au fil du temps et des transformations, composante de la construction identitaire.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 31.

D222 - Cohésion et singularité identitaires

Sentiment d'être un sujet suffisamment unifié et cohérent, distinct des autres, malgré les remaniements et appartenances multiples.

Repère : N. Khatir, support officiel 2026, p. 31.

Index alphabétique

Psychologie de la santé

H001 - Psychologie de la santé (fiche p. 41)

La psychologie de la santé applique les connaissances psychologiques à l'étude de la santé et de la maladie et cherche à comprendre comment les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et comportementaux interviennent dans la prévention, le maintien de la santé, le vécu et l'évolution des problèmes de santé.

Attribution indiquée dans le cours : Matarazzo ; Bruchon-Schweitzer et Dantzer (1994). Deux définitions citées.

H002 - Santé - définition OMS citée (fiche p. 41)

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.

H003 - Santé perçue (fiche p. 41)

La santé perçue est l'appréciation globale qu'une personne porte elle-même sur son propre état de santé, en intégrant ses sensations, son fonctionnement, ses repères et sa situation.

H004 - Qualité de vie (fiche p. 41)

La qualité de vie est la perception qu'un individu a de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lequel il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes.

Attribution indiquée dans le cours : OMS (1994). Les deux paragraphes de définition sont conservés dans le passage ci-dessous.

H005 - Approche biopsychosociale (fiche p. 41)

L'approche biopsychosociale considère que la santé et la maladie résultent d'interactions entre des dimensions biologiques, psychologiques et sociales, et qu'aucune de ces dimensions ne suffit seule à résumer la situation de la personne.

H006 - Maladie (fiche p. 41)

La maladie est une altération de la santé comportant un ensemble de caractères définis : une cause, des signes et des symptômes, une évolution et des modalités thérapeutiques et pronostiques précises.

Attribution indiquée dans le cours : Nouveau Larousse Médical, sans date précisée.

H007 - Disease (fiche p. 41)

Le terme disease désigne la dimension biomédicale de la maladie, c'est-à-dire l'atteinte, les mécanismes et les signes objectivables étudiés par la médecine.

H008 - Illness (fiche p. 42)

Le terme illness désigne l'expérience subjective de la maladie, c'est-à-dire la manière dont une personne ressent, interprète et vit ce qui lui arrive.

H009 - Sickness (fiche p. 42)

Le terme sickness désigne la dimension sociale de la maladie, c'est-à-dire la manière dont un trouble est reconnu, interprété et traité dans l'environnement culturel, familial et social.

H010 - Maladie chronique (fiche p. 42)

Une maladie chronique est une affection rarement guérissable qui nécessite une prise en charge prolongée, souvent durable, afin d'en limiter les effets, d'en compenser certaines conséquences ou d'en accompagner l'évolution.

Attribution indiquée dans le cours : HAS (2014).

H011 - Handicap (fiche p. 42)

Est handicapée toute personne dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l'effet de l'âge ou d'un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l'école ou à occuper un emploi s'en trouvent compromises.

Attribution indiquée dans le cours : OMS, sans date précisée dans le support.

H012 - Représentations de la maladie (fiche p. 42)

Les représentations de la maladie sont les croyances et explications personnelles, souvent implicites, qu'un individu construit concernant la cause, l'identité, la durée, les conséquences et les possibilités de contrôle ou de traitement de sa maladie.

H013 - Théorie profane (fiche p. 42)

Une théorie profane est une explication personnelle de la maladie élaborée par la personne malade ou son entourage, à partir de leurs expériences, de leurs valeurs et de leurs croyances, indépendamment de la validité médicale de cette explication.

H014 - Facteur de risque (fiche p. 42)

Un facteur de risque est une caractéristique ou une situation associée à une probabilité plus élevée de rencontrer un problème de santé ; sa présence ne suffit pas, à elle seule, à déterminer l'apparition d'une maladie.

H015 - Facteur de protection (fiche p. 43)

Un facteur de protection est une caractéristique individuelle ou environnementale qui contribue à réduire un risque ou à favoriser les ressources d'adaptation face à une situation défavorable.

H016 - Facteur salutogène (fiche p. 43)

Un facteur salutogène est un élément personnel, relationnel ou environnemental qui favorise le maintien de la santé, le bien-être ou les capacités d'ajustement d'une personne.

Index alphabétique

H017 - Douleur - formulation historique IASP 1979 (fiche p. 44)

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en des termes évoquant une telle lésion ; le cours souligne sa dimension personnelle et le fait qu'une lésion objectivable n'est pas indispensable à son existence.

H018 - Douleur - formulation IASP 2020 (fiche p. 44)

La douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.

H019 - Douleur chronique (fiche p. 44)

Une douleur chronique est une douleur qui persiste ou réapparaît pendant plus de trois mois ; elle est multifactorielle et peut associer des dimensions biologiques, psychologiques et sociales.

Attribution indiquée dans le cours : OMS, sans date précisée dans le support.

H020 - Souffrance (fiche p. 44)

La souffrance qualifie un être qui supporte, endure ou subit une douleur physique et morale, un état de mal-être, c'est-à-dire un sentiment de non-adaptation au monde, d'étrangeté aux êtres et aux choses, d'indifférence douloureuse.

Attribution indiquée dans le cours : OMS, attribution du support sans date précisée.

H021 - Souffrance psychique (fiche p. 44)

La souffrance psychique est un état de mal-être qui peut survenir dans une situation éprouvante sans remplir nécessairement les critères d'un trouble psychiatrique caractérisé.

Attribution indiquée dans le cours : HAS, sans date précisée dans le support.

H022 - Douleur morale (fiche p. 44)

La douleur morale est un terme de la sémiologie psychiatrique qui correspond à un état de détresse observé dans les dépressions profondes, notamment mélancoliques, lorsque les sensations pénibles, le désespoir et la perte d'intérêt deviennent particulièrement intenses.

H023 - Plainte (fiche p. 44)

La plainte est l'expression adressée à autrui d'un trouble, d'une gêne, d'une douleur ou d'une souffrance, telle que la personne la perçoit et peut la mettre en mots ou en comportements.

H024 - Douleur du membre fantôme (fiche p. 45)

La douleur du membre fantôme est une douleur que la personne peut ressentir comme provenant d'un membre amputé, bien que ce membre ne soit plus présent ; elle illustre les perturbations possibles du vécu et des représentations corporelles.

H025 - Approche psychosomatique (fiche p. 45)

L'approche psychosomatique est une approche clinique globale qui cherche à relier les dimensions psychiques et somatiques de la personne, en tenant compte de son histoire, de ses relations et de ses conditions de vie, sans réduire une maladie à une cause uniquement mentale.

H026 - Événement de vie (fiche p. 46)

Un événement de vie est un changement extérieur à la personne, relativement rapide et suffisamment important pour créer une discontinuité dans son existence et mobiliser ses capacités d'adaptation.

H027 - Difficulté de vie (fiche p. 46)

Une difficulté de vie est une situation problématique persistante durant au moins quatre semaines.

H028 - Tracas quotidiens (fiche p. 46)

Les tracas quotidiens sont des incidents ou difficultés de faible intensité qui, par leur fréquence ou leur accumulation, peuvent participer à la charge de stress ressentie.

H029 - Échelle de Holmes et Rahe (fiche p. 46)

L'échelle de Holmes et Rahe est un outil historique qui attribue un poids de réajustement à différents événements de vie pour estimer une charge de changements ; son score ne permet pas de prédire avec certitude l'apparition d'une maladie chez une personne.

H030 - Soutien social - sens général (fiche p. 46)

Le soutien social renvoie à l'ensemble des aides que des individus dispensent et reçoivent de leur entourage familial, amical, de voisinage ou institutionnel. Il comprend des formes diverses d'aide matérielle, informationnelle, morale ou affective.

H031 - Réseau social (fiche p. 46)

Le réseau social est l'ensemble des personnes avec lesquelles un individu est en relation.

H032 - Soutien social reçu (fiche p. 46)

Le soutien social reçu désigne les caractéristiques observables et les aides effectivement reçues d'autrui, que l'on peut décrire notamment par les relations et ressources présentes dans l'entourage de la personne.

Index alphabétique

H033 - Soutien social perçu (fiche p. 46)

Le soutien social perçu correspond à l'appréciation subjective que la personne porte sur la disponibilité, la pertinence et la qualité de l'aide qu'elle pense pouvoir recevoir de son entourage.

H034 - Vulnérabilité (fiche p. 47)

La vulnérabilité se définit par un état de moindre résistance aux nuisances et agressions ; ce concept évoque des faiblesses patentes ou latentes, immédiates ou différées, et peut être compris comme une incapacité ou une difficulté à résister aux contraintes de l'environnement.

H035 - Résilience - approche psychologique générale (fiche p. 47)

En psychologie, la résilience désigne globalement un processus qui permet de sortir vainqueur d'une épreuve traumatique et de continuer à se construire malgré l'adversité ; elle suppose récupération après un traumatisme, réorganisation psychique et transformation à travers les épreuves.

H036 - Résilience - Rutter (1985) (fiche p. 47)

Capacité pour des individus ayant subi des événements de vie très aversifs, ou même dramatiques, d'arriver à mener une vie normale. Les sujets résilients sont capables de développer, dans des circonstances parfois très difficiles, des stratégies d'ajustement adéquates qui les protègent.

H037 - Résilience - Boris Cyrulnik (fiche p. 47)

La résilience définit la capacité à se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants.

H038 - Personnalité (fiche p. 47)

La personnalité désigne l'organisation relativement durable des manières de percevoir, de ressentir, de penser et de se comporter qui contribuent à la singularité d'un individu.

H039 - Hostilité (fiche p. 47)

L'hostilité regroupe des dimensions cognitives, émotionnelles et comportementales telles que le cynisme, les attributions hostiles, la colère, la méfiance et les réactions agressives.

Attribution indiquée dans le cours : Haney et al. (1996), référence d'une étude citée dans l'encadré S2 p. 43 ; la définition textuelle de l'hostilité n'est pas attribuée séparément.

H040 - Type de personnalité A (fiche p. 47)

Le type A désigne, dans les modèles historiques présentés, un profil marqué notamment par l'impatience, la compétitivité et parfois l'hostilité ; les associations avec la maladie coronarienne ont été discutées et nuancées.

H041 - Type de personnalité C (fiche p. 48)

Le type C renvoie à un profil d'adaptation historiquement décrit par l'inhibition des émotions négatives et la conciliation ; son association supposée au cancer ne constitue pas une causalité médicale démontrée.

H042 - Optimisme (fiche p. 48)

L'optimisme est une tendance cognitive relativement générale à anticiper des issues favorables et à percevoir positivement les possibilités futures.

H043 - Lieu de contrôle (fiche p. 48)

Le lieu de contrôle correspond à la croyance générale que les événements dépendent principalement de facteurs internes, liés à ses actions, ou de facteurs externes, comme le hasard et l'influence d'autrui.

H044 - Auto-efficacité (fiche p. 48)

L'auto-efficacité est la croyance qu'une personne peut mobiliser ses ressources et conduire les actions requises pour réussir une tâche ou surmonter une situation.

H045 - Stress biologique - Selye (1936) (fiche p. 49)

Le stress, ou syndrome général d'adaptation selon Selye, est une réponse biologique de l'organisme à un événement de vie d'ordre physique, psychique ou émotionnel, positif ou négatif.

H046 - Stress perçu (fiche p. 49)

Le stress perçu correspond à l'évaluation faite par l'individu d'un événement comme menaçant ou non pour son bien-être physique et/ou psychologique.

H047 - Stress transactionnel (fiche p. 49)

Le stress signifie ici une relation entre la personne et son environnement, qui est évaluée par la personne comme tarissant ou excédant ses ressources et menaçant son bien-être.

Attribution indiquée dans le cours : Lazarus et Folkman (1984).

H048 - Évaluation primaire (fiche p. 49)

L'évaluation primaire est l'opération cognitive par laquelle une personne détermine ce que représente une situation pour elle, notamment une menace, une perte ou un défi.

H049 - Évaluation secondaire (fiche p. 49)

L'évaluation secondaire est l'opération cognitive par laquelle une personne apprécie les ressources et les possibilités d'action qu'elle estime disposer pour faire face à une situation.

H050 - Contrôle perçu (fiche p. 49)

Le contrôle perçu correspond à la représentation que se fait une personne de sa possibilité d'agir sur un événement, ses causes, son déroulement, ses conséquences ou ses propres réactions.

Index alphabétique

H051 - Coping / stratégies d'ajustement (fiche p. 49)

Le coping désigne les efforts cognitifs et comportementaux qu'une personne met en œuvre pour faire face à une situation évaluée comme stressante ou dépassant ses ressources habituelles.

H052 - Coping centré sur le problème (fiche p. 49)

Le coping centré sur le problème vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face, notamment par la recherche d'informations, la résolution de problèmes, la planification et l'action directe.

H053 - Coping centré sur l'émotion (fiche p. 50)

Le coping centré sur l'émotion vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la situation, en détournant son attention, en réinterprétant positivement l'événement, en minimisant les conséquences ou en évitant temporairement la situation.

H054 - Coping centré sur le soutien social (fiche p. 50)

Le coping centré sur la recherche de soutien social rassemble les efforts effectués pour obtenir la sympathie, l'écoute, les informations ou l'aide matérielle et pratique d'autrui.

H055 - Angoisse (fiche p. 51)

L'angoisse est une peur sans objet, ou du moins sans objet extérieur défini, qui exprime la souffrance de l'appareil psychique face à une menace intérieure. Elle peut signaler un débordement et déclencher des mécanismes de défense.

H056 - Mécanismes de défense (fiche p. 51)

Les mécanismes de défense sont produits de manière inconsciente ; ils regroupent ce que le psychisme met en place lorsque la réalité est insupportable, afin de se protéger contre l'angoisse et de maintenir un certain équilibre. Face à un événement traumatique, ils peuvent laisser à la personne du temps pour intégrer ce qu'elle vit.

Attribution indiquée dans le cours : Concept rattaché par le support à la théorie psychanalytique, particulièrement Anna Freud (p. 14). Définition p. 17 non attribuée individuellement.

H057 - Déni (fiche p. 51)

Le déni est l'action de refuser la réalité d'une perception vécue comme dangereuse ou douloureuse pour le moi.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H058 - Projection (fiche p. 51)

La projection est une opération par laquelle le sujet expulse dans le monde extérieur des pensées, des affects ou des désirs qu'il méconnaît ou refuse en lui et qu'il attribue à d'autres personnes ou choses de son environnement.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H059 - Projection agressive (fiche p. 51)

La projection agressive peut se manifester par des réactions agressives et revendicatrices du patient, sous forme de reproches, de plaintes ou d'insatisfaction orientés vers l'extérieur face à la maladie.

H060 - Régression (fiche p. 51)

La régression constitue un retour à des modes d'expression antérieurs de la pensée, des conduites ou des relations objectales, face à un danger interne ou externe susceptible de provoquer un excès d'angoisse ou de frustration.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H061 - Rationalisation (fiche p. 51)

La rationalisation est une justification logique, mais artificielle, qui camoufle, à l'insu de celui qui l'utilise, les vrais motifs irrationnels et inconscients de certains de ses jugements, conduites ou sentiments, car ces motifs ne pourraient être reconnus sans anxiété.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H062 - Refoulement (fiche p. 52)

Le refoulement est le rejet dans l'inconscient de représentations conflictuelles qui demeurent actives tout en étant inaccessibles à la prise de conscience. Le retour du refoulé peut intervenir lorsque le refoulement échoue ou devient insuffisant.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H063 - Déplacement (fiche p. 52)

Le déplacement est la généralisation ou le déplacement d'un problème vers un autre objet habituellement moins menaçant : l'affect et le sentiment restent reconnus et exprimés, mais ils sont redirigés vers une cible moins conflictuelle, bien que de même nature.

Attribution indiquée dans le cours : Perry, Guelfi, Despland, Hanin, Lamas (2009), Mécanismes de défense principes et échelles d'évaluation, 2e édition, Masson.

Index alphabétique

H064 - Isolation (fiche p. 52)

L'isolation désigne une élimination de l'affect lié à une représentation conflictuelle (souvenirs, idées ou pensées), alors que la représentation en question reste consciente.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H065 - Dénégation (fiche p. 52)

La dénégation est le refus de reconnaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une pensée, un désir ou un sentiment qui sont source de conflit.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H066 - Maîtrise (fiche p. 52)

La maîtrise vise à diminuer l'angoisse liée à l'incertitude de la maladie à travers la restauration d'un sentiment de contrôle sur la situation ; la personne veut agir sur sa propre histoire et sur la maladie en croyant pouvoir en contrôler le processus.

H067 - Retrait apathique (fiche p. 52)

Le retrait apathique est un détachement protecteur, fait d'indifférence affective, de restriction des relations sociales et des activités extérieures, et de soumission passive aux événements, qui permet à une personne de supporter une situation très difficile.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H068 - Activisme (fiche p. 52)

L'activisme consiste à gérer les conflits psychiques ou les situations traumatiques externes par le recours à l'action, à la place de la réflexion ou du vécu des affects.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H069 - Combativité (fiche p. 53)

La combativité est une forme d'activisme qui neutralise l'angoisse et le désarroi du malade en suscitant une énergie importante lui permettant de dépasser la maladie et de se dépasser lui-même.

H070 - Affiliation - mécanisme de défense (fiche p. 53)

L'affiliation est la recherche de l'aide et du soutien d'autrui quand on vit une situation qui engendre de l'angoisse. Dans ce chapitre, elle désigne un mécanisme de défense, et non le concept distinct d'affiliation en psychologie sociale.

H071 - Humour - mécanisme de défense (fiche p. 53)

L'humour est un processus qui consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques ou insolites. C'est uniquement l'humour appliqué à soi-même qui peut être considéré comme un mécanisme de défense.

H072 - Sublimation (fiche p. 53)

La sublimation peut renvoyer à la désexualisation d'une pulsion qui se transforme en tendresse ou en amitié sans changer d'objet ; elle peut aussi désigner la dérivation de l'énergie d'une pulsion sexuelle ou agressive vers des activités socialement valorisées, notamment artistiques, intellectuelles ou morales.

Attribution indiquée dans le cours : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

H073 - Annonce du diagnostic (fiche p. 54)

L'annonce du diagnostic est l'acte médical par lequel un médecin fait part à un patient du diagnostic d'une pathologie aiguë ou chronique, ou d'un handicap. L'annonce du diagnostic est toujours un choc psychologique, une épreuve, un bouleversement et un traumatisme pour le patient et ses proches, au sens où cette annonce fait effraction dans le psychisme.

H074 - Corps-objet (fiche p. 54)

Le corps-objet désigne le corps que la médecine peut observer et étudier scientifiquement, notamment par l'anatomie, la physiologie et l'étude de ses organes.

H075 - Corps-sujet (fiche p. 54)

Le corps-sujet est le corps singulier vécu par la personne, indissociable du psychisme, du langage, de son histoire et de sa relation à autrui.

H076 - Schéma corporel (fiche p. 54)

Le schéma corporel est l'organisation des repères sensoriels, moteurs et posturaux qui permet à une personne de se situer, de percevoir et de mobiliser son corps dans l'espace et dans l'action.

H077 - Image du corps (fiche p. 54)

L'image du corps est la représentation subjective, psychique et affective qu'une personne construit de son propre corps, de son apparence et de sa valeur corporelle au regard de son histoire et des relations avec autrui.

Attribution indiquée dans le cours : Paul Schilder (1935) pour la deuxième définition ; première formulation non attribuée dans le support.

H078 - Identité corporelle (fiche p. 54)

L'identité corporelle désigne le sentiment d'être soi dans et avec son corps et de conserver une continuité de soi malgré les transformations, les expériences et les perceptions corporelles.

Index alphabétique

H079 - Conscience de soi (fiche p. 54)

La conscience de soi consiste à être conscient que l'on existe en tant qu'être humain distinct de son entourage.

Psychologie sociale

S001 - Psychologie sociale (fiche p. 16)

Discipline qui étudie les interactions entre l'individu et la société, ainsi que la dimension sociale des processus mentaux et des comportements. Elle analyse comment autrui, les groupes et les institutions influencent nos conduites.

S002 - Lien social (fiche p. 16)

Ensemble des relations et des échanges qui inscrivent une personne dans un tissu social préexistant et orientent sa sociabilité, ses actions et sa place parmi les autres.

S003 - Affiliation (fiche p. 16)

Ensemble des conduites par lesquelles une personne établit des liens avec autrui et cherche à pouvoir compter sur les autres. En psychologie sociale, elle traduit la dimension sociale de l'existence et le besoin d'appartenance.

S004 - Interdépendance (fiche p. 16)

Situation dans laquelle chacun a besoin de la présence ou de l'action d'autrui pour poursuivre ses propres buts. Elle explique une partie de la coopération et de la formation des liens.

Attribution indiquée dans le cours : Wilson (1975) pour le modèle utilitaire présenté ; la définition n'est pas attribuée séparément.

S005 - Modèle utilitaire de l'affiliation (fiche p. 16)

Explication de la formation du lien social par la nécessité de coopérer pour atteindre des objectifs ou répondre à des besoins que l'individu ne satisfait pas seul.

S006 - Modèle de la cohésion sociale (fiche p. 16)

Explication de l'affiliation par l'attraction interpersonnelle : sympathie, attitudes positives et désir de proximité favorisent le rapprochement et la cohésion.

S007 - Attraction interpersonnelle (fiche p. 16)

Dimension affective d'une relation qui rend autrui attirant et donne envie de se rapprocher de lui. Elle peut reposer sur la sympathie, l'admiration ou des affinités et ne se réduit pas à l'attirance physique.

S008 - Modèle de l'identification sociale (fiche p. 17)

Explication de l'affiliation par un besoin de définir son identité en tant que membre d'un groupe. La personne adopte les caractéristiques qu'elle juge représentatives de ce groupe.

S009 - Prototype du groupe (fiche p. 17)

Ensemble des caractéristiques perçues comme les plus représentatives d'un groupe et utilisées comme repères pour se définir comme membre de celui-ci.

S010 - Attachement (fiche p. 17)

Lien affectif profond dans lequel les personnes prennent une importance particulière l'une pour l'autre. Les premiers attachements participent à la capacité ultérieure de se lier et de s'affilier.

Attribution indiquée dans le cours : Bowlby, Harlow et Spitz cités ; la phrase de définition n'est pas attribuée à un auteur unique.

S011 - Socialisation (fiche p. 17)

Processus d'apprentissage et d'intégration sociale par lequel une personne reçoit, apprend et s'approprie les normes, valeurs, rôles et modèles de conduite de ses milieux de vie.

S012 - Socialisation primaire (fiche p. 17)

Socialisation qui se déroule principalement pendant l'enfance, sous l'influence de la famille, de l'école, des pairs et des médias. Ces sources transmettent des messages selon des modalités différentes.

S013 - Socialisation secondaire (fiche p. 17)

Apprentissages sociaux qui se poursuivent après l'enfance lors de l'entrée dans de nouveaux rôles et milieux. Ils peuvent compléter ou transformer les habitudes antérieures.

S014 - Accordage affectif (fiche p. 17)

Ajustement réciproque des expressions, rythmes et intensités émotionnelles dans une interaction. Cette notion éclaire le caractère interactif des premiers échanges et de la socialisation.

S015 - Décentration (fiche p. 17)

Capacité à quitter son seul point de vue pour envisager celui d'autrui. Son développement contribue à comprendre la réciprocité et à ajuster ses relations sociales.

S016 - Pairs (fiche p. 18)

Personnes qui occupent une position comparable dans un contexte, notamment les camarades d'une même classe d'âge. Ils constituent une source de socialisation souvent informelle.

S017 - Besoins de sociabilité selon Schutz (fiche p. 18)

Trois besoins relationnels : inclusion, contrôle et affection. L'inclusion concerne le contact et la participation, le contrôle la sécurité et la place dans les relations, l'affection les liens affectifs.

S018 - Identité sociale (fiche p. 18)

Construction de soi liée aux interactions, aux appartenances, aux positions occupées et aux attentes attachées aux rôles. Elle résulte d'un processus actif d'évaluation, d'ajustement et de négociation avec autrui.

Attribution indiquée dans le cours : Mead (1934), Allport et Miller (1975) pour les conceptions successives présentées.

Index alphabétique

S019 - Soi (fiche p. 18)

Ensemble des caractéristiques qu'une personne considère comme siennes et auxquelles elle attribue une valeur socioaffective. Il répond à « qui suis-je ? » et comporte un sentiment de continuité.

Attribution indiquée dans le cours : Mead (1934) pour le modèle Ego et Je ; définition générale p. 4 sans attribution particulière.

S020 - Moi-objet (fiche p. 18)

Dans la présentation de Mead retenue ici, dimension du Soi construite par l'intériorisation des attitudes d'autrui envers soi. Le sujet se considère depuis le regard social.

S021 - Moi-sujet (fiche p. 18)

Dimension vécue du Soi : manière singulière dont la personne s'éprouve elle-même. le « Je » interagit avec le Moi-objet pour construire la conscience de soi.

S022 - Continuité temporelle de soi (fiche p. 18)

Sentiment d'être la même personne à travers le temps malgré les changements de situation, de corps ou de rôle. C'est l'un des facteurs de cohérence identitaire présentés avec Allport.

S023 - Estime de soi (fiche p. 18)

Évaluation de la valeur que l'on s'accorde, notamment en relation avec autrui. Elle dépend des aspirations, des réalisations, de l'approbation sociale et du sentiment de pouvoir agir sur les situations.

S024 - Approbation sociale (fiche p. 19)

Reconnaissance ou jugement favorable perçu de la part d'autrui. Elle contribue à l'image et à l'évaluation de soi, sans être la seule source de l'estime de soi.

S025 - Lieu de contrôle (fiche p. 19)

Croyance relative à ce qui détermine les événements : ses propres actions dans le contrôle interne, des facteurs extérieurs dans le contrôle externe. Il concerne une perception du contrôle, pas la preuve d'une maîtrise effective.

S026 - Identité publique (fiche p. 19)

Dans le modèle de Miller présenté ici, identité liée aux normes du groupe et au rôle social. Elle comporte un versant objectif, le rôle assigné, et un versant subjectif, la manière de l'assumer.

S027 - Identité de choix (fiche p. 19)

Manière dont une personne se représente elle-même dans le modèle de Miller. Elle se distingue de la seule définition publique du rôle qu'on attend d'elle.

Attribution indiquée dans le cours : Miller (1975).

S028 - Présentation de soi (fiche p. 19)

Manière dont une personne se donne à voir dans l'interaction. Elle peut chercher à se distinguer, à susciter une impression favorable, à jouer un rôle acceptable ou à préserver des marges dans la relation.

Attribution indiquée dans le cours : E. Goffman (1973) pour la mise en scène ; les autres dimensions ne sont pas attribuées séparément.

S029 - Conscience de soi intime (fiche p. 19)

Sentiment que l'on a de soi-même indépendamment d'une situation sociale particulière. Elle désigne le versant intérieur de l'expérience de soi.

Attribution indiquée dans le cours : Auteurs transcrits « Jenigstein/Scheirr/Bus » (1975) dans le support ; graphie conservée pour éviter une correction non vérifiée.

S030 - Conscience de soi publique (fiche p. 19)

Attention portée à soi comme objet du regard et de l'évaluation d'autrui. Elle intervient dans la façon de se présenter en interaction.

Attribution indiquée dans le cours : Auteurs transcrits « Jenigstein/Scheirr/Bus » (1975) dans le support ; graphie conservée.

S031 - Soi idéal et Soi reflété (fiche p. 19)

Le Soi idéal correspond à ce que l'on aimerait être ; le Soi reflété renvoie à l'image de soi perçue dans le regard d'autrui. Leur écart peut contribuer à une tension identitaire.

S032 - Appartenance sociale (fiche p. 20)

Inscription dans des groupes et catégories, de dimensions diverses, dont les normes, valeurs et représentations contribuent à la définition de soi.

S033 - Exploration identitaire (fiche p. 20)

Démarche par laquelle une personne examine plusieurs possibilités, valeurs ou choix avant de s'orienter. Avec l'engagement, elle constitue un axe du modèle de Marcia.

S034 - Engagement identitaire (fiche p. 20)

Investissement dans des choix, orientations ou valeurs que la personne assume. Il peut être fort avec ou sans exploration préalable dans le modèle de Marcia.

S035 - Identité achevée (fiche p. 20)

Configuration de Marcia associant une exploration importante et un engagement fort dans des choix élaborés. Elle désigne une position dans ce modèle, et non un diagnostic ou la fin de toute évolution.

Attribution indiquée dans le cours : Marcia (1966, 1978).

S036 - Identité moratoire (fiche p. 20)

Configuration associant exploration importante et engagement encore faible ou suspendu. La personne examine des possibilités sans avoir stabilisé son choix.

Index alphabétique

S037 - Identité forclose (fiche p. 20)

Configuration associant engagement fort et faible exploration préalable des possibilités. Un choix peut être adopté en reprenant directement des attentes ou modèles de l'entourage.

Attribution indiquée dans le cours : Marcia (1966, 1978).

S038 - Identité diffuse (fiche p. 20)

Configuration associant faible exploration et faible engagement. Elle traduit l'absence de choix identitaire stabilisé dans les dimensions examinées.

Attribution indiquée dans le cours : Marcia (1966, 1978).

S039 - Identification (fiche p. 20)

Processus par lequel autrui ou un modèle social sert de référence à la personne, qui en intériorise certains traits et les incorpore à sa conduite. Le terme peut aussi désigner l'identification d'autrui à travers des catégories.

S040 - Référent identitaire (fiche p. 21)

Personne, groupe, rôle, norme, valeur ou symbole qui marque l'image de soi et sert de modèle ou de source de reconnaissance.

S041 - Comparaison sociale (fiche p. 21)

Évaluation de soi par référence à autrui, notamment pour situer ses capacités et rechercher de la reconnaissance. Elle peut modifier l'estime de soi selon la cible et le contexte.

S042 - Groupe restreint (fiche p. 21)

Petit ensemble de personnes en relations effectives et personnelles, partageant des buts, des interactions et un vécu commun. Il possède une organisation, une identité collective et une interdépendance qui dépassent l'addition des individus.

S043 - Groupe primaire et groupe secondaire (fiche p. 21)

le groupe primaire repose sur des relations directes et une réalité vécue, tandis que le groupe secondaire n'exige pas que tous ses membres se connaissent personnellement.

S044 - Dynamique de groupe (fiche p. 21)

Ensemble des processus d'interaction qui organisent la vie d'un groupe, ses affects, ses normes, ses rôles, ses décisions et ses changements.

S045 - Cohésion du groupe (fiche p. 21)

Force des liens et du sentiment d'appartenance qui permettent aux membres de se sentir unis et de maintenir une activité commune.

S046 - Normalisation (fiche p. 21)

Construction progressive de normes communes par influence mutuelle dans une situation initialement floue ou ambiguë. Elle réduit l'incertitude, facilite le consensus et organise le fonctionnement du groupe.

S047 - Organisation affective du groupe (fiche p. 22)

Configuration des attractions, rejets, affinités, conflits et influences entre membres. Elle contribue à déterminer des places telles que membre populaire, marginal ou exclu.

S048 - Histoire collective du groupe (fiche p. 22)

Vécu commun de conflits, alliances, rivalités, exclusions et événements qui continue d'influencer les relations présentes. On l'aborde sous l'expression « inconscient collectif ».

S049 - Valeur sociale (fiche p. 22)

Idéal abstrait auquel un groupe accorde de l'importance et qui oriente ses jugements et ses actes. Les valeurs sont liées à un contexte culturel et historique.

S050 - Norme sociale (fiche p. 22)

Règle explicite ou implicite définissant les conduites attendues dans une collectivité. Son respect et ses écarts peuvent entraîner reconnaissance ou sanctions formelles ou diffuses.

S051 - Statut social (fiche p. 22)

Position occupée dans une structure sociale, associée à des droits, devoirs et attentes. On distingue les statuts assignés, non choisis, et acquis, liés à une trajectoire et à des actions.

S052 - Rôle social (fiche p. 22)

Dimension dynamique du statut : ensemble des conduites attendues de celui qui l'occupe et manière singulière de les incarner. Il articule attentes collectives et appropriation personnelle.

S053 - Rôle centré sur la tâche (fiche p. 22)

Intervention qui fait progresser le travail du groupe : chercher ou fournir des informations, proposer, coordonner, clarifier ou résumer.

Attribution indiquée dans le cours : Benne et Sheats, sans date précisée.

S054 - Rôle de maintien de la cohésion (fiche p. 22)

Intervention qui entretient les conditions relationnelles de travail : encourager, rassurer, faciliter l'expression, harmoniser et réduire les tensions.

Attribution indiquée dans le cours : Benne et Sheats, sans date précisée.

Index alphabétique

S055 - Rôle centré sur les besoins individuels
(fiche p. 23)

Dans la classification de Benne et Sheats retenue ici, conduite qui privilégie la satisfaction personnelle au détriment du fonctionnement collectif, par exemple bloquer, dominer ou agresser.

S056 - Leadership (fiche p. 23)

Influence exercée pour organiser la tâche ou maintenir la cohésion du groupe. Des actes de leadership peuvent être accomplis par plusieurs membres et ne supposent pas une fonction hiérarchique officielle.

S057 - Leadership autoritaire (fiche p. 23)

Mode de conduite où le dirigeant décide et contrôle fortement l'activité. Dans les expériences historiques, il peut soutenir la production immédiate tout en favorisant dépendance, apathie ou agressivité.

S058 - Leadership démocratique (fiche p. 23)

Mode de conduite favorisant participation, discussion et autonomie des membres. Les expériences l'associent à un meilleur climat et à un meilleur moral du groupe dans les expériences présentées.

S059 - Leadership laisser-faire (fiche p. 23)

Mode de conduite comportant peu de direction et de régulation par celui qui occupe la place de dirigeant. Le collectif peut manquer de décisions et de coordination.

S060 - Sociométrie (fiche p. 23)

Méthode associée à Moreno visant à représenter et étudier l'organisation affective spontanée des groupes : attractions, rejets et choix relationnels.

Attribution indiquée dans le cours : J.L. Moreno, sans date précisée.

S061 - T-group (fiche p. 23)

Groupe de formation associé aux travaux de Lewin, utilisé comme lieu d'observation, de réflexion et d'exploration de la dynamique des interactions.

S062 - Influence sociale (fiche p. 24)

Processus par lequel les pensées, opinions ou conduites d'une personne sont modifiées dans la relation à autrui, à un groupe ou à une autorité. Elle s'exerce notamment par les normes et la communication.

S063 - Pression de conformité (fiche p. 24)

Incitation explicite ou implicite à adopter les conduites et représentations communes pour préserver l'accord et la cohésion du groupe. Elle peut s'appuyer sur l'approbation, le prestige ou la crainte du rejet.

S064 - Conformisme (fiche p. 24)

Modification d'un jugement ou d'un comportement pour se mettre en accord avec une norme déjà soutenue par le groupe. L'adhésion peut rester superficielle ou atteindre les convictions.

S065 - Complaisance (fiche p. 24)

Conformisme de surface visant à éviter les désagréments, à passer inaperçu ou à obtenir une approbation, sans modifier nécessairement ses croyances profondes.

Attribution indiquée dans le cours : H. Kelman (1958).

S066 - Conformisme par identification (fiche p. 24)

Adoption de la position d'un groupe ou d'autrui afin de préserver une relation valorisée et d'être accepté. La recherche de reconnaissance soutient cette forme d'influence.

Attribution indiquée dans le cours : H. Kelman (1958).

S067 - Intériorisation (fiche p. 24)

Adoption d'un contenu comme une conviction personnelle. La personne y adhère et n'éprouve plus son accord comme une simple soumission extérieure.

Attribution indiquée dans le cours : H. Kelman (1958).

S068 - Obéissance (fiche p. 24)

Modification de son comportement en réponse à un ordre émis par une autorité perçue comme légitime. La perception de légitimité participe à l'effet d'influence.

S069 - État agentique (fiche p. 24)

Modèle explicatif de l'obéissance dans lequel une personne se considère surtout comme exécutante de l'autorité et met à distance son autonomie critique et sa responsabilité personnelle.

S070 - Syntonisation avec l'autorité (fiche p. 25)

Orientation privilégiée de l'attention et de la conduite vers les consignes de l'autorité, au détriment d'autres informations de la situation, notamment les effets sur autrui.

S071 - Engagement dans l'action (fiche p. 25)

Processus par lequel les actes déjà accomplis rendent plus difficile l'abandon de la conduite et favorisent sa justification. Il constitue une explication discutée de la poursuite de l'obéissance.

S072 - Réactance (fiche p. 25)

Motivation à résister à une influence perçue comme menaçant sa liberté ou son indépendance, afin de restaurer cette liberté. Elle peut apparaître avant même l'examen des arguments.

S073 - Déviance (fiche p. 25)

Écart aux normes d'un groupe ou d'un système de règles donné. La qualification dépend donc de la référence collective et ne désigne pas à elle seule une pathologie ou une faute morale.

Index alphabétique

S074 - Influence minoritaire (fiche p. 25)

Capacité d'une minorité active à faire évoluer les positions du collectif. On souligne son investissement, son autonomie et sa consistance comme conditions favorables.

S075 - Consistance d'une minorité (fiche p. 25)

Cohérence et continuité de la position soutenue par une minorité dans le temps et entre ses membres. Elle contribue à rendre son message identifiable et crédible.

S076 - Minorité orthodoxe et hétérodoxe (fiche p. 25)

La minorité orthodoxe accentue une norme existante ; la minorité hétérodoxe propose une contre-norme. Cette distinction concerne leur rapport à la règle majoritaire.

S077 - Bouc émissaire (fiche p. 25)

Personne sur laquelle un groupe déplace ou concentre ses conflits et difficultés internes. Un nouveau membre peut occuper cette place et être rejeté pour maintenir un équilibre collectif.

S078 - Marginalité (fiche p. 26)

Position durable à la marge d'un groupe, sans être totalement à l'intérieur ni complètement exclu. Le membre n'incarne qu'une partie des normes collectives.

S079 - Communication (fiche p. 26)

Processus d'échange et de production de sens entre des interlocuteurs, par un message, un canal et des codes dans un contexte donné, avec des effets et des retours possibles.

S080 - Modèle de Lasswell (fiche p. 26)

Lecture de la communication à travers cinq questions : qui dit quoi, par quel moyen, à qui et avec quels effets ? Elle met en relation source, message, canal, destinataire et impact.

S081 - Codage et décodage (fiche p. 26)

Le codage transforme une information en signes selon un code ; le décodage permet au destinataire d'interpréter ces signes. Un code commun ou partiellement partagé favorise la compréhension.

S082 - Modèle de Shannon (fiche p. 26)

Modèle de transmission qui distingue notamment émetteur, message, canal, récepteur et opérations de codage/décodage. Les perturbations ou bruits peuvent altérer la transmission et son interprétation.

S083 - Bruit physique (fiche p. 26)

Perturbation matérielle gênant la transmission ou la réception du message, comme un bruit ambiant, une mauvaise liaison téléphonique ou une interruption.

Attribution indiquée dans le cours : Weaver dans la présentation du schéma de Shannon (1947).

S084 - Bruit sémantique (fiche p. 26)

Perturbation du sens liée aux différences de codes, de références ou d'interprétation entre interlocuteurs. Un même mot peut renvoyer à des significations différentes.

Attribution indiquée dans le cours : Weaver dans la présentation du schéma de Shannon (1947).

S085 - Répertoire (fiche p. 26)

Ensemble des références linguistiques, culturelles, idéologiques et sémantiques à partir desquelles une personne construit et interprète les messages.

S086 - Feedback ou rétroaction (fiche p. 27)

Information en retour du récepteur vers l'émetteur permettant d'ajuster la communication. Elle peut être verbale ou non verbale et transforme un trajet linéaire en boucle dynamique.

Attribution indiquée dans le cours : N. Wiener (1948), modèle de communication présenté dans le support.

S087 - Modèle de Wiener (fiche p. 27)

Approche dynamique de la communication insistant sur le feedback et les ajustements permanents entre interlocuteurs. Le récepteur participe au processus par ses retours.

S088 - Émetteur (fiche p. 27)

Personne ou source qui produit et adresse un message. Ses objectifs, attitudes, références, choix de mots, crédibilité et attractivité influencent la communication.

S089 - Récepteur (fiche p. 27)

Destinataire qui reçoit et interprète le message selon son attention, ses capacités, ses attentes, ses affects et son répertoire. Il n'est pas un contenant passif de l'information.

S090 - Canal (fiche p. 27)

Moyen par lequel circule un message : voix dans l'air, téléphone, écrit, affichage ou autre support. Son choix influence les possibilités et les limites de l'échange.

S091 - Contexte de communication (fiche p. 27)

Conditions matérielles, relationnelles, culturelles, statutaires et hiérarchiques entourant un échange. Elles peuvent faciliter ou gêner l'expression et la réception.

S092 - Prosodie (fiche p. 27)

Caractéristiques de la voix telles que rythme, intonation, intensité, accentuation et pauses. Elles accompagnent les mots et contribuent au sens et à l'effet du message.

S093 - Communication incidente (fiche p. 27)

Information transmise sans intention consciente de la communiquer, par exemple une parole qui échappe à l'émetteur. Elle se distingue des communications consommatoire et instrumentale.

Attribution indiquée dans le cours : Zajonc, sans date précisée.

Index alphabétique

S094 - Communication consommatoire (fiche p. 28)

Communication qui exprime un état émotionnel. Sa fonction principale est l'expression de cet état plutôt que la poursuite d'un objectif informatif délibéré.

Attribution indiquée dans le cours : Zajonc, sans date précisée.

S095 - Communication instrumentale (fiche p. 28)

Communication qui poursuit intentionnellement un objectif : informer, expliquer, convaincre ou produire un effet sur autrui.

Attribution indiquée dans le cours : Zajonc, sans date précisée.

S096 - Crédibilité de la source (fiche p. 28)

Degré de confiance et de compétence attribué à une source par le récepteur. Elle peut augmenter l'efficacité persuasive du message mais ne prouve pas à elle seule sa vérité.

S097 - Attractivité de la source (fiche p. 28)

Caractère attirant, sympathique ou admirable attribué à l'émetteur, favorisant l'identification du récepteur. Un changement fondé surtout sur l'affect peut être moins stable si le lien se modifie.

S098 - Communication persuasive (fiche p. 28)

Communication visant à faire évoluer une attitude ou un comportement. Son effet dépend notamment de l'attention, de la compréhension, de l'acceptation, de la mémorisation et du passage à l'action.

S099 - Argumentation unilatérale et bilatérale (fiche p. 28)

Un discours unilatéral présente un seul versant d'une position ; un discours bilatéral expose aussi les objections ou arguments opposés. L'effet dépend du destinataire, de ses positions et de l'ordre de présentation.

S100 - Polysémie (fiche p. 28)

Possibilité pour un même mot ou énoncé d'avoir plusieurs sens. Elle peut créer un décalage entre le sens visé et le sens reçu.

S101 - Communication non verbale (fiche p. 29)

Ensemble des dimensions de l'échange qui ne reposent pas sur le contenu lexical : distance, posture, gestes, présentation corporelle, expressions faciales, regard et caractéristiques de la voix.

S102 - Proxémie (fiche p. 29)

Étude de l'usage des distances et de l'espace dans les interactions. La distance ressentie comme appropriée varie avec la relation, la situation et les repères culturels.

S103 - Posture (fiche p. 29)

Organisation du corps dans l'interaction, incluant tonus, orientation, position et gestes. Elle prend sens avec d'autres indices et le contexte.

S104 - Mimique (fiche p. 29)

Expression du visage participant à la communication des émotions et à la régulation de l'échange. Avec le regard et le sourire, elle fournit un retour à l'interlocuteur.

S105 - Fonction expressive du non-verbal (fiche p. 29)

Fonction par laquelle le corps et la voix donnent des indications sur l'état émotionnel, l'opinion sur autrui ou l'estime de soi.

S106 - Fonction d'étayage du langage (fiche p. 29)

Fonction du non-verbal qui accompagne, renforce, précise ou contredit un message verbal. Le sens reçu résulte de leur combinaison.

S107 - Fonction quasi symbolique (fiche p. 29)

Fonction de gestes qui tiennent lieu de signes conventionnels, proches de mots, dans un contexte culturel donné.

Attribution indiquée dans le cours : Cranach, sans date précisée.

S108 - Congruence (fiche p. 30)

Cohérence entre les différentes dimensions d'un message, notamment entre mots, ton et attitude corporelle. Elle facilite la lisibilité de l'échange.

S109 - Approche systémique (fiche p. 30)

Approche qui étudie un ensemble d'éléments en interaction, ses règles, ses fonctions et ses relations avec l'environnement. Une modification d'un élément peut réorganiser les échanges du système.

S110 - Homéostasie d'un système (fiche p. 30)

Processus par lesquels un système tend à maintenir son équilibre et ses modes habituels de fonctionnement. Il coexiste avec des possibilités de changement et d'évolution.

S111 - Patient désigné (fiche p. 30)

Dans certaines approches systémiques historiques, membre identifié comme porteur du problème et autour duquel se focalise la demande. Cette notion invite à élargir l'analyse des interactions.

S112 - Communication symétrique (fiche p. 30)

Interaction fondée sur une relation de similitude ou d'égalité des positions. Elle peut soutenir la réciprocité ou donner lieu à une escalade compétitive.

Attribution indiquée dans le cours : Bateson, école de Palo Alto, sans date propre à cette distinction.

S113 - Communication complémentaire (fiche p. 30)

Interaction organisée autour de positions différentes qui s'articulent, chacune répondant à l'autre. Elle peut être ajustée ou devenir rigide et problématique.

Attribution indiquée dans le cours : Bateson, école de Palo Alto, sans date propre à cette distinction.

Index alphabétique

S114 - Communication digitale (fiche p. 30)

Dans le vocabulaire de Palo Alto, dimension de la communication fondée sur des signes conventionnels codifiés, notamment le langage verbal.

Attribution indiquée dans le cours : Bateson, école de Palo Alto, cadre présenté dans le support.

S115 - Communication analogique (fiche p. 31)

Dimension de la communication liée aux ressemblances, aux attitudes, au contexte relationnel et au non-verbal. Elle module le sens et se prête à l'interprétation.

Attribution indiquée dans le cours : Bateson, école de Palo Alto, cadre présenté dans le support.

S116 - Métacommunication (fiche p. 31)

Communication portant sur la relation ou sur la manière d'interpréter les messages. Elle peut être implicite ou explicite et aide à réguler l'échange.

Attribution indiquée dans le cours : Bateson, école de Palo Alto, cadre présenté dans le support.

S117 - Injonction paradoxale (fiche p. 31)

Demande dont l'exécution est incompatible avec ce qu'elle exige, ou message réunissant des exigences contradictoires.

S118 - Double contrainte (fiche p. 31)

Configuration relationnelle où des exigences incompatibles, dont certaines peuvent être implicites, placent la personne dans une impasse difficile à commenter ou à quitter.

S119 - Structure de communication (fiche p. 31)

Organisation effective des échanges entre membres d'un groupe pour une tâche donnée. Elle dépend de la situation et peut changer avec la tâche ou les modalités de travail.

Attribution indiquée dans le cours : Flament (1965).

S120 - Réseau de communication (fiche p. 31)

Ensemble des canaux disponibles reliant les membres d'un groupe. Les réseaux en chaîne, cercle, Y et étoile distribuent différemment l'accès à l'information.

S121 - Centralisation du réseau (fiche p. 31)

Degré auquel les échanges passent par un membre ou un petit nombre de positions centrales. Elle concentre l'information et peut faciliter certaines coordinations tout en limitant la participation des autres.

S122 - Flux de communication (fiche p. 31)

Circulation effective des messages dans un groupe : qui parle, à qui, combien et selon quelles modalités. Leur observation aide à comprendre les rôles et la participation.

S123 - Grille de Bales (fiche p. 32)

Outil distinguant douze catégories d'interactions : trois socioémotionnelles positives, six relatives à la tâche et trois socioémotionnelles négatives. Leurs relations éclairent six types de difficultés du groupe.

Attribution indiquée dans le cours : Bales (1950).

S124 - Perception sociale (fiche p. 32)

Ensemble des processus par lesquels nous construisons une représentation d'autrui et des groupes. Elle combine informations disponibles, catégories et attentes préalables.

S125 - Catégorisation sociale (fiche p. 32)

Processus mental qui organise l'environnement humain en catégories partageant certains traits. Il facilite le traitement de la complexité, mais peut rigidifier les frontières et amplifier les ressemblances ou différences perçues.

S126 - Stéréotype (fiche p. 32)

Croyance ou représentation simplifiée attribuant des caractéristiques à une catégorie de personnes ou à un groupe. Il peut être favorable ou défavorable en apparence tout en restant réducteur.

Attribution indiquée dans le cours : Lippmann (1922).

S127 - Préjugé (fiche p. 32)

Attitude préconçue, souvent défavorable, à l'égard de personnes en raison de leur appartenance à un groupe. Il comporte une dimension évaluative et s'apprend dans un contexte social.

S128 - Discrimination (fiche p. 32)

Traitement défavorable ou différenciation dans les conduites envers une personne sur la base de son appartenance réelle ou supposée à une catégorie. Elle désigne le versant des pratiques, à distinguer des croyances et attitudes.

S129 - Endogroupe et exogroupe (fiche p. 32)

L'endogroupe est le groupe auquel on s'identifie, le « nous » ; l'exogroupe est le groupe perçu comme extérieur, le « eux ». Ces frontières dépendent du contexte et de l'appartenance mobilisée.

S130 - Favoritisme endogroupe (fiche p. 33)

Tendance à avantager ou valoriser son groupe d'appartenance par rapport à un autre groupe. Elle peut apparaître même après une répartition arbitraire en groupes.

S131 - Paradigme des groupes minimaux (fiche p. 33)

Dispositif expérimental où des personnes sont réparties en groupes selon des critères minimes ou arbitraires, afin d'étudier les effets de cette seule catégorisation sur les choix.

Index alphabétique

Attribution indiquée dans le cours : Tajfel, Billig, Bundy et Flament (1971), graphie et date du support.

S132 - Ethnocentrisme (fiche p. 33)

Tendance à prendre les normes et valeurs de son groupe comme référence privilégiée et à surestimer sa supériorité par rapport à d'autres groupes.

S133 - Dissonance cognitive (fiche p. 33)

Tension liée à l'incompatibilité entre des cognitions, ou entre croyances et conduites, qui peut motiver des ajustements pour réduire cette incohérence.

S134 - Effet Pygmalion (fiche p. 33)

Effet par lequel les attentes d'une personne à l'égard d'autrui peuvent modifier ses propres conduites envers lui et contribuer à faire évoluer ses performances.

Attribution indiquée dans le cours : Rosenthal et Jacobson (1968).

S135 - Prophétie autoréalisatrice (fiche p. 33)

Processus par lequel une attente initiale suscite des comportements et interactions qui contribuent à produire un résultat ressemblant à cette attente, ensuite perçu comme sa confirmation.

S136 - Intériorisation des stéréotypes (fiche p. 33)

Appropriation de représentations sociales qui peut conduire à valoriser les traits d'un groupe dominant et à dévaloriser l'image de son propre groupe.

S137 - Illusion de corrélation (fiche p. 33)

Perception ou surestimation d'une association entre deux événements ou caractéristiques. un trait inhabituel peut être davantage remarqué lorsqu'il est associé à un groupe minoritaire.

S138 - Message

Contenu transmis au cours d'une communication. Son organisation, son code, sa forme, sa complexité et ses différents niveaux de sens influencent ce que le récepteur peut comprendre, retenir ou interpréter.

Précision issue du support officiel de psychologie sociale

S139 - Code de communication

Système de signes et de règles utilisé pour construire et interpréter un message, par exemple une langue. Le décodage suppose que l'émetteur et le récepteur disposent de références au moins partiellement communes.

Précision issue du support officiel de psychologie sociale

S140 - Territoire et espace intime

Dimension spatiale de la communication non verbale : distance entre soi et autrui, accès à l'intimité et manière d'occuper l'espace. La distance vécue comme acceptable dépend notamment de la relation et du contexte culturel.

Précision issue du support officiel de psychologie sociale

S141 - Image corporelle dans la communication non verbale

Aspect de soi donné à voir à autrui, notamment par les choix vestimentaires et la présentation corporelle, socialement et culturellement marqués.

À distinguer : Cet emploi dans le chapitre communication se distingue de l'image du corps comme représentation subjective et affective de soi.

Précision issue du support officiel de psychologie sociale

S142 - Communication paradoxale

Communication comportant des niveaux ou des exigences incompatibles qui placent le destinataire dans une contradiction. Une injonction peut par exemple exiger la spontanéité. La double contrainte désigne une impasse relationnelle plus large, et non toute contradiction isolée.

Attribution indiquée dans le cours : École de Palo Alto, sans auteur unique attribué à la définition.

Précision issue du support officiel de psychologie sociale

Index alphabétique

Santé : passages complémentaires du support

Passages du support et repères complémentaires. Les précautions de lecture accompagnent les modèles historiques et les formulations qui demandent une distinction.

X001 - Prévention et promotion des comportements de santé

•Prévention (promotion des comportements de santé) = « Mieux vaut prévenir que guérir »

Attribution du passage : Bruchon-Schweitzer (2001), dans les objectifs de la psychologie de la santé.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 5

X003 - Santé selon l'OMS 1946 et Santé selon l'OMS 1984

La santé (1) : 1. «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité» (Préambule à la Constitution de l'OMS, 1946) 2. «Mesure dans laquelle une personne ou un groupe peut réaliser ses aspirations et satisfaire ses besoins et s'adapter aux changements et au milieu. La santé est donc perçue comme une ressource de la vie quotidienne, et non comme le but de la vie; il s'agit d'un concept positif mettant en valeur les ressources sociales et individuelles, ainsi que les capacités physiques». (OMS, 1984)

Attribution du passage : OMS (1946), Préambule à la Constitution.

Attribution du passage : OMS (1984).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 11

X004 - Santé comme bien instable et Santé comme équilibre et Santé comme adaptation

La santé (3) : Nouvelles définitions, prenant en compte : • La notion d'instabilité : "La santé, plus que l'absence d'infirmité ou de maladie est une qualité de vie comportant une dimension sociale, mentale, morale et affective tout autant que physique. C'est un bien instable qu'il faut préserver, acquérir, constamment défendre et reconstruire tout au long de sa vie." (CEE, 1988) • La notion d'équilibre : "La santé est l'équilibre et l'harmonie de toutes les possibilités de la personne humaine, biologiques, psychologiques et sociales. Cet équilibre exige d'une part la satisfaction des besoins fondamentaux de l'homme qui sont qualitativement les mêmes pour tous les êtres humains (besoins affectifs, nutritionnels, sanitaires, éducatifs et sociaux), d'autre part une adaptation sans cesse remise en question de l'homme à un environnement en perpétuelle mutation". (Santé publique, Santé de la communauté ; Monnier et al, 1980) • La notion d'adaptation: "État physique et mental relativement exempt de gênes et de souffrances qui permet à l'individu de fonctionner aussi longtemps que possible dans le milieu où le hasard ou le choix l'ont placé".

René Dubos, 1972, L'homme ininterrompu

Attribution du passage : CEE (1988), attribution du support.

Attribution du passage : Monnier et collaborateurs (1980), Santé publique Santé de la communauté.

Attribution du passage : René Dubos (1972), L'homme ininterrompu.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 13

X005 - Équilibre santé maladie et santé relative

La santé est relative et évolutive. Le support la représente sur un continuum santé-maladie, plutôt que comme deux états séparés et immuables.

À distinguer : Le schéma exprime une continuité ; il ne donne pas un seuil diagnostique.

Synthèse du schéma du cours - Santé doc. 1 / p. 14

X006 - État de santé perçu

Etat de santé perçu ou perception de la santé (1) : Définition : « L'état de santé perçu reflète la perception générale que les individus ont de leur santé physique et psychique ». (OCDE ,2015), = Auto-évaluation par un sujet de son propre état de santé (« comment évaluez-vous votre état de santé actuel ? ») La santé est une idée, une norme propre à chaque individu selon son vécu, son âge, son sexe, ses conditions socio-économiques, sa catégorie socio-professionnelle, sa culture … Exemple : « Être en bonne santé, c'est ne pas être malade »/« Être en bonne santé, c'est ne pas avoir de handicap physique ou fonctionnel... »

Attribution du passage : OCDE (2015).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 15

Index alphabétique

X008 - Dimensions de la qualité de vie

Les 4 dimensions de la qualité de vie (1) : 4 catégories essentielles (Bruchon-Schweitzer, 2002) : • La santé psychologique (bien-être) • La santé physique et les capacités fonctionnelles • Les relations et les activités sociales • Le bien-être matériel (et le statut socio-économique) Les 4 dimensions de la qualité de vie (2) : 1. Domaine physique = santé physique et capacités fonctionnelles (mobilité, autonomie, dépendance à des substances ou autres) ; sensations somatiques = symptômes, conséquence des traumatismes ou des procédures thérapeutiques, douleurs et inconfort, énergie et fatigue, sommeil et repos etc. 2. Domaine psychologique = état émotionnel et affectif (émotivité, stabilité, humeur, anxiété, dépression) ; fonctionnement cognitif (capacité à résister au stress, capacités relationnelles…), image du corps, estime de soi etc. 3.

Domaine social = place sociale, relations et activités sociales ; rapport à l'environnement familial, amical ou professionnel, soutien social, activité sexuelle etc. 4. Domaine matériel = satisfaction vis-à-vis du revenu, du domicile, du lieu de vie, statut socio-économique, aides financières etc. Et aussi: Capacité de travail Spiritualité/Religion/Croyances personnelles

Attribution du passage : Bruchon-Schweitzer (2002).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 20, 21

X009 - Domaines et facettes de la qualité de vie

Santé physique : énergie et fatigue ; douleur et inconfort ; sommeil et repos. Santé psychologique : image du corps et apparence ; sentiments négatifs ; sentiments positifs ; estime de soi ; pensée, apprentissage, mémoire, concentration. Niveau d'indépendance/dépendance : mobilité ; activités quotidiennes ; dépendance à substance médicale et à soutien médical ; capacité de travail. Relations sociales : relations personnelles ; soutien social ; activité sexuelle. Environnement : ressources financières ; liberté, sûreté physique et sécurité ; aide sociale et à la santé : accessibilité et qualité ; habitat ; occasions d'acquérir de nouvelles informations et compétences ; participation et opportunité de jeux/loisirs ; environnement physique (pollution, bruit, embouteillage, climat) ; transports.

Spiritualité/religion/croyances personnelles (facette unique).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 22

X010 - Qualité de vie liée à la santé

Qualité de vie et maladie (1) : 1. Maladie => bouleversement des conditions de vie antérieures et remise en cause parfois brutale de la QDV ; notion de qualité de vie liée à la santé : on prend en compte non pas toutes les dimensions de la qualité de vie en général mais celles qui peuvent être modifiées par la maladie ou son traitement. 2. Prise en compte des perceptions et préférences des patients, en matière de décisions de santé ; cf. différences importantes entre l'évaluation clinique faite par le milieu médical et l'évaluation subjective faite par le malade lui-même. 3. Mesure QDV liée à la maladie => connaître retentissement de la pathologie et des traitements dans vie quotidienne des patients, c'est-à- dire : Effets toxiques à court et à long terme des traitements et leur caractère indésirable et/ou intolérable (cf. alopécie pour traitement chimio) Intervention de la subjectivité des patients dans la prise en charge, qui conditionnera la relation avec le corps médical, l'acceptation du traitement, l'évolution de la maladie. => cette mesure doit permettre d'améliorer le bien-être physique, psychologique et social du patient.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 26

X011 - Hétéro-évaluation et Auto-évaluation et Mesures objectives dans la qualité de vie

3. Mesure de la QDV : exemple de l'évaluation de l'état fonctionnel d'un malade • Mesures « objectives » : radios, scanner, EEG… • Hétéro-évaluation : diagnostic du médecin • Auto-évaluation : compte-rendu du patient

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 27

X012 - Théorie des humeurs

Grèce antique et Rome : théorie des humeurs (Hippocrate, 460-370 av JC ; puis Galien, 129-199), selon laquelle il existe dans le corps 4 humeurs auxquelles sont reliés des caractères et des tempéraments - ces 4 éléments et qualités doivent coexister en équilibre pour que la personne soit en bonne santé => - traitements sont calculés pour rétablir l'équilibre et les régimes pour le maintenir

Attribution du passage : Hippocrate (460-370 av. JC) puis Galien (129-199) : repères biographiques donnés par le cours.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 32

Index alphabétique

X016 - Signes subjectifs et Signes objectifs et Pronostic

Construction d'une maladie •Expression d'une plainte, d'une douleur, d'une souffrance par l'individu • Consultation chez le médecin • Identification par le médecin des signes ou symptômes subjectifs (signes fonctionnels ou ce que le médecin extrait du ressenti du patient) et des signes ou symptômes objectifs (signes physiques) →Examens biologiques, radiologiques... • Diagnostic • Maladie nommée avec étiologie, pronostic (évolution probable) et traitement (thérapeutique)

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 40

X017 - Représentation de la maladie ou théorie profane et Étiologie

Les représentations de la maladie (ou théories profanes ou naïves) (1) La rencontre entre la maladie telle qu'elle est subjectivement éprouvée (illness), socialement représentée (sickness) et telle qu'elle est scientifiquement diagnostiquée (disease) aboutit à la construction par le patient d'un modèle explicatif de sa maladie (car l'homme a toujours besoin de trouver un sens/causes, signification, évolution, mécanismes, diagnostics, action des traitements, conséquences de la maladie) ; ce sont les théories profanes de la maladie. Définition de la représentation d'une maladie (Leventhal, Meyer et Nerenz, 1980) : La représentation d'une maladie regroupe «les croyances personnelles implicites de bon sens d'un individu au sujet de sa maladie».

Ce que permet une représentation de la maladie - Donner du sens à la maladie (Pourquoi moi?, Pourquoi maintenant ? etc.) - Gérer la maladie (s'adapter : stratégies d'adaptation ou d'ajustement) Les représentations de la maladie (ou théories profanes ou naïves) (2) Contenu de cette représentation de la maladie - La cause (étiologie) : biologique, environnementale, émotionnelle, psychologique - Les conséquences : évaluation de l'individu sur l'impact de sa maladie, sur sa qualité de vie, sur sa capacité de fonctionnement - La dimension identitaire : place que donne l'individu à la maladie dans la façon dont il se définit - La dimension temporelle : croyance par rapport à la progression de sa maladie et à l'évolution de ses symptômes - Les croyances par rapport au traitement : et/ou à l'aspect contrôlable de la maladie

Attribution du passage : Leventhal, Meyer et Nerenz (1980).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 41, 42

X018 - Modèle explicatif exogène et Modèle explicatif endogène

2 types de modèles explicatifs : Modèles exogènes : maladie est causée par un agent externe (éléments naturels, événements de vie , relations à autrui). Victime = en bonne santé au départ, ne participe en rien à la genèse du processus pathologique. L'ennemi est totalement responsable. Rencontre conflictuelle. Traitement est soustractif (enlever ce qui crée la maladie) ; modèle occidental, allopathique, centré sur la partie malade. Modèles endogènes : maladie trouve sa cause à l'intérieur du sujet (transmission familiale, dysfonctionnement corporel, émotions, caractère). Traitement s'intéresse à la globalité de l'individu, vise à le renforcer pour mieux résister ou éviter la maladie ; modèle additif (homéopathique)

À distinguer : Il s'agit des modèles explicatifs et croyances étudiés dans ce cours ; leur description ne démontre pas l'efficacité d'un traitement.

Attribution du passage : Le schéma S1 p. 44 indique « d'après Pedinielli et coll, 1996 » ; source Bruchon-Schweitzer (2002). La présentation textuelle S1 p. 43 ne donne pas d'auteur particulier.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 43

X020 - Douleur définition IASP 2020 et Douleur définition IASP 1979

La douleur : définition (1) La douleur est « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. »(2020, International Association for the Study of Pain). Avant (1979) : La douleur est « Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes » (IASP) La douleur : définition (2) Cette définition montre qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'une lésion pour déclencher la douleur et inversement, toute lésion ne déclenche pas obligatoirement de douleur. La douleur est un phénomène perceptif fonctionnel ; elle nous apprend à éviter les situations dangereuses.

C'est avant tout un signal d'alarme qui met en jeu des réflexes de protection nous permettant de nous soustraire aux stimuli nocifs. Douleur = expérience personnelle, intime, subjective, qui engage la totalité du sujet, avec toute son histoire de vie (interprétation selon sensibilité propre et expériences passées). Donc toute personne exprimant une douleur, par des mots ou des comportements, doit être considérée comme ayant "mal", même si la cause n'est pas identifiée, et elle doit être soulagée. Pour traiter la douleur, il est important de s'intéresser non seulement à la composante sensorimotrice (sensations), mais aussi à la sphère affectivo- émotionnelle et à la composante cognitive et comportementale.

Index alphabétique

Attribution du passage : International Association for the Study of Pain (IASP), 2020.

Attribution du passage : International Association for the Study of Pain (IASP), 1979. Ancienne définition.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 47, 48

X021 - Mécanisme nociceptif et Mécanisme neuropathique ou neurogène et Douleur psychogène dans le support

La douleur : un modèle multidimensionnel (2) Mécanismes générateurs : • Mécanisme nociceptif (origine somatique) Exemple : douleur provoquée par des traumatismes (fracture), infections (abcès), agressions chimiques ou inflammatoires • Mécanisme neuropathique ou neurogène Exemple : douleurs à type de brûlures ou de décharges électriques ou encore de picotements etc. • Mécanisme psychogène = douleurs sans cause retrouvée mais vraies (pas de douleurs simulées)

À distinguer : Terminologie du support. Une cause non identifiée ne suffit pas à conclure à une origine psychique.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 51

X022 - Expérience subjective et comportement observable dans la douleur

Expérience subjective de douleur : - Emotion (+ affect) = anxiété, peur - Cognition = signification, interprétation par le patient de sa douleur et croyances liées à la douleur Comportement observable : - Moteur : mimiques, mimiques, soupirs, attitudes antalgiques, limitations des mouvements, attitudes guindées. - Verbal : les mots… - Neurophysiologique : tachycardie, sueurs, polypnée etc.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 52

X023 - Croyance de mystère et Croyance de pérennité et Croyance de constance et Croyance de culpabilité

Les croyances relatives à la douleur Exemple d'une échelle d'inventaire des croyances et perceptions associées à la douleur (The pain beliefs and perceptions inventory (PBPI)) A partir de : Adaptation et validation française de l'inventaire de croyances et perceptions associées à la douleur: The pain beliefs and perceptions inventory (PBPI), L. Dany et al. / Pratiques psychologiques 15 (2009) 387 4 dimensions des croyances relatives à la douleur: • La dimension «mystère» : «Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai mal» = caractère mystérieux de la douleur + expérience difficilement compréhensible • La dimension «pérennité» : «Ma douleur sera toujours là» = aspect temporel de l'expérience douloureuse en termes de développement à long terme et de possibilité de douleur chronique • La dimension «constance» : «J'ai constamment mal» = aspect temporel de la douleur mais ici caractère continu ou intermittent de la douleur • La dimension «culpabilité» : «Si j'ai mal c'est uniquement de ma faute» = sentiment de responsabilité vis-à-vis de la douleur

Attribution du passage : L. Dany et collaborateurs (2009), adaptation française du PBPI citée.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 53

X025 - Douleur aiguë et douleur chronique tableau comparatif

Douleur aiguë. Définition : signal symptôme. Origine : monofactorielle. Physiopathologie : inflammation - lésion - œdème. Thérapeutique : curatrice. Douleur chronique. Définition : syndrome douloureux chronique. Origine : plurifactorielle = amalgame de nombreux facteurs qui interviennent dans l'expression de la douleur ; consultation pluridisciplinaire. Physiopathologie : étiopathogénie complexe. Thérapeutique : réadaptative ; objectifs = vivre avec douleur résiduelle et réinsertion professionnelle. Participation du patient : nécessaire sinon échec. La cellule « participation du patient » n'est pas renseignée pour la douleur aiguë dans le tableau source.

À distinguer : Comparaison schématique du cours. La participation et l'évaluation du patient comptent aussi dans la douleur aiguë.

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 58

Index alphabétique

X027 - Souffrance psychique et Douleur morale et Sidération psychique

La souffrance (2) Définitions complémentaires : La souffrance psychique est un «« un état de mal-être qui n'est pas forcément révélateur d'une pathologie. Elle indique la présence de symptômes ne correspondant pas à des critères diagnostics de maladie et qui peuvent être réactionnels à des situations éprouvantes et à des difficultés existentielles » (HAS) La douleur morale est un terme qui appartient à la terminologie de la séméiologie psychiatrique. Elle correspond à un état de détresse observé dans les dépressions profondes (dépressions mélancoliques) ; les sensations pénibles qui accompagnent la dépression (sentiment que la vie est un échec, la situation sans espoir, l'avenir impossible, perte du plaisir et d'intérêt) sont poussées à leur paroxysme, et l'on parle alors de douleur morale.

La plupart du temps, douleur morale => sidération psychique : le sujet ne peut plus penser, car la douleur est trop intense et paralyse toute activité psychique. Il faut arriver à transformer la douleur (qui ne peut pas se dire) en souffrance (qui peut s'élaborer).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 60

X028 - Dolorisme

La signification des concepts de douleur et de souffrance est construite culturellement et socialement, et cette construction aura une incidence sur la façon de les vivre, de les exprimer et d'y remédier. Les facteurs religieux et culturels : Douleur = longtemps considérée comme une nécessité ; influence de la religion chrétienne, où la souffrance avait une connotation positive, marque de piété, rachat des fautes, notion de châtiment ("tu enfanteras dans la douleur") ; parfois, exaltation de la douleur volontaire (jeûne, isolement, sévices corporels). C'est ce qu'on appelle le "dolorisme" (glorification de la souffrance).

Extrait du support officiel - Santé doc. 1 / p. 61

X030 - Modèle linéaire

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : les modèles linéaires (1) Les modèles linéaires : Selon ces modèles, la santé (ou la maladie) est à prédire en fonction de certains antécédents du sujet et de son environnement. = des causes→des effets

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 5

X031 - Modèle biomédical

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : les modèles linéaires (2) Le modèle biomédical : Modèle déjà évoqué, celui qui est encore prédominant en médecine contemporaine : maladie concerne le corps et correspond à un dysfonctionnement organique dû à l'effet de divers agents pathogènes (infections, traumatismes, lésions, tumeurs, substances toxiques etc.). S'intéresse à la maladie + qu'à la personne malade. Croyance à la séparation entre le corps et l'esprit). A été très utile pour combattre maladies infectieuses, développer vaccins et ATB. Mais est considéré aujourd'hui comme trop simpliste (modèle causes → effets), et ne suffit plus pour comprendre genèse de certaines pathologies (cancer, maladies cardio-vasculaires).

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 6

X032 - Modèle psychosomatique linéaire et Approche épidémiologique

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : les modèles linéaires (3) Le modèle de l'approche psychosomatique : = vulnérabilité psychologique (structure ou traits de personnalités, conflit psychique, expériences traumatiques précoces etc.) →maladies spécifiques (asthme, eczéma, bronchites, cancer, infarctus du myocarde etc.) Le modèle de l'approche épidémiologique : = études de groupes de sujets (malades et sains) →identification des facteurs influençant l'apparition de la maladie (facteurs liés à l'environnement, aux conditions sociales, économiques etc.)

À distinguer : Modèles historiques : ne pas déduire une maladie précise d'un conflit psychique.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 7

Index alphabétique

X034 - Modèle intégratif et multifactoriel

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : le modèle intégratif et multifactoriel (1) Rappel de la définition de la psychologie de la santé : étude du rôle de l'interaction des facteurs psychologiques, sociaux et biologiques dans le maintien de la santé ou le déclenchement et l'évolution des maladies. Le modèle proposé par la psychologie de la santé prend en compte une diversité de facteurs et leur interdépendance pour comprendre la santé ou le déclenchement et l'évolution des maladies (apparition, évolution et guérison) ; on dit que c'est un modèle multifactoriel. Il retient trois facteurs qu'il considère comme ayant un impact sur la santé : - Les facteurs environnementaux : les antécédents environnementaux mais aussi sociodémographiques, c'est-à-dire ce que l'individu « a subi », événements de vie, réseau social ; - Les facteurs individuels : les données individuelles, psychosociales et biologiques, autrement dit ce qu'il « est » ; Ces 2 types de facteurs renvoient aux antécédents de l'individu. - Les transactions entre l'individu et son contexte : ses transactions et stratégies d'ajustement, qui permettent de comprendre comment il réagit face à l'adversité.

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : le modèle intégratif et multifactoriel (2) Modèle proposé par Bruchon-Schweitzer et Dantzer (1996) : modèle intégratif, qui a pour avantage de ne pas privilégier une approche uniquement biologisante ou une approche uniquement psychologisante, et qui conçoit l'individu comme un sujet actif, avec des facultés d'adaptation aux situations de l'existence => approche globale de l'individu LE MODELE INTEGRATIF ET MULTIFACTORIEL EN PSYCHOLOGIE DE LA SANTE (BRUCHON-SCHWEITZER et DANTZER, 1994)

Attribution du passage : Bruchon-Schweitzer et Dantzer. Le support indique 1994 et mentionne aussi 1996 p. 10.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 9, 10

X035 - Prédicteurs et Déclencheurs ou stresseurs et Antécédents

Modèle basé sur 3 composantes essentielles : Les prédicteurs qui regroupent les facteurs socio-environnementaux et les facteurs personnels ; constituent les facteurs de risque et de pronostic des problèmes de santé. Comprennent : - Les déclencheurs (ou stresseurs) = éléments qui seuls ne suffiraient pas à expliquer la décompensation, mais qui y contribuent - Les antécédents = phénomènes, situations, caractéristiques qui précèdent invariablement l'apparition de la maladie ; peuvent être soit sociaux et biologiques ; soit psychiques. Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : le modèle intégratif et multifactoriel (4)

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 12

X036 - Modérateurs dans le modèle du cours et Issues ou critères d'ajustement

Les modérateurs qui désignent les transactions individu-contexte ; ont un rôle fondamental en modulant l'impact des facteurs environnementaux et personnels sur l'état de santé ; ils comprennent l'évaluation, les stratégies d'ajustement, le fonctionnement de divers systèmes physiologiques (neurologique, endocrinien, immunitaire…) Les issues, ou critères (d'ajustement/non-ajustement) qui sont l'état de santé sur lequel débouchent ces processus ; ils sont d'ordre somatiques, comportementaux, émotionnels, cognitifs

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 13

X037 - Déterminants de santé

Aperçu de quelques modèles en psychologie de la santé : le modèle intégratif et multifactoriel (6) Les antécédents environnementaux et sociodémographiques : Les déterminants de la santé = facteurs influant sur l'état de santé, c'est-à-dire : • Facteurs endogènes concernant l'individu : biologie, génétique, morphologie… • Facteurs environnementaux : géographie, lieu de travail, écologie (qualité de l'air, de l'eau, rejets industriels et agricoles), démographie (répartition des populations, isolement rural…) • Facteurs de comportement social et individuel : consommation d'alcool, tabac, drogues, sédentarité, mauvaises habitudes alimentaires, comportements sexuels à risques, comportements de prise de risque ou de violence • Facteurs liés au système de santé : accès aux soins, organisation du système de soins, connaissances médicales • Facteurs socioculturels dont les conditions culturelles : représentations des individus / maladie et santé, mais aussi comportements, normes, valeurs, racisme, sexisme, compétition, coopération • Facteurs socio-économiques : niveau de richesse de la population, qualité de l'habitat, niveau d'urbanisation, inégalités, discriminations, marché du travail, pauvreté • Changements sociaux : migrations, urbanisation, guerres, crises, récession économique • Facteurs politiques : cadre législatif et réglementaire, effort économique/programmes de soins.

NB : ces facteurs peuvent être répartis dans des modèles spécifiques.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 14

Index alphabétique

X039 - Difficultés de vie et Incidents de vie ou tracas et Événements complexes et Événements en série

Les événements de vie : définition (2) On distingue : • Les difficultés de vie, situations problématiques qui durent au moins quatre semaines, • Les incidents de vie ou tracas, événements de vie d'intensité mineure ou concernant des personnes trop éloignées du sujet. • Les difficultés naissant d'événements, les événements complexes (c'est-à-dire survenant pendant la même semaine et découlant d'un même processus) et les événements en série (événement de même thème se répétant) proches des stresseurs chroniques. Gravité, durée, fréquence, de certains événements => retentissement émotionnel => processus pathogènes qui vont se traduire par une maladie.

On peut schématiquement tenter de ranger les événements de vie dans quatre catégories : situations de perte ou d'agression, situations d'épuisement, situations d'attente, bouleversement des habitudes.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 22

X040 - Événement stressant approche qualitative

On s'est plutôt intéressé à l'aspect qualitatif de l'événement, par ex son impact ou son retentissement affectif sur le sujet au moment de sa survenue. On a vu que l'événement ne devenait facteur de stress que s'il fragilisait l'individu. Evénement stressant = pas facteur causal mais amplificateur ou aggravant d'un état de santé + ou - fragile => notion de stress perçu.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 24

X041 - Soutien social réseau soutien reçu et soutien perçu

Le soutien social : définition (1) Le soutien social renvoie à l'ensemble des aides que les individus dispensent et reçoivent de leur entourage (familial, amical, de voisinage, institutionnel). Aides de nature très diverse (pour trouver un logement ou un emploi, aide financière, soutien moral ou affectif etc.). Le soutien social est un concept multidimensionnel, on distingue : • Ceux qui offrent un soutien : le soutien social est alors défini en termes d'activités; • Ceux qui obtiennent un soutien avec 2 composantes : • Le soutien social reçu = caractéristiques objectives du soutien que reçoit l'individu ; peut se définir en termes de relation, (avoir des amis, être impliqué…) = synonyme de réseau social NB : Le réseau social correspond à l'ensemble des personnes avec lesquelles l'individu est en relation (= renvoie à la notion d'intégration sociale, c'est-à-dire le statut matrimonial, la présence de la famille ou d'amis, la participation à des groupes sociaux ou religieux).

Si réseau social important →facteur de protection de maladie / Si isolement social→risque de maladie (et de mortalité) plus important. • Le soutien social perçu = est subjectif, se situe du point de vue de la personne. Perception par l'individu de l'aide qu'il reçoit et de la disponibilité de cette aide => impact sur capacité à gérer situation stressante ; le soutien social, même potentiel, a un effet en dehors de toute situation stressante.

À distinguer : Distinguer le réseau (personnes en relation), le soutien reçu (aides effectives) et le soutien perçu (disponibilité et satisfaction). La fiche de révision clarifie cette distinction.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 26

X042 - Soutien social définition de Wallston et al

Confort, soins, estime ou aide prodigués à un individu par son entourage. Wallston et al, 1983.

Attribution du passage : Wallston et al. (1983), encadré de S2 p. 26.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 26

X043 - Les cinq dimensions du soutien social

Le soutien social : définition (2) Modèles théoriques multidimensionnels du soutien social, avec 5 dimensions communes : • L'intégration émotionnelle ou soutien émotif => la personne se sent aimée, entourée grâce à des manifestations de sollicitude, de confiance, d'empathie, d'amour, de bienveillance ; peut exprimer ses émotions et obtenir un feedback ; se produit lors de relations intimes et stables. • L'intégration sociale => la personne sent qu'elle fait partie d'un réseau de communication; implique un partage des préoccupations (échange d'idées et d'informations, vision commune de l'expérience) ; se rencontre entre collègues et amis. • Le soutien d'estime ou de valorisation personnelle => la personne se sent estimée et appréciée, grâce à des encouragements, des louanges, des compliments ; inspire courage, permet de donner ou redonner confiance à qqn dans sa propre valeur et ses capacités ; confirme la compétence à assumer correctement un rôle donné. • Le soutien informatif => aide dans la définition, la compréhension et la résolution de problèmes ; suggestions et conseils pour permettre de faire face à une situation. • Le soutien matériel ou aide tangible => la personne sent qu'elle fait partie d'un réseau d'obligations réciproques, grâce à des aides concrètes et pratiques => impression d'être déchargé d'une partie de ses fardeaux.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 27

X045 - Adéquation du soutien aux besoins

Efficacité du soutien social dépend de la concordance entre les comportements de soutien émis par l'environnement d'une personne et les besoins engendrés par ses difficultés.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 28

Index alphabétique

X046 - Mesure du soutien social reçu et Mesure du soutien social perçu

• Mesure du réseau social, c'est-à-dire de l'ensemble des personnes qui fournissent de l'aide ou avec qui un individu est en interaction ; comporte certaines caractéristiques comme : taille, statut des membres à l'intérieur du réseau, densité, degré de proximité physique, fréquence des contacts, durée de fréquentation, réciprocité. Les instruments qui mesurent les ressources du réseau identifient les rapports qui relient la personne à sa famille, à ses amis, à ses pairs = ensemble d'indicateurs objectifs des ressources sociales qui, lors d'une crise, sont susceptibles d'offrir du soutien. Ex d'instrument : SNS (Social Network Scale) qui mesure 4 indicateurs : taille du réseau, nombre de relations, densité, nombre de relations privilégiées.

Critiques = ne permettent pas de démontrer comment ces ressources apportent du soutien social et influencent l'état de la personne => pas utilisés pour évaluer qualité de l'adaptation d'une personne, mais pour évaluer sources potentielles de soutien. • Mesure du soutien social reçu = mesure du soutien actif (en opposition à un soutien potentiel) ; description comportementale du soutien apporté par les autres. Instruments = ont pour objet d'évaluer le nombre d'actions spécifiques de soutien reçues dans un passé récent. Ex : Inventory of Socially Supportive Behavior (ISSB) : mesure les comportements qui procurent du soutien à un individu, en se basant sur 4 des modalités d'expression du soutien (émotionnel, instrumental, informatif et intégratif) ; 40 énoncés.

L'instrument mesure des comportements d'aide tangibles et non tangibles. Critique : mesure de ces comportements d'aide repose sur un rappel d'expériences antérieures plutôt que d'observations actuelles. • Mesure du soutien social perçu ou subjectif = indicateur de l'appréciation du soutien, de l'évaluation cognitive faite par un sujet du soutien qu'il reçoit ; peut porter sur divers types de soutien. Instruments : tentent de mesurer les différents aspects du soutien social perçu Ex : Social Support Questionnaire (SSQ), basé sur les théories de l'attachement ; propose d'évaluer la perception de la disponibilité et de la satisfaction du soutien social.

Questionnaire de soutien social perçu de Bruchon-Schweitzer (2002) : permet d'évaluer la disponibilité (qui pourrait m'aider ?) et la satisfaction (en suis-je satisfait ?) ; soutien social peut avoir diverses sources (partenaire, famille, amis, collègues, professionnels, etc.) ; est de divers types (soutien d'estime, matériel, informatif, émotionnel

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 29

X047 - Effet direct du soutien social et Effet tampon du soutien social

Le soutien social influence la santé selon 2 modalités distinctes : 1/ Le soutien social a un effet direct et positif sur la santé et le bien-être, indépendamment du stress; il ferait fonction de barrière contre les effets du stress ; il agirait de diverses façons : • expériences positives régulières et ensemble de relations sociales stables et renforçantes => favoriserait un sentiment général de bien-être • reconnaissance de la valeur personnelle => favoriserait l'estime de soi. • => états psychologiques positifs bénéfiques pour la santé de l'individu, qui auraient plusieurs conséquences : régulation du système endocrinien ; adoption de comportements sains. 2/ Le soutien social a un effet modérateur (ou tampon, ou buffer) : surtout en situation de stress, car il intervient entre les facteurs de stress et la réponse pour diminuer les impacts néfastes du stress sur la santé et le bien-être (effet préventif reconnu sur les troubles psychologiques) = rôle médiateur dans la relation entre l'événement stressant et la santé, de trois façons différentes : • agirait positivement sur les perceptions qu'a l'individu de son environnement. • agirait au niveau de la réponse émotive liée à l'événement stressant et sur l'évaluation de ses conséquences. • agirait directement au niveau des processus physiologiques, rendant ainsi les individus moins réactifs au stress perçu

À distinguer : Effet direct : indépendamment du stress. Effet tampon : atténuation de son impact. Ne pas assimiler médiation et modération.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 31

X048 - Soins de support

Le soutien social : l'exemple des soins de support Idée de départ : répercussions du cancer sur QDV quotidienne => prise en charge ne peut se limiter au traitement de la seule maladie ; patients doivent aussi bénéficier d'un accompagnement global et personnalisé. => développement des « soins de support », depuis le milieu des années 2000 (plan cancer 2003-2007, circulaire de 2005) = ensemble des soins qui prennent en charge les conséquences, pour le malade, d'un cancer et de ses traitements => prise en charge multidisciplinaire, ininterrompue et cohérente, qui repose sur une large palette de soutiens sociaux (émotionnel, informatif, de valorisation…) Les soins de support sont complémentaires des traitements destinés à soigner la tumeur en tant que telle, et déterminants en termes de qualité de vie pour la personne malade.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 33

Index alphabétique

X049 - Caractéristiques cognitives et filtre individuel

Les éléments de l'environnement n'exercent pas leur effet de façon mécanique ; ne sont pas simplement donnés, sont aussi en partie construits (ou reconstruits) et interprétés par chaque personne en fonction de ses caractéristiques cognitives (notion de filtre). Certaines de ces caractéristiques individuelles vont jouer un rôle plus ou moins pathogène, d'autres plus ou moins protecteur. Notions de vulnérabilité et de résilience

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 34

X050 - Vulnérabilité et Vulnérabilité personnelle et Vulnérabilité environnementale

Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (1) Vulnérabilité et facteurs de risques : La vulnérabilité se définit par un état de moindre résistance aux nuisances et agressions ; concept qui évoque des faiblesses patentes ou latentes, immédiates ou différées ; peut être compris comme une impossibilité (ou incapacité) à résister aux contraintes de l'environnement. En sciences humaines, le terme de vulnérabilité est employé pour désigner des individus ou des groupes considérés comme vulnérables du fait de caractéristiques innées (génétiques, biologiques) et/ou acquises (psychosociales). Du fait de réactions au stress inadaptées ou pathologiques, ces individus sont + susceptibles que les autres de développer une maladie, ou de présenter des troubles du comportement.

Chez l'enfant la vulnérabilité se révèle face à des facteurs de risques (événements stressants, ou situations personnelles ou environnementales) qui augmentent la probabilité de développer des troubles psychologiques ou du comportement qui peuvent compromettre l'adaptation de l'enfant à son milieu. Approche de la vulnérabilité peut se concevoir selon 2 axes : • La dimension de la vulnérabilité personnelle, c'est-à-dire inhérente au sujet lui-même, du fait de sa personnalité et de son développement ; c'est la vulnérabilité centrée sur le sujet ; elle prend en compte le terrain ou les prédispositions génétiques, les ressources de la personnalité, les ressources cognitives… • La dimension de la vulnérabilité liée à l'environnement, c'est-à-dire dépendant des faiblesses du milieu et des interactions relationnelles inadéquates ; elle prend en compte la défaillance de l'environnement, qu'il s'agisse de la configuration familiale ou du contexte socio-économique + large (cf. les types d'attachement).

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 35

X051 - Facteurs de risque

Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (2) En relation avec ces axes, on a défini des facteurs de risque, qui sont des variables liées à l'apparition ultérieure de pathologies ou d'inadaptations (tout événement ou condition qui augmente la probabilité que l'individu développe des problèmes psychopathologiques). On peut les regrouper en 3 catégories : • Facteurs centrés sur l'enfant (prématurité, déficits cognitifs, séparations maternelles précoces etc.) ; • Facteurs liés à la configuration familiale (séparation parentale, violence, maladie chronique d'un parent, décès d'un proche etc.) ; • Facteurs socio-environnementaux (pauvreté et faiblesse socio-économique, situation de migrant etc.) NB : c'est le plus souvent une constellation de facteurs de risque qui peuvent devenir source de risque et non un risque pris isolément ; on a démontré que le risque de vulnérabilisation s'accroît exponentiellement avec accumulation de facteurs de risque.

Cependant, certaines études d'enfants et d'adolescents ont montré que certains d'entre eux résistent à des difficultés relationnelles, familiales et/ou à des carences affectives graves qui devraient normalement être totalement déstructurantes, et même qu'ils ont pu développer des comportements adaptés à leur environnement, et utiliser des mécanismes de défense qui leur permettent de se préserver psychiquement malgré l'adversité. La notion de résilience permet de comprendre ce phénomène.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 36

X052 - Résilience

Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (3) Résilience et facteurs de protection : La résilience est un terme employé dans le contexte de la physique des matériaux et en métallurgie pour désigner la capacité d'un matériau à retrouver son état initial suite à un choc ou une pression continue ; évoque donc des concepts de souplesse et d'adaptation En psychologie, la résilience désigne globalement un processus qui permet de sortir vainqueur d'une épreuve traumatique et de continuer à se construire malgré l'adversité => récupération après un traumatisme, réorganisation psychique, transformation à travers les épreuves.

Élaboration du concept issu des observations faites par Emmy Werner, chercheuse américaine (étude longitudinale de 30 ans, cf. livre « Overciming the Odds ») En France : travaux de Boris Cyrulnik, pour qui "la résilience définit la capacité à se développer quand même, dans des environnements qui auraient dû être délabrants". Processus complexe qui résulte de l'interaction entre l'individu et son environnement ; art de

Index alphabétique

s'adapter aux situations adverses (conditions biologiques et socio-psychologiques) en développant des capacités qui mettent en jeu des ressources internes (intrapsychiques) et externes (liens avec l'environnement social et affectif).

Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (4) La résilience : quelques définitions « Capacité pour des individus ayant subi des événements de vie très aversifs, ou même dramatiques, d'arriver à mener une vie normale. Les sujets résilients sont capables de développer, dans des circonstances parfois très difficiles, des stratégies d'ajustement adéquates qui les protègent » (Rutter, 1985).

Attribution du passage : Emmy Werner ; Boris Cyrulnik ; Rutter (1985). Le support présente plusieurs formulations, reproduites p. 37-38.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 37, 38

X053 - Facteurs de protection

Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (5) Facteurs de protection en lien avec la résilience = facteurs qui modifient la réaction à la situation en réduisant l'effet du risque et les réactions en chaîne négatives ; repose sur trois domaines : • Facteurs individuels : compétences cognitives de bon niveau ; sentiments de compétences personnelles ; habiletés dans résolution de problèmes ; capacité à trouver du soutien ; capacité à gérer le stress => base pour développement d'un fonctionnement résilient = estime de soi + sentiment de sa propre efficacité • Facteurs familiaux : soutien familial, sentiment de solidarité familiale, développement pendant l'enfance d'un attachement sécure • Facteurs de soutien : disponibilité de personnes aidantes ; présence de réseau d'aide formelle ou informels => Ces deux derniers facteurs vont apporter le sentiment d'avoir une base de sécurité interne Effets de la personnalité sur la santé : Les modèles de vulnérabilité et de résilience (6) Combinaison de facteurs « protecteurs » (selon Rutter) • Capacité à donner du sens à la situation • Capacité à agir positivement (en lien avec estime de soi, confiance en soi, sentiment d'efficacité personnelle, habileté à résoudre les problèmes) • Relations affectives stables et sécurisantes • Expériences antérieures de succès, de réussite • Capacité à interagir avec autrui

Attribution du passage : Rutter, cité p. 40 ; présentation complémentaire p. 39 sans attribution particulière.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 39, 40

X054 - Accueil expression et reconstruction dans la résilience

Attitude des soignants pouvant favoriser développement de la résilience chez qqn ayant vécu un traumatisme (maladie, handicap acquis, agression) : but = aider l'autre à se dégager de sa position de victime et intégrer le traumatisme dans son existence => 3 éléments : • L'accueil : bienveillant => disponibilité, capacité à résister aux mouvements défensifs qui peuvent se manifester chez le patient à la suite de ce traumatisme • L'expression : permettre à l'autre de vivre les émotions intenses liées au traumatisme et d'en prendre conscience, d'intégrer progressivement le traumatisme dans son histoire personnelle ; but = s'approprier l'événement au lieu de le subir. • La reconstruction : consiste pour la victime à retrouver son estime de soi, sa liberté d'agir et de s'investir ; essayer de transformer le traumatisme en une force (sublimation dans activité d'aide par exemple).

Attribution du passage : Présentation clinique dans le cours, sans auteur ou date précisés pour ces trois éléments.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 41

X055 - Profil de type A et Profil de type B et Hostilité

Personnalité et cardiopathie : Deux types de personnalité ont été décrits : • Type A = profil comportemental défini par un ensemble de caractéristiques telles que : impatience, agressivité, irritabilité, compétitivité, besoin de tout contrôler, vigueur dans les gestes et la voix, désir de réussite et de reconnaissance sociale, sur le plan cognitif : «noyau toxique» = vision négative du monde et d'autrui, affects hostiles, réponses agressives … => ensemble de facteurs de risques pouvant induire un risque coronarien . • Type B (opposé au type A), caractérisé par un faible besoin d'accomplissement de soi, l'absence d'agressivité et de compétitivité et la tolérance à l'égard d'autrui, et présentant de faibles risques de pathologie coronarienne.

Cependant, des études ultérieures n'ont pas révélé un lien aussi évident => on a alors réanalysé le type A, et montré qu'il se subdivisait en composantes + spécifiques, dont un trait de personnalité qui semble plus associé au risque coronarien : l'hostilité = attitudes, croyances et perceptions négatives concernant autrui, vu comme source de frustration, de méchanceté, d'injustice => tendance au ressentiment, désir de faire mal.

À distinguer : Profils historiques et associations discutées dans le cours ; ils ne permettent pas de prédire une maladie individuelle.

Attribution du passage : Friedman et Rosenham (1976), graphie de l'encadré S2 p. 43 ; référence associée à la comparaison des types A et B, sans attribution séparée de la phrase de définition.

Index alphabétique

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 43

X056 - Style de type C

Personnalité et cancer : Style comportemental de type C = façon particulière de s'adapter à la réalité, c'est-à-dire individus gentils, apaisants, conciliants, patients, coopérants, stoïques face à l'adversité, qui respectent l'autorité, ont des difficultés à s'affirmer, sacrifient leurs besoins au profit de ceux d'autrui et n'expriment pas leurs émotions, particulièrement les émotions négatives (colère) => caractéristiques fondamentales = suppression de émotions et réaction au stress par l'impuissance-désespoir Caractéristiques de la personnalité de type C - Inhibition, non-expression des émotions négatives, sentiment de culpabilité très présent, tendances dépressives, dévouement à autrui ++++ - Histoire de vie particulière : perte d'autrui, conflit psychique ancien non résolu… -« Façade agréable » cachant la détresse +++

À distinguer : Les résultats sur le type C et le cancer sont contradictoires. Ne pas attribuer un cancer à une personnalité ou à un défaut d'expression émotionnelle.

Attribution du passage : Temoshok (1987, 1990), encadré S2 p. 44 pour le style de type C. Shaffer et al. (1987) est cité pour une étude ; ce n'est pas une attribution de la définition.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 44

X057 - Névrosisme et Anxiété comme trait et Traits pathogènes

Effets de la personnalité sur la santé : La personnalité comme facteur de vulnérabilité (3) Traits de personnalité «pathogènes» = facteurs de vulnérabilité • L'hostilité • Le névrosisme • L'anxiété L'hostilité = Hostilité «cynique» : vision négative des autres (et de la société) = Attributions hostiles : «on m'en veut» = Affects hostiles : colère, méfiance… = Réponses agressives (comportements agressifs) = Evitement social (fuir les gens) →Maladies cardiovasculaires (idem type A) Le névrosisme = Anxiété : tendance à éprouver de la timidité, des craintes et de l'inquiétude = Dépression : tendance à éprouver des sentiments de culpabilité, de tristesse, d'impuissance et de solitude. = Timidité sociale : tendance à éprouver des émotions de honte et d'embarras = Impulsivité : incapacité à maîtriser ses désirs et ses besoins = Sentiment de vulnérabilité. →Plaintes somatiques +++ →Détresse psychologique L'anxiété (comme trait de la personnalité) = Perception des événements (de la vie) comme toujours menaçants →Asthme, ulcères, migraines →Hypertension artérielle

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 45

X058 - Traits salutogènes et Optimisme

Intérêt + récent pour les caractéristiques « salutogènes » de la personnalité, c'est-à-dire celles qui protègent l'individu et ont des effets bénéfiques sur sa santé. Traits de personnalité «salutogènes» = traits de personnalité protecteurs • L'optimisme • Le lieu de contrôle • L'auto-efficacité L'optimisme (et l'humour) = vision positive de soi et du monde = croyance en l'issue favorable des événements et de ses actions →Bonne santé physique et émotionnelle L'optimisme : Style cognitif global, tendance généralisée à anticiper une issue favorable aux événements et à avoir une perception positive de soi et du monde.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 47

X059 - Sentiment de contrôle personnel et Lieu de contrôle ou LOC et Lieu de contrôle interne et Lieu de contrôle externe

Le contrôle Sentiment de contrôle personnel = croire que, grâce à nos capacités et à nos actions, nous pouvons maîtriser ce qui nous arrive, c'est-à-dire atteindre nos objectifs et éviter les événements désagréables=> rôle protecteur en réduisant l'impact des événements de vie stressants. Notion générale qui recouvre plusieurs dénominations, dont le lieu de contrôle/Locus Of Control (LOC, Rotter, 1966), c'est-à-dire la croyance généralisée dans le fait que les événements ultérieurs dépendent ; • soit de facteurs internes (actions, efforts, capacités personnelles), • soit de facteurs externes (destin, chance, hasard, personnages tout-puissants) ; Les individus vont généralement se distinguer : • soit par le fait qu'ils vont faire un lien causal entre leurs actions ou capacités et ce qui leur arrive (contrôle interne) • soit par le fait qu'ils vont attribuer ce qui leur arrive à des facteurs extérieurs (contrôle externe) Liens contrôle/santé : selon la plupart des recherches, c'est l'internalité qui a des effets salutogènes sur le bien-être émotionnel et la santé physique, alors que l'externalité aurait des effets plutôt délétères.

Plusieurs hypothèses explicatives : l'internalité atténuerait l'effet des événements stressants ; serait un choix existentiel consistant à croire qu'on a une possibilité d'emprise sur les événements alors que le fait d'être persuadé qu'on ne peut pas maîtriser les événements entraînerait une + grande vulnérabilité ; pour sujets internes, les événements aversifs sont des défis (≠pour sujets externes = menaces ou pertes) => influence sur la santé mentale et les troubles émotionnels ; l'internalité correspondrait à style de vie + sain. Le lieu de contrôle (locus of contrôle ou LOC) ROTTER (1955 1966) ►Lieu de contrôle interne = Croire que les événements ultérieurs dépendent de soi (actions, efforts, capacités), donc que l'on peut les maitriser. →Bien-être physique et émotionnel Car

Index alphabétique

impact des événements de vie stressant ou aversifs + styles de vie sains + stratégies d'adaptation. ►Lieu de contrôle externe = croire que tout ce qui nous arrive dépend du destin, du hasard, de la chance…

Attribution du passage : Rotter (1966) ; le support affiche aussi 1955 dans son encadré.

Attribution du passage : Rotter (1966), cadre du locus of control.

Extrait du support officiel - Santé doc. 2 / p. 49

X061 - Stress selon Selye et Agent stresseur et Réaction d'alarme et Phase de résistance et Phase d'épuisement

Définition et description Le stress désigne à la fois une situation contraignante et les processus physiologiques mis en place par l'organisme pour s'y adapter. Travaux de Hans Selye (moitié du XXe siècle) = théorie du "syndrome général d'adaptation" où le stress est conceptualisé comme une réaction non spécifique, stéréotypée, innée (l'organisme réagit de la même façon, quelles que soient les agressions auxquelles il est soumis), ayant une fonction d'adaptation aux situations de danger => pas négatif en soi, est une réaction de mobilisation automatique de l'organisme qui permet de le rendre plus efficace, qui le stimule et le rend + productif.

Selye a distingué 3 phases séquentielles dans le stress : • Réaction d'alarme (ou phase de choc) = survient juste après exposition à l'agent stresseur ; l'organisme va tout faire pour s'adapter à cette situation; phase de mobilisation rapide des ressources, se traduisant par diverses réactions physiologiques • Phase de résistance : phase de mobilisation dans le temps des ressources nécessaires pour faire face à la situation ; phase de résistance en cas de persistance du stimulus stressant ; à ce stade, le stress est considéré comme bénéfique ; résistance vis-à-vis de l'agent stressant est accentuée. • Phase d'épuisement : survient si ressources du sujet sont épuisées avant fin de la confrontation à la situation stressante ; si le stress continue trop longtemps, l'organisme se fatigue.

Le stress va non seulement avoir des effets physiologiques, mais aussi psychologiques. Quand la personne est face à une situation stressante, son comportement ainsi que sa perception de l'environnement sont modifiés. L'épuisement provient du fait que l'organisme a dû fonctionner en surrégime et que par décompensation il fonctionne mal. Définition Stress ou Syndrome Général d'Adaptation selon Selye (1936) : = Réponse biologique de l'organisme à un événement de vie d'ordre physique, psychique ou émotionnel, positif ou négatif. Notion d'agent stresseur = tout stimulus persistant et/ou anormal (choc traumatique (physique ou psychologique, conditions de travail…) qui oblige l'organisme à rétablir l'équilibre homéostatique.

Attribution du passage : Hans Selye (1936).

Attribution du passage : Cadre du syndrome général d'adaptation de Selye, présenté sur la même page.

Attribution du passage : Hans Selye, cadre du syndrome général d'adaptation.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 2

X064 - Évaluation cognitive primaire et Évaluation cognitive secondaire

L'évaluation cognitive de l'événement aversif ou stressant ►Temps 1 : évaluation cognitive primaire = Comment je vis cet événement ? = événement menaçant ou non menaçant pour mon bien- être physique ou psychologique ? Si l'événement (la maladie) est vécu comme stressant (menaçant) →émotions négatives (anxiété, colère, peur…) Si l'événement est vécu comme un défi ou un challenge → émotions positives (ardeur…) ►Temps 2 : évaluation cognitive secondaire = «Puis-je faire face à cette situation et comment ?» = appréciation (évaluation) par l'individu de ses ressources personnelles (physiques, sociales, psychologiques, matérielles…) pour faire face à la situation Quand l'individu est confronté à une situation, il effectue deux évaluations : • Évaluation primaire = évaluation de ce qui est en jeu dans la situation (perte, menace, défi) ; permet au sujet de juger la valeur de l'enjeu. • Évaluation secondaire = sujet se demande ce qu'il peut faire pour remédier à la perte, prévenir la menace ou obtenir le bénéfice ; met en jeu diverses ressources adaptatives, personnelles, matérielles et sociales, que le sujet possède pour faire face : les options de coping Ces deux évaluations dépendent : • des déterminants environnementaux et situationnels (caractéristiques de la situation) : nature, durée de l'événement, ambiguïté, contrôlabilité, soutien • des déterminants dispositionnels (caractéristiques personnelles) : croyances sur soi et sur le monde, valeurs et buts personnels, estime de soi, hardiesse (enthousiasme face au changement, engagement, contrôle de soi…), bien-être psychologique, lieu de contrôle Après ces évaluations, le sujet mettra en œuvre des stratégies de coping, ayant des effets immédiats (sur l'affect, les émotions, …) et à long terme (sur le bien-être psychologique, l'état de santé ou maladie, le fonctionnement social)

Attribution du passage : Lazarus et Folkman (1984), modèle transactionnel présenté dans le cours.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 6

Index alphabétique

X066 - Stress objectif et définition interactionnelle

Dans tous les cas, les réactions au stress varient d'un individu à l'autre ou selon le contexte. Ce qui compte le plus, c'est + la manière dont l'individu va percevoir la situation que l'événement en lui-même : on parle de stress perçu, pour bien faire la distinction avec le stress objectif qui dépend des caractéristiques objectives de la situation = conception interactionnelle du stress (prise en compte de l'interaction de l'individu avec son environnement. Le stress peut être envisagé "non plus comme une réponse à un événement catastrophique mais plutôt comme l'ensemble des perceptions d'impuissance et de malaise qui envahissent l'individu face à des événements difficiles à maîtriser". (Paulhan et Bourgeois).

C'est de cette vision interactionnelle qu'est née la théorie du coping.

Attribution du passage : Paulhan et Bourgeois ; aucune date indiquée pour cette définition dans S3 p. 4 et p. 9.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 9

X067 - Coping ou stratégies d'ajustement

Le coping et ses différentes formes La notion de coping est entrée dans le langage scientifique avec le travail de Lazarus (1966) sur le stress et le coping. To cope signifie "faire face". Le coping est un concept issu de la psychologie cognitive, qui décrit les cognitions, les comportements et les affects utilisés par l'individu pour faire face à une situation : en fonction de son individualité, et face à un stresseur donné, le sujet va réagir, en mettant en place des stratégies qui vont lui permettre de s'adapter à la situation. Définitions «Ensemble d'actions cognitives et comportementales que le sujet interpose entre l'événement perçu comme menaçant et lui-même» (BRUCHON-SCHWEITZER, 2002).

«Ensemble des efforts cognitifs et comportementaux, toujours changeants, destinés à gérer (réduire, minimiser, maîtriser ou tolérer) les exigences externes et/ou internes de la situation, évaluées comme consommant ou excédant les ressources de l'individu» (LAZARUS et FOLKMAN, 1984).

Attribution du passage : Bruchon-Schweitzer (2002) ; Lazarus et Folkman (1984). Deux définitions intégrales dans le passage ci-dessous.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 10

X068 - Coping centré sur le problème et Coping centré sur l'émotion et Coping de recherche de soutien social

Il existe plusieurs sortes de coping : • Le coping centré sur le problème : vise à réduire les exigences de la situation et/ou à augmenter ses propres ressources pour mieux y faire face. Ex dans vie quotidienne : négocier un délai pour payer ses factures, rechercher un emploi mieux rétribué, consulter un médecin, augmenter ses connaissances dans certains domaines, construire un planning, rechercher des informations etc. Comprend deux facteurs plus petits : 1) la résolution du problème (recherche d'informations, élaboration de plans d'action) 2) l'affrontement de la situation (efforts et actions directs pour modifier le problème) • Le coping centré sur l'émotion : vise à gérer les réponses émotionnelles induites par la situation, en détournant son attention, en réinterprétant positivement la situation, en minimisant les conséquences, par l'évitement ou la fuite… Régulation des émotions peut se faire de diverses façons (émotionnelle, physiologique, cognitive, comportementale).

Il existe beaucoup de réponses appartenant à cette catégorie : consommer des substances, s'engager dans diverses activités distrayantes, se sentir responsable, exprimer ses émotions. Ce type de coping comprend 5 sous-dimensions : 1) fuite-évitement ; 2) minimisation de la menace avec prise de distance ; 3) réévaluation positive ; 4) auto-accusation ; 5) recherche de soutien émotionnel • Le coping centré sur la recherche de soutien social : efforts pour obtenir la sympathie d'autrui ; tentatives effectives pour obtenir une écoute, des informations, ou encore une aide matérielle Coping centré sur le problème = L'individu se focalise sur le problème en cherchant à le résoudre →d'où comportements : élaboration de plan d'action, recherche d'informations, combativité, efforts de contrôle sur la maladie etc.

Ex : Je savais ce qu'il fallait faire aussi j'ai redoublé d'efforts et j'ai fait tout mon possible pour y arriver / Je me suis battu (e) pour ce que je voulais / Je me suis concentré sur un aspect positif qui pourrait apparaître ensuite/ J'ai cherché partout des informations etc. = Coping «vigilant» ou «actif» Coping centré sur l'émotion = L'individu se focalise sur ses émotions en tentant de les gérer au mieux , voire les réduire →d'où comportements : Evitement (ne pas penser au problème, dormir plus que d'habitude…) / Distraction (écouter de la musique, regarder la télévision etc.)/ Autoaccusation (se sentir responsable de ce qui arrive etc.)/ Dramatisation etc.

Ex: J'ai essayé de tout oublier / J'ai pensé à des choses fantastiques pour me sentir mieux / Je me suis culpabilisé (e) / J'ai espéré qu'un miracle se produise…

Index alphabétique

= Coping «évitant» ou «passif» Coping centré sur la recherche de soutien social = L'individu se focalise sur la recherche de soutien social →d'où comportements : chercher la sympathie et l'aide d'autrui, une écoute, une aide matérielle etc. Ex : J'ai parlé à quelqu'un de ce que je ressentais / J'ai accepté la compréhension et la sympathie de quelqu'un / J'ai discuté avec quelqu'un de ce que je vivais etc.

À distinguer : L'efficacité du coping dépend de la situation et de sa contrôlabilité. Centré sur l'émotion ne signifie pas toujours passif ou inefficace.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 11, 12

X069 - Style de coping et Contrôlabilité

Les styles de coping sont propres à chaque individu (tendance à utiliser globalement les mêmes stratégies faces à des situations comparables : évitement, affrontement…) ; cependant, ces styles ne sont pas figés : puisque dépendent d'une évaluation de la situation, ils peuvent évoluer ; sont aussi le résultat d'un apprentissage ; si j'utilise plusieurs fois un coping qui ne réussit pas à m'aider, je vais finir par en changer, et par apprendre des façons d'agir + efficaces. La contrôlabilité de la situation est un paramètre important dans l'efficacité du coping ; contrôle = possibilité de maîtrise et d'intervention sur une situation donnée ; il peut être objectif (dépendant des caractéristiques propres de la situation) et subjectif (perçu) : • Le coping centré sur le problème, actif est efficace quand situation est effectivement contrôlable, c'est-à-dire si solution est réellement possible ; • Le coping centré sur émotion est efficace quand problème s'impose, car permet de réduire le stress • => la stratégie de coping est efficace si elle permet à l'individu de maîtriser la situation stressante et/ou de diminuer son impact sur son bien-être physique et psychique.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 13

X070 - Repères des première et deuxième topiques

Rappel concernant l'angoisse en psychanalyse : (1) La première topique (Cs, Pcs, Ics) Date de 1900. (2) La deuxième topique (Ça, Moi, Surmoi) Date de 1920.

Attribution du passage : Repère du cours : 1900. Le schéma de la seconde topique est intitulé « Le psychisme selon Freud » ; aucun prénom supplémentaire n'est ajouté.

Attribution du passage : Repère du cours : 1920. Le schéma porte la mention « Le psychisme selon Freud ».

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 14

X072 - Angoisse définition complémentaire de l'encadré

Affect (ou état affectif) marqué par un déplaisir plus ou moins intense qui se manifeste dès qu'une situation reste innommable ou irreprésentable et demeure dans l'inconscient.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 15

X073 - Angoisse face à la maladie

L'angoisse face à la maladie L'angoisse se manifeste lorsqu'il y a impossibilité de pouvoir affronter une idée, une pensée innommable ou irreprésentable, et donc de pouvoir comprendre précisément la source du mal-être et d'en parler, il y a apparition d'un autre sentiment déplaisant, l'angoisse, à la place du sentiment encore plus déplaisant, voire effrayant, qui ne parvient pas à la conscience. La maladie est donc une source d'angoisse et peut provoquer l'effondrement des systèmes de défense mis en place par le sujet. Face à la maladie, l'angoisse peut être de différentes natures : • Angoisse devant l'envahissement de la maladie, angoisse de ne pas parvenir à trouver un espace permettant d'espérer, de désirer et demander autre chose que sa situation actuelle ; • Angoisse quand on n'est pas consulté sur son mal, quand on a l'impression d'être devenu un objet de soin et non plus un sujet désirant ; • Angoisse devant l'atteinte à son intégrité, devant les transformations corporelles provoquées par la maladie, face à la douleur, aux traitements ; • Angoisse de la personne âgée devant l'impossibilité d'échapper à la dépendance, c'est-à-dire à un statut de personne assistée dépendant uniquement du bon vouloir d'autrui et à qui on ne laisse plus le choix de décisions ; • Angoisse en lien avec son entourage (crainte à la fois d'être abandonné et de les abandonner etc.) • Angoisse devant la mort, dans maladies à pronostic vital très incertain ou pour ceux qui se savent condamnés ; la personne se trouve alors confrontée au non symbolisable, puisque personne ne sait ce qu'est la mort.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 16

X078 - Dénégation et Maîtrise défensive

La dénégation « Refus de reconnaître comme siens, immédiatement après les avoir formulés, une pensée, un désir, un sentiment qui sont source de conflit » (IONESCU S., JACQUET M.-M., LHOTE C., (1997) Les mécanismes de défense. Paris, Nathan) La maîtrise « Vise à diminuer l'angoisse liée à l'incertitude de la maladie à travers la restauration d'un sentiment de contrôle sur la situation.» Le sujet veut agir sur sa propre histoire, sur la maladie, en croyant pouvoir en contrôler le processus. (RUSZNIEWSKI M., (2014) Face à la maladie grave. Paris, Dunod) = le patient peut rechercher des explications sur les causes de la maladie, des informations sur les traitements, les procédures ou encore effectuer la vérification systématique des soins infirmiers, mettant en place de véritables rites obsessionnels.

Attribution du passage : Ruszniewski M. (2014), Face à la maladie grave, Dunod.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 22

Index alphabétique

X080 - Affiliation comme défense et Humour comme défense

Ces 3 mécanismes, contrairement aux précédents, potentiellement dommageables pour une bonne gestion de l'angoisse, sont positifs, source d'adaptation réussie : L'affiliation « Recherche de l'aide et du soutien d'autrui quand on vit une situation qui engendre de l'angoisse » (IONESCU S., JACQUET M.-M., LHOTE C., (1997) Les mécanismes de défense. Paris, Nathan) = permet au patient de trouver du réconfort en se tournant vers son réseau de soutien, mais sans en devenir dépendant => mécanisme de nature adaptative précieux dans l'épreuve. L'humour « Processus qui consiste à présenter une situation vécue comme traumatisante de manière à en dégager les aspects plaisants, ironiques, insolites.

C'est dans ce cas seulement (l'humour appliqué à soi-même) qu'il peut être considéré comme un mécanisme de défense » (IONESCU S., JACQUET M.-M., LHOTE C., (1997) Les mécanismes de défense. Paris, Nathan).

Attribution du passage : Ionescu S., Jacquet M.-M. et Lhote C. (1997), Les mécanismes de défense, Nathan ; référence citée par le support.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 24

X083 - Réactions à l'annonce repères du schéma

Les étapes dans l'annonce du diagnostic (à partir d'E. Kübler-Ross). Le processus de conversion. Sidération : n'entend pas. Déni : refuse la réalité. Colère : se révolte, conteste, accuse. Marchandage : essaye d'obtenir des aménagements. Dépression : relâche sa résistance. Acceptation : accepte l'évidence. Investissement : s'engage. Légende : les phases du « deuil », d'après la grille Elizabeth Kübler-Ross. Le schéma de cette page comporte sept repères ; le tableau de la page suivante en développe six. Ces deux présentations du support sont conservées distinctement.

Attribution du passage : Schéma présenté « à partir d'E. Kübler-Ross » en S3 p. 28 ; le cours mentionne 1976 en S3 p. 27. La légende de l'image écrit « Elizabeth Kübler-Ross » : variante conservée.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 28

X084 - Sidération lors de l'annonce et Colère lors de l'annonce et Marchandage et Dépression dans le schéma du cours et Acceptation

L'annonce du diagnostic (4) : Les étapes du deuil d'E. Kübler-Ross 1. La sidération (le choc initial) Incapacité momentanée du patient à pouvoir réaliser, à réfléchir , à analyser l'information reçue. Patient sans réaction, sans parole... 2. Le déni (mécanisme de défense) - « Non, c'est impossible » - « ça ne peut pas être vrai » - « il s'est trompé de dossier » - « d'ailleurs, je n'ai jamais eu confiance en lui, je vais en consulter un autre » 3. La colère (la révolte) Sentiment d'injustice, de punition, d'agressivité, de culpabilité - « Pourquoi moi ? » - « Qu'est-ce que j'ai bien pu faire au bon Dieu ? » - « C'est injuste » etc. 4. Le marchandage (ou négociation) Négocier le traitement, la chirurgie - « Je veux bien me soigner mais pas maintenant, après le mariage de mon fils » - « La chimiothérapie, je veux bien mais si on ne faisait qu'une séance tous les mois » 5.

La dépression Prise de conscience du diagnostic , de la prise en charge, du traitement etc. - « Je m'en doutais, se plaint le sujet, je n'ai jamais eu de chance. Les tuiles, ça a toujours été pour moi » - « Juste au moment où ça commençait à aller mieux… Déjà quand j'étais petit… 6. L'acceptation Acceptation des contraintes liées au traitement, des séquelles liées à la chirurgie...

À distinguer : Le mot dépression est utilisé ici dans le schéma des réactions à l'annonce ; cela ne constitue pas à lui seul un diagnostic.

Attribution du passage : Cadre présenté à partir d'E. Kübler-Ross ; le cours indique Elisabeth KUBLER-ROSS (1976) en S3 p. 27. Les formulations du tableau p. 29 ne sont pas attribuées individuellement.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 29

Index alphabétique

X086 - Conscience de soi corporelle

C'est être conscient que l'on existe en tant qu'être humain distinct de l'entourage. On peut observer la constitution de la conscience de soi à travers les réactions de l'enfant face au miroir : il met beaucoup de temps avant de comprendre que l'image que lui renvoie le miroir est la sienne ; il reconnaît les autres, bien avant de se reconnaître lui-même. La reconnaissance de soi semble se produire vers la troisième année. Les étapes : • Entre 2 et 6 mois, l'enfant s'intéresse plus au visage d'autrui qu'à sa propre image ; il n'a pas d'idée de son propre corps et de son identité. • Vers 6 mois, il reconnaît un visage humain. Face au miroir, sourit, babille comme s'il s'agissait d'un autre enfant, qu'il cherche à saisir, ou à approcher. • Entre 6 et 15 mois, il s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe avec le miroir ; est de plus en plus intrigué et même perplexe ; joue inlassablement avec son reflet ; puis, commence à comprendre que celui qu'il voit bouger dans le miroir n'est pas une personne réelle puisqu'il ne peut la saisir, mais seulement une image qui bouge ; est passé du réel à l'imaginaire. • Entre 18 et 24 mois, à force de remarquer que cette image est totalement fidèle à ses propres mouvements, il commence à comprendre que cette image est son image, qu'elle le représente.

Acquisition du langage (qui lui permettra de se nommer) + acquiescements de ses parents => confirmation de ce pressentiment. Compréhension que l'image qu'il voit le représente = étape très importante (qui va se doubler aussi de la construction de l'espace spéculaire). Début de construction du schéma corporel et de l'image du corps.

À distinguer : Les âges du support sont des repères de développement, pas des critères diagnostiques individuels.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 32

X087 - Schéma corporel et Extéroception et Proprioception et Intéroception et Somatotopie

Définition Idée que nous avons de notre corps et grâce à laquelle nous pouvons nous représenter, à tout moment et en toutes circonstances dans nos différentes attitudes, au repos et dans l'action. Représentation topographique du corps dans l'espace qui correspond, sur le plan cortical, à ce qu'on appelle la somatotopie. Schéma corporel = connaissance, représentation, vécu que chaque individu a de son propre corps, afin de lui permettre de se situer dans l'espace. L'acquisition de ce schéma corporel permet d'établir les frontières du corps et de mieux en situer les limites. Le schéma corporel s'élabore lentement à partir des perceptions ; il résulte essentiellement de l'intégration et de la synthèse des informations sensorielles multiples à la fois extéroceptives (informations fournies par les sens : vue, ouïe-équilibre, toucher, olfaction, goût), proprioceptives (informations provenant des tendons, muscles, ligaments) et intéroceptives (informations en provenance des viscères).

Perception individuelle, qui exprime la façon dont le corps est, et s'organise dans l'espace. Schéma anatomique (perception des différentes parties de notre corps) et fonctionnel (perception de la mécanique de notre corps). = nous permet de saisir l'unité de notre corps et la localisation précise de ses parties.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 33

X088 - Construction du schéma corporel

L'acquisition du schéma corporel chez l'enfant Le schéma corporel n'est pas inné, se construit tout au long de l'enfance jusqu'à 11 ans, grâce aux expériences vécues, et en fonction de la maturation du système nerveux, des expériences sensorielles et motrices, de l'univers dans lequel les mouvements sont à faire, de la tonalité affective de cet univers etc. • À la naissance, l'enfant n'est pas conscient du monde qui l'entoure, ni de son corps propre, ni de la séparation entre les deux. • De la naissance à 3 mois environ = perception "éclatée" de son corps. • A partir de 10 mois : fait la différence entre les différentes sensations (sensations de son corps et sensations faisant intervenir les objets). • Vers 12 mois, 2 changements importants : développement de la préhension + acquisition de la marche => meilleure structuration du schéma corporel .

Pendant un moment, le schéma corporel reste approximatif, puis s'affine avec l'acquisition du langage => finit par atteindre le niveau symbolique (cf. le phénomène du membre fantôme) Le schéma corporel est à la base de notre sentiment de permanence, de continuité, et de notre relation au monde.

À distinguer : L'organisation sensorimotrice continue à évoluer ; ne pas interpréter les âges indiqués comme des seuils

Index alphabétique

rigides.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 34

X089 - Hallucinose du membre fantôme et Algohallucinose

Les troubles du schéma corporel sont essentiellement d'étiologie neurologique (lésion, dysfonctionnement etc.) Exemple de l'amputation d'un membre →le patient souffrant d'hallucinose perçoit toujours ce membre comme existant. Il peut également souffrir d'algohallucinose (douleur du membre fantôme). Et aussi: « fantôme » de sein, d'œil, de viscères, etc. D'autres troubles rentrent dans cette catégorie : asomatognosies, pouvant donner lieu à une héminégligence, autotopoagnosie, dyspraxie etc.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 36

X093 - Approche psychosomatique globale et Maladie psychosomatique dans le cours

L'approche psychosomatique s'inscrit dans une prise en compte plus globale de la maladie = approche clinique qui relie les dimensions constitutives de l'être humain au lieu de les dissocier. Cette approche repose sur la reconnaissance du lien psyché-soma comme donnée fondamentale du développement et de l'évolution de la personne. Elle peut être définie : • Du point de vue de la conception de l'homme et de la maladie = par la prise en compte de l'être humain en tant qu'être complexe, c'est-à-dire qu'au lieu de circonscrire les causes de maladie à des facteurs extérieurs (microbes etc.) ou intérieurs (génétiques), elle inclue le rôle du psychisme, et tient compte aussi de facteurs environnementaux, sociaux, voire culturels.

Cf. affections telles que asthme, troubles du sommeil, affections cutanées etc. : ces troubles n'ont pas toujours une origine organique identifiable, leur donner une origine partiellement psychique peut rassurer le patient. Cependant attention : o à ne pas faire d'une intuition devenue très populaire une vérité scientifique : pour l'instant, rien n'a été démontré scientifiquement, on se base sur des questionnements : comment se fait-il par exemple qu'une même nature de conflit psychique va s'exprimer chez certains sous forme de souffrance morale, et chez d'autre sous forme de somatisation ? o à ne pas faire du diagnostic « psychosomatique » un diagnostic de complaisance, quand on n'arrive pas à expliquer les causes de la maladie o à ne pas culpabiliser les malades en insistant sur la capacité de leur esprit à les rendre malades. • Du point de vue de la méthode = abord clinique global du patient qui intègre ses différentes dimensions => intérêt du médecin pour le fonctionnement mental du patient et pas pour son organe malade.

Maladie psychosomatique = peut être la seule réponse qu'aura trouvé l'individu pour faire face à un traumatisme ou événement douloureux auquel il n'a pas trouvé d'autre issue ; faute de pouvoir les mettre en mot, ou faute de pouvoir le gérer dans l'action, il tombe malade Le psychosomaticien cherchera alors à aller au-delà des maux du corps pour aider le malade à trouver les mots de la pensée, de l'élaboration psychique. Précisions importantes : La maladie psychosomatique est une vraie maladie ; on parle de maladie psychosomatique si la réponse somatique aux événements stressants est chronique ; il n'y a pas de causalité linéaire entre un événement et la réaction somatique, mais plutôt accumulation de difficultés mal gérées psychiquement => réaction psychosomatique .

Conclusion pour les soignants : Le psychisme de l'individu malade reste souvent opaque ; le soignant doit être humble, admettre que les mécanismes à l'œuvre lui échappent pour la plupart, ne pas déclarer que « c'est psychosomatique » pour dénigrer les dimensions qu'il ne comprend pas. Il faut être conscient que les croyances du patient (y compris sur la part de psychisme attribuée à sa maladie), son savoir profane sont à prendre en compte, car c'est une autre forme d'écoute, qui peut être très fructueuse puisqu'elle intègre des mécanismes « obscurs » et respecte l'intégralité du fonctionnement de la personne.

Extrait du support officiel - Santé doc. 3 / p. 42, 43

Index alphabétique

Sociale : passages complémentaires du support

Passages du support et repères complémentaires. Les précautions de lecture accompagnent les modèles historiques et les formulations qui demandent une distinction.

Y094 - Psychologie sociale ou psychosociologie

Appelée aussi psychosociologie, elle étudie les interactions entre l'individu et la société, entre les processus mentaux et leur dimension sociale.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 1

Y095 - Lien social affiliation attachement et socialisation

Chacun est plongé d'emblée dans un contexte, inséré dans un champ social l'établissant dans un réseau d'échanges particuliers . Tout individu est relié d'une quelconque manière à autru i (parents, fratrie, pairs, institutions, groupes etc.) et donc inséré dans un tissu social complexe qui l'enserre, oriente son action, et définit sa sociabilité. Le lien social s'actualise de plusieurs façons au cours de la vie et selon les contextes. 2. L'affiliation Liée à la nature fondamentalement sociale de l'être humain comme être -avec-les-autres, l'affiliation se traduit par les différentes formes de conduite par lesquelles on établit des liens avec autrui (cf. l'attachement).

La sociabilité humaine s' exprime par le besoin fondamental de pouvoir compter sur les autres en s'appuyant sur eux. Pourquoi s'affilier à des groupes ? a) Le modèle utilitaire Pour certains auteurs (Wilson, 1975), l'affiliation est lié en grande partie à la nécessité de coopérer afin de vivre en société , ce qui constituerait un facteur de la formation du lien social → un des mécanismes essentiels de l'affiliation est donc la découverte de l'interdépendance (ensemble de situations où la présence d'autrui est nécessaire à chacun pour poursuivre ses propres buts). b) Le modèle de la cohésion sociale Où l'attraction interpersonnelle est l'élément déterminant de la formation du groupe → attraction = dimension émotionnelle d'une relation qui se caractérise par l'expression d'attitudes positives , sympathie et désir de se rapprocher d'autrui (plus l'attraction est grande, plus la cohésion est forte). c) Le modèle de l'identification sociale L'affiliation répond dans ce modèle à un besoin identitaire (qui suis -je ?) et s'appuie sur l'auto - catégorisation (je me définis en tant que membre du groupe et j'adopte pour cela la position la plus prototypique, la plus caractéristique du groupe).

B. La formation du lien social Les relations au cours de la vie sont fortement marquées par l'enfance (premières relations sociales, grande intimité). L'entrée dans le lien social s'appuie sur 2 phénomènes : 1. L'attachement Relation affective unissant deux individus à travers la valorisation et l'importance qu'ils ont l'un pour l'autre (Bowlby, Harlow, Spitz). L'attachement est un des liens sociaux profonds qui forment le noyau des relations ultérieures de chacun et la capacité d'un individu à se lier et à s'affilier est fonction de la qualité des attachements dont il a été l'objet et qu'il a pu développer au cours de la prime enfance. 2. La socialisation Processus d'apprentissage et d'intégration sociale à travers la relation, par lesquels les individus reçoivent, apprennent et s'approprient les normes, valeurs, rôles qui régissent le fonctionnement de la vie en société, assimilation des modèles culturels de pensée et de comportement ayant deux buts : - Favoriser l'adaptation de l'individu à la vie sociale - Maintenir une certaine cohésion dans la société.

Selon les travaux de Schutz (1960), elle répond à trois besoins fondamentaux de sociabilité : 1- Besoin d'inclusion (tendance à rechercher la communication et le contact) 2- Besoin de contrôle (qui articule besoin de sécurité et d'emprise sur autrui) 3- Besoin d'affection.

Attribution du passage : Schutz (1960).

Extrait du support officiel - Sociale / p. 1, 2

Y097 - Identité chez Mead et Allport

1. Définition de G. Mead (1934) L'identité se forge à partir des interactions avec autrui et l'environnement (les réactions de l'entourage provoquent la prise de conscience de ses capacités, du rôle que l'individu joue et du regard qu'on porte sur lui). Mead définit le Soi par rapport à : - Ego (= Moi-objet, individu vécu comme objet pour lui-même, intériorisation des attitudes des autres envers lui, autre généralisé auquel l'individu s'identifie), - Je (= Moi-sujet, sentiment de l'individu pour lui-même). Le Soi est le fruit de l'interaction entre Ego et Je, cette interaction est le lieu où se forge la conscience de Soi → position propre qui consiste à s'éprouver soi -même à travers le prisme de la relation à autrui. 2.

Définition d'Allport Le sentiment d'identité (qui est aussi en rapport avec le Soi, la conscience de Soi) se décompose en plusieurs facteurs assurant sa cohérence : 1- Le sentiment physique de son corps 2- Le sentimen t de continuité temporelle (je suis la même personne hier, aujourd'hui et demain) 3- Le sentiment de valeur et d'estime de soi (en lien avec l'évaluation d'autrui vis-à-vis de nous) 4- Le sentiment d'orientation générale dans l'existence (nos objectifs, buts qui donnent et éclairent le sens de nos vies).

Attribution du passage : G. Mead (1934).

Attribution du passage : Allport, sans date précisée dans ce passage.

Index alphabétique

Extrait du support officiel - Sociale / p. 3, 4

Y098 - Identité publique et identité de choix

3. Définition de Miller (1975) On distingue : 1- Identité publique (en lien avec les normes du groupe) renvoyant au rôle social Sur son versant objectif : Sur son versant subjectif : Rôle assigné par le groupe Assomption de ce rôle par l'individu à travers l'image qu'il s'en fait 2- Identité de choix (manière dont l'individu se représente lui-même). L'identité sociale renvoie à la position occupée, aux attentes qui lui sont liées et à l'identification de l'individu à son rôle.

Attribution du passage : Miller (1975).

Extrait du support officiel - Sociale / p. 4

Y102 - Identification référents et comparaison sociale

1. L'identification A à voir avec la catégorisation (cf. expérience de Mucchielli sur l'identification d'autrui, 1980, à partir de la photo d'un batteur noir de jazz célèbre arrivant en gare, fait apparaître 2 types d'identification, l'une n'est qu'un enchaînement de stéréotypes, l'autre une évaluatio n de l'allure générale à partir d'un indice). L'identification a plusieurs sens : - Elle se réfère à des modèles sociaux et culturels orientant nos comportements pour évaluer autrui et nous -mêmes, elle est alors socialement partagée de sorte qu'elle fonction ne comme un devoir-être → fonction de cohésion sociale par l'adhésion aux valeurs/ normes du groupe. - Processus selon lequel autrui sert de modèle à un individu (ou un groupe), qui le fait sien en l'incorporant à sa propre conduite par une intériorisation e t une assimilation (cf. la notion d'identification en psychanalyse). 2.

Influence des référents identitaires Individus ou groupes (groupes sociaux de référence mais aussi référents psychosociaux = rôles, normes, mentalités, systèmes de valeurs, symboles à l'œuvre dans la pyramide sociale) qui marquent de façon particulière l'image de soi → on veut leur ressembler sur certains points et être approuvés d'eux. Deux mécanismes montrent leur importance : 1- La comparaison sociale (quête de reconnaissance, évaluation de soi par rapport à autrui) 2- L'influence normative des groupes sociaux de référence (famille, classe, catégorie socioprofessionnelle etc.). Conclusion : l'identité est un processus actif et conflictuel fondé sur l'évaluation/ l'improvisation/ la négociation.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 6

Y103 - Groupe groupe restreint et groupe secondaire

Un groupe n 'est pas juste la somme des individus qui le composent mais bien plus, du fait d'une expérience/d'un vécu communs. Les interactions des membres d'un groupe créent une entité particulière, un objet social nouveau. Importance de : 1) buts communs, intérêts communs amenant les membres du groupe à réunir leurs actions pour atteindre cet objectif, 2) nombre réduit de membres (de 3 -4 à 15 -20) dans un groupe restreint, tous en relation effective personnelle les uns avec les autres (le groupe restreint ou primaire correspond à une expérience réelle, émotionnelle, à une réalité vécue et non à un découpage théorique comme les groupes sociaux abstraits, par ex. les médecins, les femmes, les vieux etc. , le groupe primaire s'oppose au groupe secondaire qui ne passe pas par une confrontation directe, ex : les Parisiens, les salariés de FT). 3) Le groupe restreint est marqué par un sentiment d'interdépendance et d'appartenance (un « nous »), d'identité propre (croyances, attitudes etc.), un système de valeurs/normes.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 6

Y105 - Normalisation valeurs normes et statuts

3. Apparition spontanée de normes de référence (ou normalisation) Fonctions de la normalisation : 1- Réduction de l'ambiguïté 2- Evitement du conflit, recherche de consensus 3- Processus de négociation (plus facile si les enjeux sont moindres) Ces normes groupales deviennent des références communes, sorte de code d e valeurs (ce qui est bien pour le groupe). Le groupe sanctionne celui qui s'écarte des modèles de conduite ainsi définis par le mépris, la mise à l'écart, et récompense celui qui les respecte par le prestige, la popularité, le pouvoir etc. La normalisation est donc un facteur d'uniformisation dans les groupes. 4. Constitution progressive d'une organisation affective interne Plus ou moins consciente, faite des courants d'attraction, répulsion, inclination, rejets, conflits, déterminant la position des membres dans le groupe (populaire, en marge, exclus, influents etc.). 5.

Formation d'un inconscient collectif Histoire commune du groupe = conflits, rivalités entre leaders, exclusions etc. 6. Mécanismes de régulation du groupe : normes, valeurs, statuts et rôles Normes et valeurs sociales, statuts et rôles sociaux sont des mécanismes de régulation des groupes en tant qu'ils permettent sa cohésion et l'intégration de l'individu dans le groupe. a) Valeurs Considération donnée à un acte, un comportement, une situation, un sentiment. Jugée comme allant de soi, i déal social qui oriente les pensées et les actes d'un groupe (en rapport avec le jugement moral, esthétique etc.) . Les valeurs (qui sont du domaine de l'abstrait) sont r elatives à la culture,

Index alphabétique

l'époque etc. b) Normes La norme (qui est du domaine du concret) signifie la m ise en pratique de la morale du groupe, règle explicite ou implicite qui impose de façon plus ou moins prégnante un mode organisé de conduite s sociales (prescriptions imposées), ensemble de comportements c onformes aux attentes d'une collectivité.

Sa non-observance entraîne des sanctions diffuses (ex : exclusion du groupe, rejet, mise à distance etc.) ou clairement énoncées (ex : sanctions légales, peines de prison, amendes etc.). c) Statut Position occupée dans la structure sociale : - Statuts assignés (non choisis) ou non, ex : jeune, vieux, homme, femme, mari de/fille de, lien de parenté, de filiation etc. - Statuts acquis, ils renvoient à la position sociale (métier/prestige/pouvoir), au mérite/effort du sujet fourni pour y parvenir et dépendent de l'action du sujet (ex : médecin, maire, professeur etc.).

Extrait du support officiel - Sociale / p. 8

Y106 - Rôles et leadership

d) Rôle Partie dynamique du statut (manière de l'incarner). Un statut donné prescrit des droits et des devoirs associés à une position sociale qu'il détermine, d es modèles de conduite que le rôle concrétise → ensemble de conduites considérées comme normales pour le détenteur de tel statut , également fonction des attentes du groupe sur le rôle (cf. grille de Bales). Benne et Sheats distinguent 3 types de rôle dans un groupe : 1- Rôles centrés sur la tâche (mécanisme de progression) : facilitent, coordonnent les efforts du groupe, (ex : cherche r des infos, prendre des initiatives, lance r une idée, informer, clarifier, résumer etc.) 2- Rôles centrés sur le maintien de la cohésion (mécanismes d'entretien) : maintiennent le moral du groupe, médiateur qui réduit les conflits interpersonnels, harmonise, fait des compromis/protecteur qui assure l'expression et la sécurité de chacun , offre de la réassurance, encourage et protège 3- Rôles relatifs à la recherche de satisfaction des besoins individuels : freins à la progression et à l'entretien du groupe (ex : agresser, dominer, bloquer, interrompre etc.).

Comment définir le leader ? Quel est son rôle ? Toute intervention centrée sur la tâche ou le maintien de la cohésion est considérée comme un acte de leadership. Les caractéristiques d'un leader sont variables, fonction des groupes et de leurs valeurs/attentes/objectifs , cf. expérience de Lewin/Lipitt et White sur le style de leaders hip (autoritaire/démocratique/laisser-faire) → effets sur la productivité et le climat de groupe.

Attribution du passage : Benne et Sheats, sans date précisée.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 9

Y109 - Réactance déviance minorités et marginalité

1. La réactance Développement d'une motivation négative liée au sentiment d'une perte de son indépendance et qui se traduit par une résistance à l'influence pour retrouver la liberté perdue. 2. La déviance Type de conduite résultant d'un conflit entre valeurs et normes et qui place les individus en dehors du système social de règles établies, où leur conduite ne paraît plus limitée par elles. La déviance peut être une réaction aux phénomènes de désindividuation liée aux groupes (besoin de se singulariser face au groupe, réaction d'agressivité liée au refus de l'anonymat et de la similitude). Chaque groupe possède un certainseuil de tolérance à la déviance (écarts de conduite par rapport aux modèles en vigueur, principes de conduite personnels, mise en avant de son individu alité).

Si les tentatives de réintégration du déviant au groupe ne fonctionnent pas, il y a un risque d'exclusion et de rejet (cf. l'expérience de Schachter (1951). NB : Le déviant peut aussi exercer une influence cf. e xpérience de Asch (1951) au sujet du rôle du déviant sur la réduction du conformisme → un point de vue anticonformiste fait diminuer le taux de conformité et donc augmente la résistance à la pression du groupe/à l'influence sociale. Cf. aussi les travaux de Moscovici sur le poids des minorités → les minorités actives (hétérodoxe avec contre-norme ou orthodoxe avec exagération de la norme) exercent une influence (dite influence minoritaire) s'il y a : investissement relatif au problème/autonomie/consistance. 3.

D'autres types de non-conformité : le nouveau, l'étranger, le marginal - Le nouveau : l'intégration d'un nouvel élément remet en question le fon ctionnement antérieur du groupe. D'où l'importance de la forme (les circonstances de son arrivée, ses caractéristiques singulières etc.) → un nouveau peut servir de dérivation aux conflits internes du groupe (phénomène du bouc émissaire) et être utilisé par le group e pour maintenir sa structure, d'où son rejet. - L'étranger : la façon dont il réagit aux normes/valeurs du groupe est déterminante dans son acceptation (cf. le stagiaire !). - Le marginal : métaphore spatiale, en marge mais pas à l'extérieur, au bord, le marginal n'incarne que partiellement les normes et les modèles du groupe, la marginalité peut constituer une position durable dans un groupe, position à distance sans être au-dehors.

Attribution du passage : Moscovici, sans date précisée dans ce passage.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 10, 11

Index alphabétique

Y110 - Communication codage bruit et feedback

C. La communication La communication est le vecteur de l'influence sociale. 1. Les trois schémas classiques influencés par la cybernétique (N. Wiener) a) Le schéma de Laswell (1948) Emetteur Message Récepteur Répond à 5 questions : Qui ? Dit quoi ? Par quels moyens ? A qui ? Avec quels effets ? Son schéma correspond à une vision béhavioriste S -R → la communication est vue comme le trajet d'un stimulus (l'info) qui provoque une réponse (impact sur le récepteur). Canal Canal b) Le schéma de Shannon (1947) Emetteur Message Récepteur (codage) (décodage) Codage : fait de transformer une info en signe repérable (ex de code : la langue). Weaver, un linguiste, souligne la nécessité de posséder le système de règles qui a permis le codage pour être capable de d écoder et précise la notion de bruit : perturbations pouvant gêner la transmission du message et risquant de brouiller la communication.

Il y a 2 types de bruit : 1) le bruit sémantique, li é au répertoire d'un individu, il peut distordre la signification, ex : erreur de décodage lié à l'ambiguïté d'un mot, du message, 2) le bruit physique, élément concret perturbant la communication, ex : friture sur la ligne. c) Le schéma de Wiener (1948) Père de la cybernétique, il insiste sur le feedback (info en retour qui crée une boucle de rétroaction) → vision dynamique de la communication marquée par des ajustements permanents. Emetteur Message Récepteur (codage) (décodage) Feedback Ce schéma a été complété : la réflexion porte surtout sur les notions de codage et de bruits (filtre, tamis, répertoire : ensemble des références à la source des codes utilisés pour construire le message → idéologie, système linguistique, cadre sémantique, habitudes langagières etc.).

Attribution du passage : Weaver pour la notion de bruit, dans la présentation du schéma de Shannon (1947).

Extrait du support officiel - Sociale / p. 11, 12

Y112 - Crédibilité et attractivité de l'émetteur

(4) Ses caractéristiques personnelles Peuvent influer sur l'efficacité de la communication 2 caractéristiques de l'émetteur : 1- Sa crédibilité : si on attribue à l'info une source sûre, crédible, son efficacité augmente, (crédibilité = niveau d'éducation, intelligence, statut social, compétence professionnelle etc.). Certaines sources institutionnelles/individue lles sont vécues comme sûres : sciences, médecine, sociétés académiques au contraire de la police, l'armée, la justice. 2- Son attractivité : joue sur l'identification du récepteur à l'émetteur, le premier adoptant le point de vue du second sur la base des s entiments qu'il éprouve → les changements effectués sur la base de l'attractivité sont plus fragiles car lié à l'affectif, à la durabilité du lien.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 13

Y114 - Canal communication non verbale et fonctions

(2) Le canal L'air, le téléphone, la télé, un affichage, une note, un mail, son choix n'est jamais neutre dans la communication. (3) Le contexte général Environnement physique/matériel (taille de la salle, ambiance, bruit, silence, disposition des sièges, couleurs), présence de public, contexte statutaire/hiérarchique. 3. La communication non-verbale Communication hors langage, souvent inconsciente et donc involontaire. a) Organisée par 5 grands thèmes (Guittet) : (1) Le territoire Cf. recherche de E. Hall sur la proxémie, question de la distance, de l'intimité (l'espace intime est la distance entre soi et les autres en -deçà de laquelle il y a agression, viol de l'intim ité).

Dépend de la culture, du pays d'origine etc. Concerne aussi les mouvements (lourds, pesants, agiles etc.). (2) La posture Tonus, gestes, contacts corporels comme les gestes affectueux, le serrement de main etc. (3) L'image corporelle Concerne les choix vestimentaires (très marqués socialement et culturellement) entre autres. (4) Le visage et la mimique Siège d'une infinité de micro -expressions, totalement inconscientes mais parfaitement enregistrées par l'interlocuteur → grande part de ce qu'on appelle le feedbac k (contact oculaire, sourire etc., très importants dans le soin). (5) Le ton de la voix Modulé en fonction de l'interlocuteur (ferme pour se faire écouter, bas, posé et calme avec des patients inquiets/angoissés etc.). b) Remplit 3 grandes fonctions (Cranach) : (1) Fonction expressive (info par rapport à l'état émotionnel, l'opinion sur autrui, l'estime de soi) (2) Fonction d'étaiement du langage (en appui ou en contradiction du verbal) (3) Fonction quasi symbolique (désigne certains signes non équivoques comme les hochements pour dire oui)

À distinguer : Les signes non verbaux s'interprètent dans leur contexte ; aucun pourcentage universel de communication non verbale n'est à appliquer.

Attribution du passage : E. Hall, sans date précisée.

Attribution du passage : Cranach, sans date précisée.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 15, 16

Index alphabétique

Y117 - Système famille et impossibilité de ne pas communiquer

(2) Etude de la communication dans le système famille Le comportement de chaque membre e st conçu comme dépendant du comportement des autres membres et des actions de chacun sur le système . Ces comportements sont régulés par les modèles et les normes régissant le système-famille caractérisé par un principe d'homéostasie/de conservation mais au ssi un principe de changement/évolution → révolution dans la vision de la pathologie mentale qui récuse l'idée de malade désigné : le malade devient le symptôme du système familial , la maladie un mode de régulation systémique et c'est la famille entière qu'il faut prendre en charge. (3) Postulat essentiel : il est impossible de ne pas communiquer La communication apparaît alors comme un tout intégré qui comprend l'ensemble du comportement (notamment les modes de communication non lexicaux).

Ce postulat fondamen tal implique que comportement = relation à l'autre= communication (ex : je boude les bras croisé → je ne veux rien dire).

À distinguer : Il s'agit d'une lecture théorique du système familial ; elle ne permet pas de rendre la famille responsable d'une pathologie.

Attribution du passage : École de Palo Alto ; Bateson (1951) et M. Mead sont cités dans l'introduction de cette partie, sans attribution individuelle de chaque formulation.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 17

Y120 - Grille de Bales et catégories d'interaction

Bales (1950) a mis au point cette grille afin de comprendre la dynamique des interactions dans un groupe qui cherche à résoudre par la discussion certains problèmes. A partir de l'observation systématique de différents groupes de travail (classes, familles, équipes de travail), Bales a dé fini 12 catégories d'interaction rendant compte du contenus des communications et du style de relation de chacun des membres. Domaine socio-émotionnel positif : 1) Montre de la solidarité → la personne aide, encourage, gratifie les autres 2) Atténue les tensio ns → elle crée de la détente en se montrant satisfaite, en plaisantant, en dédramatisant 3) Manifeste son accord → elle comprend les actions d'autrui et abonde dans son sens Domaine de la tâche socio-opératoire : 4) Donne une suggestion → elle indique une direc tion à suivre en respectant les idées des autres 5) Exprime une opinion → elle évalue, juge, exprime sentiments/intentions 6) Donne une orientation → elle informe les autres, résume ce qui a été dit et clarifie 7) Demande une orientation → elle recherche des infos, des clarifications, fait répéter 8) Demande une opinion → elle attend des autres qu'ils donne nt leur évaluation/analyse/sentiments 9) Demande des suggestions → elle demande des idées, des façons de faire Domaine socio-émotionnel négatif : 10) Manifeste son désacco rd → elle désapprouve (passivement), refuse les orientations proposées, les offres d'aide 11) Manifeste de la tension → elle exprime la gêne, se retire du groupe 12) Montre de l'antagonisme → elle s'oppose aux autres, rabaisse leur statut, les critique.

Toutes ces relations mises en correspondances 2 à 2 renvoient à 6 types de problèmes auxquels les groupes sont constamment confrontés : a = 6&7 ; b = 5&8 ; c = 4&9 ; d = 3&10 ; e = 2&11 ; f = 1&12 a) Problème de communication b) Problème d'évaluation c) Problème de contrôle d) Problème de décision e) Problème de réduction de la tension f) Problème de réintégration sociale

Attribution du passage : Bales (1950), catégories de la grille présentée dans le support.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 18, 19

Index alphabétique

Y121 - Profils d'interaction

Le nombre, le type d'interactions, leur fréquence d'apparition permettent de dégager des profils d'interaction : 1- Au niveau des personnes (l'individu qui commu nique le plus reçoit aussi le plus de messages, les émissions sont d'abord dirigé es vers les membres les plus actifs, ensuite vers le groupe en général) 2- Au niveau des rôles : n'importe qui peut devenir leader , son style dépend de ses interventions sur : 1) la tâche (évaluation/contrôle) → il règle la division du travail, la participation des autres est faible, 2) les info s (explication, clarification) → il maintient la cohésion du groupe , la participation des autres est plus forte.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 20

Y123 - Stéréotype endogroupe et exogroupe

2. Stéréotype Terme créé par Lippmann (1922) désignant les catégories descriptives simplifiées par lesquelles nous cherchons à situer autrui ou des groupes. Etymologie : de stéréos, solide en grec, typos, le caractère, ce concept est introduit en psychologie sociale pour défin ir les phénomènes de croyances et de représentations, c e sont des « images dans nos têtes »(Lippmann) qui s'intercalent entre la réalité et notre perception, en provoquant une schématisation (schème perceptif associé à certaines catégories de personnes/obj ets, cristallisé autour d'un mot qui les désigne et intervenant automatiquement dans la représentation et la caractérisation des spécimens de ces catégories) .

Ensemble des catégories dans lesquelles nous plaçons les autres. Idée fixe et conventionnelle au sujet d'un groupe interprétant des faits observés de manière déformée, le stéréotype est le résultat d'une simplification excessive, il est répétitif et rudimentaire . Il existe des stéréotypes nationaux, ethniques, socioprofessionnels (ex : le Parisien, la femme, l'enfant, le communiste, l'Algérien etc.). Les stéréotypes sont en général nettement plus favorables pour nos groupes d'appartenance (in - group, endogroupe, intragroupe), que pour les autres (out-group, exogroupe, hors-groupe).

Extrait du support officiel - Sociale / p. 20

Y126 - Ethnocentrisme et groupes minimaux

6- Expérience de Shérif (1953, 1955, 1961) sur la justification sociale s'appuyant sur la compétition intergroupe dans des camps de vacance de garçons → chaque groupe considère qu'il est le meilleur, les 2 équipes se détestent, se forgent des stéréotypes sur l'autre groupe servant de justification voire d'anticipation des conflits, on observe la sanction de toute manifesta tion positive à l'égard d'un membre de l'exogroupe, le développement des préjugés associé à un sentiment de supériorité/valorisation de soi (par identification au groupe), vécu à l'extérieur comme un sentiment « ethnocentrique » (supériorité exagérée etc.) . Expérience de Tajfel/Billig/Bundy/Flament (1971) → paradigme des groupes minimaux : la simple segmentation d'un collectif en deux sou s- groupes définis de manière arbitraire génère favoritisme pour l'in -group (sentiment de supériorité, valorisation de soi etc.) et discrimination pour l'out-group.

La solidarité intra- groupe est vécue de l'extérieur comme une mise à l'écart.

Attribution du passage : Shérif (1953, 1955, 1961), présentation de l'expérience dans le support.

Extrait du support officiel - Sociale / p. 21, 22

Index alphabétique

Index alphabétique commun

P, D, H, S, X et Y : familles du recueil. Les nombres sont les pages de ce document. Chaque repère est cliquable.

A

Abréaction : P 12
Acceptation : X 66
Accommodation : D 29
Accord dans la grille de Bales : Y 73
Accordage affectif : S 44
Accueil dans la résilience : X 61
Accueil expression et reconstruction dans la résilience : X 61
Acquis : D 27
Acte manqué : P 13
Activisme : P 19 · H 42
Adaptation : D 28
Adéquation du soutien aux besoins : X 58
Adéquation du soutien social : X 58
Adolescence : D 33
Affect : P 13
Affiliation : S 44
Affiliation - mécanisme de défense : H 42
Affiliation comme défense : X 66
Affiliation comme défense et Humour comme défense : X 66
Affiliation sociale : Y 69
Agent stresseur : X 63
Aidant : D 35
Algies / céphalées : P 24
Algohallucinose : X 68
Alliance de caregiving : D 31
Alliance thérapeutique : P 11
Allophonie : D 34
Altruisme : P 20
Ambivalence : P 17 · D 27
Amnésie infantile : P 17
Amour d'objet : P 16
Analphabétisme : D 34
Anesthésie corporelle : P 24
Anesthésie psychique : P 24
Angoisse : P 17 · H 41
Angoisse automatique : P 17
Angoisse de dévoration : P 24
Angoisse de séparation : D 30
Angoisse définition complémentaire de l'encadré : X 65
Angoisse définition de l'encadré : X 65
Angoisse face à la maladie : X 65
Angoisses de castration : P 18
Angoisses de morcellement : P 17
Angoisses de perte d'objet : P 17
Anhédonie : P 21
Animisme : D 32
Annonce du diagnostic : H 42
Annulation rétroactive : P 18
Anosognosie : P 9 · D 35
Antagonisme dans la grille de Bales : Y 73
Antécédent / diagnostic principal : P 25
Antécédents : X 57
Anxiété comme trait : X 62
APA / OMS : P 22
Aphasie : P 24
Aphonie : P 24
Appareil psychique : P 13
Appartenance sociale : S 45
Apprentissage vicariant : P 10
Approbation sociale : S 45
Approche biologique : P 10
Approche biopsychosociale : H 38
Approche environnementaliste : P 10
Approche épidémiologique : X 56
Approche interactionniste : P 10
Approche personnaliste : P 10
Approche psychosomatique : H 39
Approche psychosomatique globale : X 68
Approche psychosomatique globale et Maladie psychosomatique dans le cours : X 68
Approche syncrétique : P 10
Approche systémique : P 11 · S 49
Apraxie : D 35
Argumentation : D 34
Argumentation unilatérale et bilatérale : S 49
Artificialisme : D 32
Assimilation : D 28
Associations libres : P 12
Astasie-abasie : P 24
Athéorique : P 25
Attachement : D 30 · S 44
Attachement chez le sujet âgé : D 36
Attachement désorganisé : D 31
Attachement et troubles neurocognitifs : D 36
Attachement insécure ambivalent / résistant : D 31
Attachement insécure évitant : D 31
Attachement sécure : D 31
Attachement symbolique chez le sujet âgé : D 36
Atteinte fonctionnelle : P 11
Attention conjointe : D 30
Atténuation des tensions dans la grille de Bales : Y 73
Attraction interpersonnelle : S 44
Attractivité de la source : S 49
Attractivité de l'émetteur : Y 72
Auto-catégorisation : Y 69
Auto-efficacité : H 40
Auto-érotisme : P 16
Auto-évaluation : X 53
Automatisme mental : P 23
Autonomie : D 33
Autonomie comportementale : D 34

B

Babillage : D 29
Barrage : P 23
Base de sécurité : D 30
Béhaviorisme : P 10
Belle indifférence : P 11
Bénéfice primaire : P 21
Bénéfice secondaire : P 21
Besoin d'affection : Y 69
Besoin de contrôle dans la sociabilité : Y 69
Besoin d'inclusion : Y 69
Besoin primaire de contact : D 36
Besoin primaire de proximité : D 36
Besoins de sociabilité selon Schutz : S 44
Biais cognitif : P 11
Bouc émissaire : S 48
Bouffée délirante aiguë · BDA : P 23
Bruit de communication : Y 72
Bruit physique : S 48
Bruit sémantique : S 48
But pulsionnel : P 13

C

Ça : P 14
Canal : S 48
Canal communication non verbale et fonctions : Y 72

Capacité métasyntaxique : D 32
Caractéristiques cognitives et filtre individuel : X 60
Caregiver : D 30
Caregiving : D 30
Carence affective : D 31
Carence du préconscient : P 25
Catégorisation : D 28
Catégorisation sociale : S 50
Catharsis : P 12
Causalité circulaire : P 11
Censure : P 14
Centralisation du réseau : S 50
CFTMEA : P 22
CIM : P 22
Classification : P 21
Classification / inclusion : D 33
Classification catégorielle : P 21
Classification dimensionnelle : P 21
Classification typologique : P 21
Clinique du pathologique : P 24
Clique / bande : D 34
Clivage de l'objet : P 19
Clivage du Moi : P 19
Clivage institutionnel : P 20
Clownisme : P 12
Codage : Y 72
Codage et décodage : S 48
Code de communication : S 51
Cognition : P 11
Cognition dans le modèle de la douleur : X 55
Cognition sociale : D 33
Cohésion du groupe : S 46
Cohésion et singularité identitaires : D 37
Colère lors de l'annonce : X 66
Combativité : H 42
Combinatoire : D 33
Communication : S 48
Communication analogique : S 50
Communication codage bruit et feedback : Y 72
Communication complémentaire : S 49
Communication consommatoire : S 49
Communication digitale : S 50
Communication incidente : S 48
Communication instrumentale : S 49
Communication non verbale : S 49
Communication paradoxale : S 51
Communication persuasive : S 49
Communication symétrique : S 49
Comorbidité : P 21
Comparaison sociale : S 46
Complaisance : S 47
Complexe d'Œdipe : P 17
Comportement d'attachement : D 30
Comportement désadapté : P 9
Comportement observable dans la douleur : X 55
Compulsion de répétition : P 15
Condensation : P 12
Conditionnement classique ou répondant : P 10
Conditionnement opérant ou instrumental : P 10
Conflit psychique : P 15
Conformisme : S 47
Conformisme par identification : S 47
Congruence : S 49
Conscience de soi : H 43
Conscience de soi corporelle : X 67
Conscience de soi intime : S 45
Conscience de soi publique : S 45
Conservation : D 33
Consistance d'une minorité : S 48
Construction du schéma corporel : X 67
Construction opératoire du nombre : D 37
Contact avec la réalité : P 9
Contagion émotionnelle : D 33
Contenu latent : P 12
Contenu manifeste : P 12
Contexte de communication : S 48
Contexte général de communication : Y 72
Continuité temporelle de l'identité : D 37
Continuité temporelle de soi : S 45
Contre-transfert : P 20
Contrôlabilité : X 65
Contrôle perçu : H 40
Contrôle sphinctérien : D 28
Conversion : P 11
Coordination intersensorielle : D 28
Coordination visuo-manuelle : D 28
Coping / stratégies d'ajustement : H 41
Coping centré sur le problème : H 41
Coping centré sur le problème et Coping centré sur l'émotion et Coping de recherche de soutien social : X 64
Coping centré sur le soutien social : H 41
Coping centré sur l'émotion : H 41
Coping de recherche de soutien social : X 64
Coping ou stratégies d'ajustement : X 64
Corps fantasmatique : P 11
Corps-objet : H 42
Corps-sujet : H 42
Couvade psychosomatique : D 28
Crédibilité de la source : S 49
Crédibilité de l'émetteur : Y 72
Crédibilité et attractivité de l'émetteur : Y 72
Critères pratiques du pathologique : D 37
Croyance de constance : X 55
Croyance de culpabilité : X 55
Croyance de mystère : X 55
Croyance de mystère et Croyance de pérennité et Croyance de constance et Croyance de culpabilité : X 55
Croyance de pérennité : X 55
Croyance du second ordre : D 33
Culpabilité : P 14

D

Décentration : D 32 · S 44
Déclencheurs ou stresseurs : X 57
Décompensation : P 18
Délire : P 23
Demande de suggestions dans la grille de Bales : Y 73
Demande d'opinion dans la grille de Bales : Y 73
Demande d'orientation dans la grille de Bales : Y 73
Dénégation : P 18 · D 34 · H 42
Dénégation et Maîtrise défensive : X 65
Déni : P 19 · D 34 · H 41
Dépersonnalisation : P 23
Déplacement : P 18 · H 41
Dépression : D 35
Dépression anaclitique : D 31
Dépression dans le schéma du cours : X 66
Désaccord dans la grille de Bales : Y 73
Désir de grossesse : D 27
Désir d'enfant : D 27
Déterminants de santé : X 57
Deuil : D 34
Deuil de l'enfant imaginaire : D 27
Deuil et travail de deuil : P 25
Deuxième topique : X 65
Déviance : S 47
Déviance sociale : P 9
Diachronie : P 9

Index alphabétique

Diagnostic : P 20
Diagnostic de rétablissement : P 22
Diagnostic différentiel : P 21
Diagnostic non spécifié : P 22
Diagnostic provisoire : P 22
Difficulté de vie : H 39
Difficultés de vie : X 58
Difficultés de vie et Incidents de vie ou tracas et Événements complexes et Événements en série : X 58
Dilemme moral : D 34
Dimensions de la qualité de vie : X 53
Discrimination : S 50
Discrimination perceptive : D 28
Disease : H 38
Dissociation psychiatrique : P 23
Dissonance cognitive : S 51
Dolorisme : X 56
Domaines et facettes de la qualité de vie : X 53
Double contrainte : S 50
Douleur - formulation historique IASP 1979 : H 39
Douleur - formulation IASP 2020 : H 39
Douleur aiguë : X 55
Douleur aiguë et douleur chronique tableau comparatif : X 55
Douleur chronique : H 39
Douleur chronique dans le tableau comparatif : X 55
Douleur définition IASP 1979 : X 54
Douleur définition IASP 2020 : X 54
Douleur définition IASP 2020 et Douleur définition IASP 1979 : X 54
Douleur du membre fantôme : H 39
Douleur morale : H 39
Douleur psychogène dans le support : X 55
DSM : P 22
Dualisme pulsionnel : P 15
Dynamique de groupe : S 46
Dyscalculie : D 32
Dyslexie : D 32
Dysorthographie : D 32

E

Échelle de Holmes et Rahe : H 39
Effet direct du soutien social : X 59
Effet direct du soutien social et Effet tampon du soutien social : X 59
Effet placebo : P 26
Effet Pygmalion : S 51
Effet tampon du soutien social : X 59
Ego ou Moi objet chez Mead : Y 69
Égocentrisme cognitif : D 32
Égodystonique / égosyntonique : P 24
Élaboration secondaire : P 12
Émetteur : S 48
Émotion : D 32
Empathie - psychologie du développement : D 33
Empreinte : D 31
Encodage / stockage / récupération : D 34
Encoprésie : D 28
Endogroupe et exogroupe : S 50
Endogroupe ou in group : Y 74
Enfant imaginaire : D 27
Enfant réel : D 27
Engagement dans l'action : S 47
Engagement identitaire : S 45
Énurésie : P 24
Énurésie nocturne : D 28
Épidémiologie : P 9
Épigenèse : D 27
Épisode dépressif caractérisé · EDC : P 21
Épistémologie : P 9
Équilibration : D 29
Équilibre santé maladie et santé relative : X 52
Erreur A-non-B : D 28
Estime de soi : D 34 · S 45
État agentique : S 47
État de santé perçu : X 52
État hypnoïde : P 25
États-limites : P 18
Étayage : P 15 · D 30
Ethnocentrisme : S 51
Ethnocentrisme dans l'expérience de Shérif : Y 74
Ethnocentrisme et groupes minimaux : Y 74
Éthologie : D 31
Étiologie : P 9 · D 36
Étude longitudinale : P 9
Évaluation cognitive primaire : X 63
Évaluation cognitive primaire et Évaluation cognitive secondaire : X 63
Évaluation cognitive secondaire : X 63
Évaluation primaire : H 40
Évaluation secondaire : H 40
Événement de vie : H 39
Événement stressant approche qualitative : X 58
Événement stressant dans l'approche qualitative : X 58
Événements complexes : X 58
Événements en série : X 58
Évitement : P 11
Excitation : P 13
Exogroupe ou out group : Y 74
Expérience subjective de douleur : X 55
Expérience subjective et comportement observable dans la douleur : X 55
Exploration identitaire : S 45
Expression dans la résilience : X 61
Extéroception : X 67
Extinction : P 10

F

Facteur de protection : H 38
Facteur de risque : H 38
Facteur salutogène : H 38
Facteurs de protection : X 61
Facteurs de risque : X 60
Fading : P 23
Famille association : D 37
Famille bastion : D 37
Fantasme : P 12
Fausse croyance : D 33
Faux négatif : P 21
Faux positif : P 21
Favoritisme endogroupe : S 50
Feedback ou rétroaction : S 48
Fidélité inter-juges : P 21
Fidélité temporelle : P 21
Figuration : P 12
Figure d'attachement : D 30
Filtre individuel : X 60
Finitude : D 34
Fixation : P 17
Flux de communication : S 50
Fonction d'étaiement du langage : Y 72
Fonction d'étayage du langage : S 49
Fonction expressive du non-verbal : S 49
Fonction quasi symbolique : S 49
Fonction sémiotique : D 32
Fonctionnel / lésionnel : P 24
Formation de compromis : P 12
Formation réactionnelle : P 18

G

Génotype : D 27
Graphème : D 29
Grille de Bales : S 50

Index alphabétique

Grille de Bales et catégories d'interaction : Y 73
Groupe : Y 70
Groupe groupe restreint et groupe secondaire : Y 70
Groupe primaire et groupe secondaire : S 46
Groupe restreint : S 46
Groupe restreint ou primaire : Y 70
Groupe secondaire : Y 70

H

Hallucination : P 23
Hallucinose du membre fantôme : X 68
Hallucinose du membre fantôme et Algohallucinose : X 68
Handicap : H 38
Handicap et limitation : P 9
Handling : D 31
Hétéro-évaluation : X 53
Hétéro-évaluation et Auto-évaluation et Mesures objectives dans la qualité de vie : X 53
Hétéronomie : D 33
Histoire collective du groupe : S 46
Holding : D 31
Homéostasie du système familial : Y 73
Homéostasie d'un système : S 49
Honte : P 14
Hospitalisme : D 31
Hostilité : H 40
Humour : P 19
Humour - mécanisme de défense : H 42
Humour comme défense : X 66
Hypersomnie / insomnie : P 22
Hypocondrie : P 23
Hypothèse étiopathogénique : P 20
Hystérie : P 11

I

Idéal du Moi : P 14
Idéalisation : P 19
Identification : P 19 · D 27 · S 46
Identification à l'agresseur : P 19
Identification référents et comparaison sociale : Y 70
Identification sociale : Y 70
Identité : D 33
Identité achevée : S 45
Identité chez Mead et Allport : Y 69
Identité corporelle : H 42
Identité de choix : S 45
Identité diffuse : S 46
Identité forclose : S 46
Identité moratoire : S 45
Identité publique : S 45
Identité publique chez Miller : Y 70
Identité publique et identité de choix : Y 70
Identité sociale : S 44
Idéologie : D 37
Illettrisme : D 34
Illness : H 38
Illusion de corrélation : S 51
Image corporelle dans la communication : Y 72
Image corporelle dans la communication non verbale : S 51
Image du corps : D 33 · H 42
Image mentale : D 32
Imitation différée : D 29
Impossibilité de ne pas communiquer : Y 73
Impulsion / compulsion : P 23
Incidence : D 36
Incidents de vie ou tracas : X 58
Inconscient · Ics : P 14
Inconscient cognitif : P 11
Inconscient collectif du groupe : Y 70
Incorporation : P 16
Infantilisation : D 35
Influence minoritaire : S 48
Influence sociale : S 47
Injonction paradoxale : S 50
Inné : D 27
INRC : D 33
Insight : D 29
Instinct : P 13
Intégration sociale : X 58
Intellectualisation : P 19
Intelligence cristallisée : D 35
Intelligence fluide : D 35
Intelligence opératoire concrète : D 29
Intelligence opératoire formelle : D 29
Intelligence préopératoire : D 29
Intelligence sensori-motrice : D 29
Intentionnalité : D 29
Interdépendance : S 44
Intériorisation : S 47
Intériorisation des stéréotypes : S 51
Intéroception : X 67
Intrication pulsionnelle : P 15
Introjection : P 19
Introspection : D 33
Investissement dans le schéma de l'annonce : X 66
Investissement libidinal : P 15
Isolation : P 18 · H 42
Issues ou critères d'ajustement : X 57

J

Je ou Moi sujet chez Mead : Y 69
Jeu symbolique : D 32

L

LAE : D 30
Lallation : D 29
Lapsus : P 12
Le nouveau dans le groupe : Y 71
Leadership : S 47
Leadership autoritaire : S 47
Leadership démocratique : S 47
Leadership laisser-faire : S 47
Lecture existentialiste du pathologique : D 37
Lecture professionnelle du pathologique : D 37
Les cinq dimensions du soutien social : X 58
L'étranger dans le groupe : Y 71
Lexique : D 29
Libido : P 15
Libido narcissique : P 15
Libido objectale : P 15
Lien social : S 44
Lien social affiliation attachement et socialisation : Y 69
Lieu de contrôle : S 45 · H 40
Lieu de contrôle externe : X 62
Lieu de contrôle interne : D 34
Lieu de contrôle ou LOC : X 62
Logique des propositions : D 33

M

Maîtrise : H 42
Maîtrise défensive : X 65
Maladie : H 38
Maladie chronique : H 38
Maladie psychosomatique dans le cours : X 68
Mandat transgénérationnel : D 27
Manie / hypomanie : P 22
Marchandage : X 66
Marginalité : S 48
Mécanisme de défense : P 18

Index alphabétique

Mécanisme neuropathique ou neurogène : X 55
Mécanisme nociceptif : X 55
Mécanisme nociceptif et Mécanisme neuropathique ou neurogène et Douleur psychogène dans le support : X 55
Mécanismes de défense : H 41
Mélancolie / manie et PMD : P 23
Mémoire : D 34
Mémoire à court terme : D 34
Mémoire à long terme : D 35
Mémoire de travail : D 35
Mémoire déclarative : D 35
Mémoire épisodique : D 35
Mémoire non déclarative : D 35
Mémoire procédurale : D 35
Mémoire sémantique : D 35
Mémoire sensorielle : D 34
Message : S 51
Mesure du soutien social perçu : X 59
Mesure du soutien social reçu : X 59
Mesure du soutien social reçu et Mesure du soutien social perçu : X 59
Mesures objectives dans la qualité de vie : X 53
Métacommunication : P 11 · S 50
Métapsychologie : P 13
Métatexte : D 37
Méthode cathartique : P 12
Mimique : S 49
Minorité active : Y 71
Minorité hétérodoxe : Y 71
Minorité orthodoxe : Y 71
Minorité orthodoxe et hétérodoxe : S 48
MIO : D 30
Mise à l'écart : P 20
Modèle bio-psycho-social : P 10
Modèle biomédical : X 56
Modèle de la cohésion sociale : S 44
Modèle de Lasswell : S 48
Modèle de l'identification sociale : S 44
Modèle de Shannon : S 48
Modèle de Wiener : S 48
Modèle en réseau de symptômes : P 22
Modèle explicatif endogène : X 54
Modèle explicatif exogène : X 54
Modèle explicatif exogène et Modèle explicatif endogène : X 54
Modèle intégratif et multifactoriel : X 57
Modèle linéaire : X 56
Modèle processuel : P 22
Modèle psychosomatique linéaire : X 56
Modèle psychosomatique linéaire et Approche épidémiologique : X 56
Modèle utilitaire de l'affiliation : S 44
Modérateurs dans le modèle du cours : X 57
Modérateurs dans le modèle du cours et Issues ou critères d'ajustement : X 57
Moi : P 14
Moi-objet : S 45
Moi-sujet : S 45
Monisme phallique : P 17
Morale conventionnelle : D 34
Morale postconventionnelle : D 34
Morale préconventionnelle : D 34
Moratoire identitaire : D 33
Morbidité / indice morbide : P 24
Mortalité / morbidité : P 22
Mot pivot : D 29
Mot-phrase / holophrase : D 29
Mutisme : P 24

N

Narcissisme : P 16 · D 34
Néoténie : D 28
Neurasthénie : P 22
Névrose : P 18
Névrose d'angoisse : P 22
Névrose de destinée : P 25
Névrose obsessionnelle : P 23
Névrose phobique : P 23
Névroses actuelles / de transfert : P 22
Névrosisme : X 62
Névrosisme et Anxiété comme trait et Traits pathogènes : X 62
Normalisation : S 46
Normalisation du pathologique : P 9
Normalisation valeurs normes et statuts : Y 70
Normalité : P 9
Normalité comme absence de maladie : D 36
Norme idéale : D 36
Norme sociale : D 27 · S 46
Norme statistique : D 27
Normes : Y 70
Nosographie : P 20
Nosologie : P 20

O

Obéissance : S 47
Object-presenting : D 31
Objet externe : P 16
Objet interne : P 16
Objet partiel : P 16
Objet pulsionnel : P 13
Objet total ou global : P 16
Objet transitionnel : D 31
Œdipe positif, négatif et complet : P 17
Opérations infralogiques : D 33
Opérations logico-mathématiques : D 33
Opinion dans la grille de Bales : Y 73
Optimisme : H 40
Organisation affective du groupe : S 46
Organisation affective interne du groupe : Y 70
Organogenèse : P 10
Orientation dans la grille de Bales : Y 73

P

Pairs : S 44
Paradigme des groupes minimaux : S 50
Paranoïa / psychose paranoïaque : P 23
Paraphrénies : P 23
Pare-excitation : P 14
Parésie / paralysie : P 24
Partenariat corrigé quant au but : D 30
Passage à l'acte : P 24
Pathogénie : D 36
Pathologie du psychologique : P 24
Pathologique : P 9 · D 27
Pathologisation du normal : P 9
Pathoplasticité : P 9
Patient désigné : P 11 · S 49
Pensée hypothético-déductive : D 33
Perception sociale : S 50
Perception-conscience · Pc-Cs : P 14
Période de latence : P 17
Permanence de l'objet : D 28
Personnalité : H 40
Perversion : P 18
Phase de résistance : X 63
Phase d'épuisement : X 63
Phase expulsive : P 16
Phase rétentive : P 16
Phénomène transitionnel : D 31
Phénotype : D 27
Phonème : D 29
Pince pouce-index : D 28
Plainte : H 39
Plainte mnésique : D 35
Plasticité cérébrale : D 27
Point de vue dynamique : P 15
Point de vue économique : P 14

Index alphabétique

Point de vue topique : P 14
Pointage / pointing : D 29
Polysémie : S 49
Posture : S 49
Posture dans la communication : Y 72
Poussée pulsionnelle : P 13
Pragmatique du langage : D 32
Préconscient · Pcs : P 14
Prédicteurs : X 57
Prédicteurs et Déclencheurs ou stresseurs et Antécédents : X 57
Préhension : D 28
Préjugé : S 50
Première théorie freudienne de l'angoisse : P 25
Première topique : X 65
Préoccupation maternelle primaire : D 27
Présentation de soi : S 45
Pression de conformité : S 47
Prévalence : D 36
Prévention : X 52
Prévention et promotion des comportements de santé : X 52
Primat du génital : P 17
Principe de constance : P 15
Principe de plaisir : P 15
Principe de réalité : P 15
Processus primaire : P 15
Processus secondaire : P 15
Processus transdiagnostique : P 22
Prodrome : P 12
Profil de type A : X 61
Profil de type A et Profil de type B et Hostilité : X 61
Profil de type B : X 61
Profils d'interaction : Y 74
Progression céphalo-caudale : D 28
Progression proximo-distale : D 28
Projection : P 19 · H 41
Projection agressive : H 41
Projet d'enfant : D 27
Pronostic : X 54
Prophétie autoréalisatrice : S 51
Prophylaxie : P 10
Proprioception : X 67
Prosodie : D 29 · S 48
Protestation / désespoir / détachement : D 31
Prototype du groupe : S 44
Proxémie : S 49
Proxémie et espace intime : Y 72
Proximité dans l'attachement : D 36
Psychanalyse : P 11
Psyché-soma : P 24 · D 31
Psychiatrie : P 9
Psychogenèse : P 10
Psychologie clinique : P 9
Psychologie de la santé : H 38
Psychologie de l'enfant : D 27
Psychologie du développement : D 27
Psychologie du pathologique : P 24
Psychologie sociale : S 44
Psychologie sociale ou psychosociologie : Y 69
Psychopathologie : P 9
Psychose : P 18
Psychose hallucinatoire chronique · PHC : P 23
Psychothérapie : P 10
Puberté : D 33
Puberté et remaniement psychosexuel : P 25
Pulsion : P 13
Pulsion de mort · Thanatos : P 15
Pulsion partielle : P 15
Pulsions d'autoconservation : P 15
Pulsions de vie · Éros : P 15
Pulsions sexuelles : P 15

Q

Qualité de vie : H 38
Qualité de vie liée à la santé : X 53

R

Ralentissement psychomoteur : P 21
Rappel / reconnaissance : D 35
Rationalisation : P 19 · H 41
Réactance : S 47
Réactance déviance minorités et marginalité : Y 71
Réaction circulaire primaire : D 29
Réaction circulaire secondaire : D 29
Réaction circulaire tertiaire : D 29
Réaction d'alarme : X 63
Réactions à l'annonce repères du schéma : X 66
Réadaptation : P 10
Réalisme enfantin : D 32
Réalisme fortuit : D 32
Réalisme intellectuel : D 32
Réalité psychique : P 12
Récepteur : S 48
Rechute : P 22
Réciprocité de l'attachement adulte : D 37
Reconstruction dans la résilience : X 61
Recueil sémiologique : P 20
Référent identitaire : S 46
Référents identitaires : Y 70
Réflexe archaïque : D 28
Refoulement : P 18 · H 41
Refus scolaire anxieux : D 34
Régression : P 19 · D 34 · H 41
Régression topique : P 25
Régulation émotionnelle : D 32
Relation anaclitique : P 18
Relation d'attachement chez l'adulte et réciprocité : D 35
Relation d'objet : P 18
Réminiscence : P 12
Rémission complète : P 22
Rémission partielle : P 22
Renforcement : P 10
Renversement en son contraire : P 19
Repères des première et deuxième topiques : X 65
Répertoire : S 48
Représentation : P 13
Représentation de chose : P 13
Représentation de la maladie ou théorie profane : X 54
Représentation de la maladie ou théorie profane et Étiologie : X 54
Représentation de mot : P 13
Représentations de la maladie : H 38
Réseau de communication : S 50
Réseau social : H 39
Résignation apprise : D 32
Résilience : X 60
Résilience - approche psychologique générale : H 40
Résilience - Boris Cyrulnik : H 40
Résilience - Rutter (1985) : H 40
Résistance : P 20
Responsivité : D 30
Reste diurne : P 12
Retour du refoulé : P 18
Retournement contre soi : P 19
Retrait apathique : H 42
Retrait relationnel : D 31
Rêve : P 25
Réversibilité logique : D 32
Reviviscence traumatique : P 23
Rôle centré sur la tâche : S 46

Index alphabétique

Rôle centré sur les besoins individuels : S 47
Rôle de maintien de la cohésion : S 46
Rôle de satisfaction des besoins individuels : Y 71
Rôle social : S 46
Rôles et leadership : Y 71
Rumination : P 11

S

Santé - définition OMS citée : H 38
Santé comme adaptation : X 52
Santé comme bien instable : X 52
Santé comme bien instable et Santé comme équilibre et Santé comme adaptation : X 52
Santé comme équilibre : X 52
Santé perçue : H 38
Santé relative et continuum santé maladie : X 52
Santé selon l'OMS 1946 : X 52
Santé selon l'OMS 1946 et Santé selon l'OMS 1984 : X 52
Santé selon l'OMS 1984 : X 52
Schéma cognitif : P 11
Schéma corporel : H 42
Schéma corporel et Extéroception et Proprioception et Intéroception et Somatotopie : X 67
Schème : D 28
Schizophrénie : P 23
Seconde théorie freudienne de l'angoisse : P 25
Self : D 31
Sémiologie psychiatrique : P 20
Sensibilité : P 21
Sensibilité relationnelle : D 30
Sentiment de contrôle personnel : X 62
Sentiment de contrôle personnel et Lieu de contrôle ou LOC et Lieu de contrôle interne et Lieu de contrôle externe : X 62
Sentiment d'efficacité personnelle : D 34
Sentiment d'identité chez Allport : Y 69
Sériation : D 33
Sévérité légère, moyenne ou sévère : P 25
Sevrage : P 16
Sexualité infantile : P 16
Sickness : H 38
Sidération lors de l'annonce : X 66
Sidération lors de l'annonce et Colère lors de l'annonce et Marchandage et Dépression dans le schéma du cours et Acceptation : X 66
Sidération psychique : X 56
Signal d'angoisse : P 17
Signe clinique : P 20
Signes objectifs : X 54
Signes subjectifs : X 54
Signes subjectifs et Signes objectifs et Pronostic : X 54
Signifiant / signifié : P 20
Situation étrange : D 31
Sociabilité indiscriminée : D 31
Socialisation : D 33 · S 44
Socialisation primaire : S 44
Socialisation secondaire : S 44
Sociogenèse : P 10
Sociométrie : S 47
Soi : S 45
Soi idéal et Soi reflété : S 45
Soins de support : X 59
Solidarité dans la grille de Bales : Y 73
Somatotopie : X 67
Souffrance : H 39
Souffrance psychique : P 9 · H 39
Souffrance psychique et Douleur morale et Sidération psychique : X 56
Source pulsionnelle : P 13
Sous-extension : D 32
Sous-stade oral primitif : P 16
Sous-stade sadique-oral : P 16
Soutien d'estime : X 58
Soutien émotif ou intégration émotionnelle : X 58
Soutien informatif : X 58
Soutien matériel ou aide tangible : X 58
Soutien social : X 58
Soutien social - sens général : H 39
Soutien social définition de Wallston et al : X 58
Soutien social perçu : H 40
Soutien social reçu : H 39
Soutien social réseau soutien reçu et soutien perçu : X 58
Soutien social selon Wallston et al : X 58
Stade anal : P 16
Stade du miroir : P 26
Stade oral : P 16
Stade phallique : P 17
Statut : Y 70
Statut acquis : Y 70
Statut assigné : Y 70
Statut social : S 46
Stéréotype : S 50
Stéréotype endogroupe et exogroupe : Y 74
Stéréotypie : D 31
Stratégies de coping : P 26
Stress biologique - Selye (1936) : H 40
Stress objectif : X 64
Stress objectif et définition interactionnelle : X 64
Stress perçu : H 40
Stress selon Paulhan et Bourgeois : X 64
Stress selon Selye : X 63
Stress selon Selye et Agent stresseur et Réaction d'alarme et Phase de résistance et Phase d'épuisement : X 63
Stress transactionnel : H 40
Structure de communication : S 50
Structure psychique : P 18
Style d'attachement chez l'adulte : D 36
Style de coping : X 65
Style de coping et Contrôlabilité : X 65
Style de type C : X 62
Style éducatif contractualiste : D 37
Style éducatif maternaliste : D 37
Style éducatif statutaire : D 37
Style expressif : D 29
Style référentiel : D 29
Sublimation : P 19 · H 42
Suggestion dans la grille de Bales : Y 73
Suggestion post-hypnotique : P 12
Sur-extension : D 32
Surmoi : P 14
Symptôme : P 20
Symptôme labile : P 21
Syndrome : P 20
Syntaxe : D 29
Syntonisation avec l'autorité : S 47
Systématisation : P 21
Système affiliatif : D 31
Système exploratoire : D 30
Système famille : Y 73
Système famille et impossibilité de ne pas communiquer : Y 73
Système relationnel : P 11

T

T-group : S 47
Talking cure : P 12
Tension dans la grille de Bales : Y 73
Territoire et espace intime : S 51
Théorie de la séduction : P 12
Théorie de l'esprit : D 33

Index alphabétique

Théorie des humeurs : X 53
Théorie du fantasme : P 12
Théorie profane : H 38
Théories sexuelles infantiles : P 17
Thérapies cognitivo-comportementales · TCC : P 11
Ton de la voix : Y 72
Tonus : D 28
Tour de rôle : D 30
Tracas quotidiens : H 39
Trace mnésique : P 13
Traits pathogènes : X 62
Traits salutogènes : X 62
Traits salutogènes et Optimisme : X 62
Transcodage : P 25
Transfert : P 20
Transfert positif / négatif : P 20
Transitivité : D 33
Traumatisme psychique : P 14
Triangulation : P 17
Trouble du langage oral : D 32
Trouble neurocognitif majeur : D 35
Type de personnalité A : H 40
Type de personnalité C : H 40

V

Vaginisme : P 24
Valeur sociale : S 46
Valeurs : Y 70
Validité externe : P 21
Validité interne / cohérence : P 21
Visage et mimique : Y 72
Voie lexicale / orthographique : D 32
Voie phonologique / assemblage : D 32
Vulnérabilité : H 40
Vulnérabilité environnementale : X 60
Vulnérabilité et Vulnérabilité personnelle et Vulnérabilité environnementale : X 60
Vulnérabilité personnelle : X 60

Z

Zone érogène : P 13

Repères de sources et portée de la fiche

Les définitions P, D, H et S sont conservées à partir des quatre fiches de cours préparées. La mention « fiche p. » indique la page de la fiche d'origine. Les passages X et Y citent les pages des supports officiels de santé et de sociale. La partie développement a été confrontée au support officiel de N. Khatir, Psychologie du développement, 2026, 35 pages. Les précisions D195-D202 sont confirmées et D203-D222 ajoutées. Les extraits littéraux indiquent la page du support. Les autres définitions sont des formulations de révision ; les références aux pages de la fiche antérieure restent utiles pour leur provenance.

Les noms d'auteurs et les dates sont repris seulement lorsqu'une attribution du cours a été vérifiée. Un auteur cité pour une théorie ou une étude n'est pas automatiquement l'auteur de toutes les définitions du chapitre. Si le support n'attribue pas une formulation, écrire « selon le cours » plutôt qu'inventer une référence.

Psychopathologie : fiche revue, 41 pages

Développement : fiche antérieure, 34 pages (provenance des premiers renvois)

Santé : fiche de 54 pages, lexique de 79 définitions

Sociale : fiche de 33 pages, lexique de 137 définitions

Cadrage du travail : liste « Concepts - Psychologie clinique et sociale », 3 pages ; présentation de validation du 4 novembre 2026, en particulier p. 3-5 et 7-15. La liste ne constitue pas une limite au contenu des quatre cours.

Les modèles psychanalytiques, les anciennes catégories diagnostiques et les profils historiques sont présentés dans leur contexte de cours. Cette fiche sert au repérage et à l'analyse argumentée d'un texte ; elle ne permet pas de poser un diagnostic à partir d'une citation.

Index alphabétique